

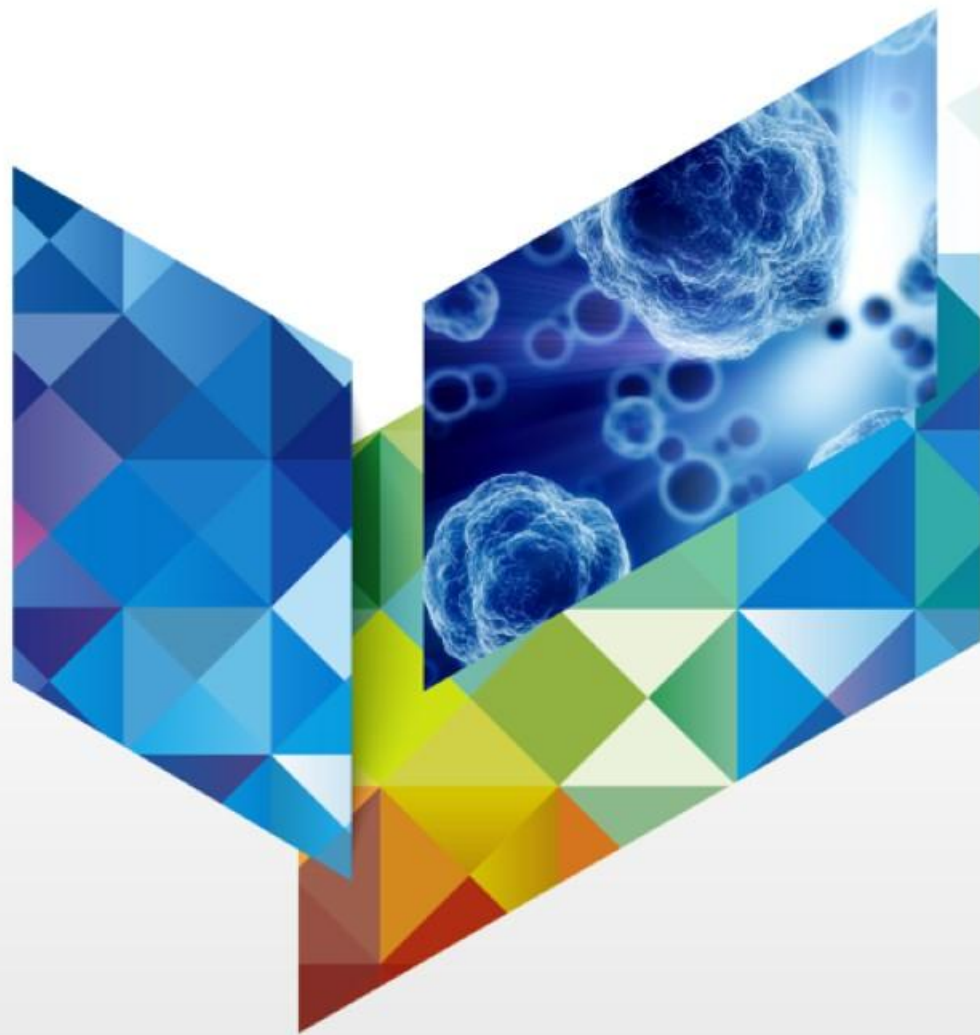


2024 BARCELONA

ESMO

2024 ESMO 卵巢癌研究进展

肿瘤中央医学事务部-医学科学二部



声 明

- 本材料旨在促进医学信息的沟通和交流，仅供医疗卫生专业人士参考。
- 内容可能含有未在中国批准的药品或临床适应症。处方请参考国家药品监督管理局批准的药品说明书。
- 本幻灯片除明确注明的出处以外，所提供的信息和材料的相关知识产权属于演讲者本人。版权所有，未经许可不得使用。
- 在引用本材料进行学术交流时，请确保所传递信息的科学性、真实性和时效性。如有疑问，请联系肿瘤中央医学事务部。



2024 BARCELONA

ESMO

目录

CONTENTS

- 01 新诊断卵巢癌一线维持治疗
- 02 铂敏感复发性卵巢癌治疗/维持治疗
- 03 铂耐药卵巢癌治疗

CONTENTS 01

新诊断卵巢癌一线维持治疗

- LBA29: PRIMA/ENGOT-OV26/GOG3012: 尼拉帕利用于新诊断晚期卵巢癌一线维持治疗的最終总生存期
- LBA30: ATHENA-COMBO (GOG-3020/ENGOT-ov45): 一项对比卢卡帕利联合纳武利尤单抗对比卢卡帕利单药用于新诊断卵巢癌维持治疗的III期随机研究

02 铂敏感复发性卵巢癌治疗/维持治疗

- LBA33: ICON9研究: 评估奥拉帕利联合西地尼布对比奥拉帕利单药用于铂类化疗缓解的铂敏感复发性卵巢癌维持治疗疗效的国际III期随机对照研究
- 718 MO: II期PICCOLO研究: 索米妥昔单抗 (MIRV) 用于治疗铂敏感复发性卵巢癌且叶酸受体 α (FR α)高表达患者

03 铂耐药卵巢癌治疗

- 746 P: III期MIRASOL研究: 索米妥昔单抗 (MIRV) vs. 研究者选择的化疗用于铂耐药卵巢癌伴叶酸受体 α (FR α)高表达患者的生存结果更新
- 766 P: 氟唑帕利联合阿帕替尼对比氟唑帕利单药治疗复发性卵巢癌 (OC) 的II期研究
- 717 MO: SHR-A1921治疗铂耐药卵巢癌 (PROC) 的首次人体 (FIH) I期研究数据
- 714 MO: II期TROPION-PanTumor03研究: Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) 在子宫内膜癌 (EC) 或卵巢癌 (OC) 患者中的应用
- 715 MO: 芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)在经治晚期子宫内膜癌(EC)和卵巢癌(OC)患者中的安全性和有效性: 一项II期研究

PRIMA/ENGOT-OV26/GOG3012研究：尼拉帕利用于新 诊断晚期卵巢癌一线维持治疗的最终总生存期

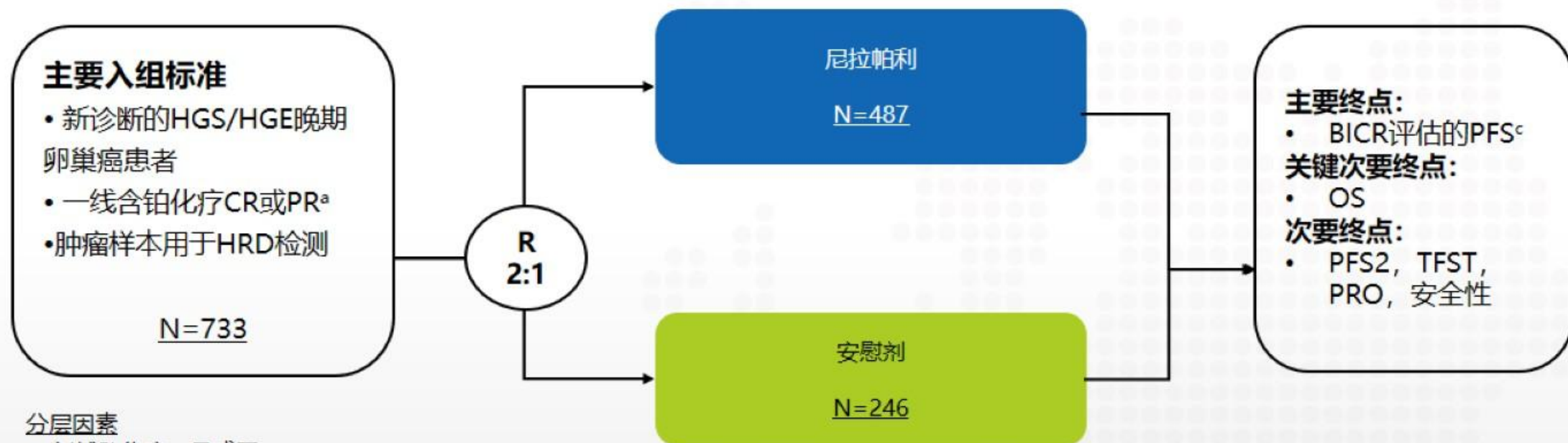
Final overall survival (OS) in patients (pts) with newly diagnosed advanced ovarian cancer (aOC) treated with niraparib (nir) first-line (1L) maintenance: results from PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012

通讯作者：Antonio González-Martin
研究机构：Universidad de Navarra

研究设计



III期PRIMA研究纳入疾病复发风险高的新诊断晚期卵巢癌



分层因素

- 新辅助化疗：是或否
- 一线含铂化疗最佳缓解：CR或PR
- 肿瘤HRD状态：HRd 或 HRp/HRnd

患者每日用药一次^b，用药36个月或直至疾病进展

PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012研究 (NCT02655016)

^a患者的CA-125必须在正常范围或者在一线治疗期间，CA-125下降90%并至少稳定7天。基线时，全人群中7.1%的患者的CA-125高于正常值上限。^b研究开始时，所有患者接受每日一次，每次300mg的固定起始剂量。之后，方案更新为使用个性化起始剂量，根据基线的体重/血小板计数进行调整。^c主要终点BICR评估的PFS通过分层检验，首先在HRd患者中检验，之后在全人群检验。BICR，盲态独立评审委员会；CA-125，肿瘤抗原125；CR，完全缓解；HGE，高级别子宫内膜样；HGS，高级别浆液性；PFS，无进展生存期；PR，部分缓解；PRO，患者报告结局；TFST，至首次后续治疗的时间。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016>
2. Antonio González-Martin, et al. 2024 ESMO LBA29.

- 全人群~60%成熟度时进行 (≈ 440 例死亡)。
- 分层检验：全人群然后HRd人群
- 如果全人群的真实风险比 ≤ 0.75 ，80%把握度检测出统计学差异。

PRIMA入组人群关键风险特征



□ 疾病分期

- 35.1% 患者诊断为IV期

□ 初始治疗

- 66.7% 患者接受新辅助化疗
- 30.6% 患者接受1线含铂化疗后达到部分缓解

□ 残留病灶

- >99% 患者诊断为III期，且在初次细胞减瘤术后有残留病灶
- 47.5% 患者术后有肉眼可见残留病灶或未进行减瘤手术

□ 肿瘤HRD/BRCA状态

- 50.9% HRd
- 30.4% HRd/*BRCAm*
- 34.0% HRp

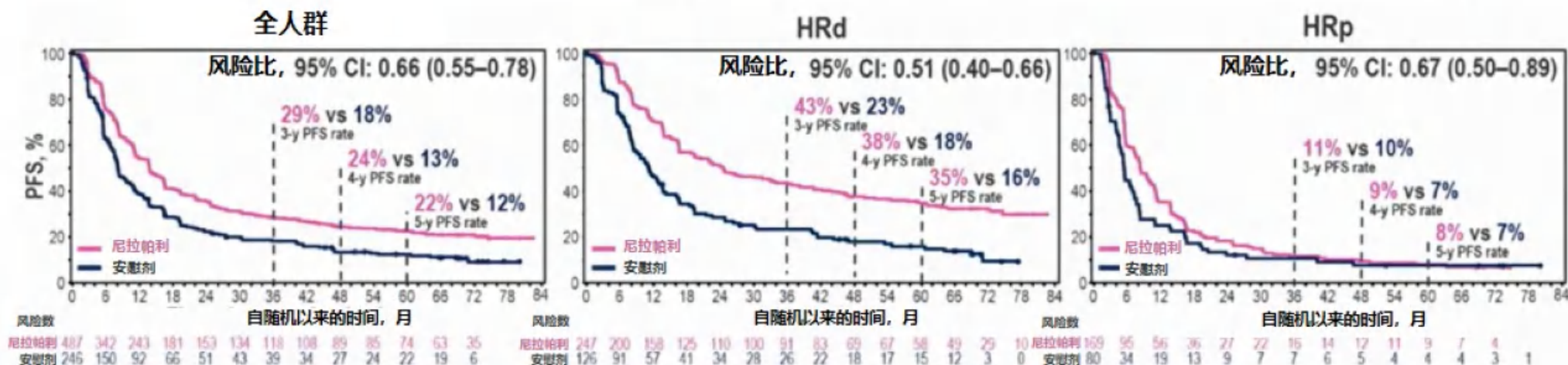
HRD, 同源重组修复缺陷状态; HRd, 同源重组修复缺陷; HRnd, 同源重组修复状态未确定; HRp, 同源重组修复正常

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016>
2. Antonio González-Martin, et al. 2024 ESMO LBA29.

更新后的长期PFS（临时分析，研究者评估）^{a,b}



通过对全人群和HRd人群的长期随访，尼拉帕利的PFS持续获益。



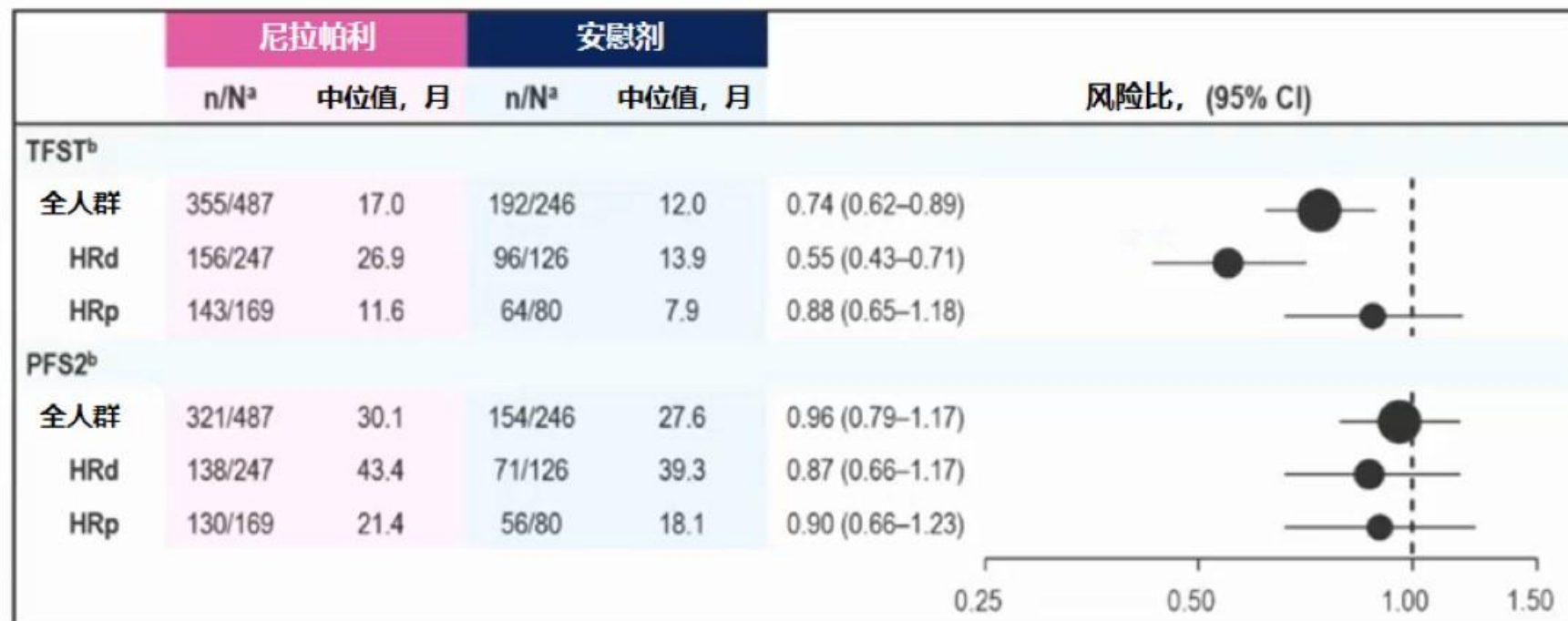
- 数据截止日期为2024年4月8日；中位随访时间6.2年。
- 存活5年的HRd人群中，接受尼拉帕利的患者无进展生存率（35%）约是接受安慰剂患者（16%）的2倍。
- 延缓疾病进展对于维持健康相关的生活质量至关重要。

^a在研究开始，患者每12周（3周期）进行一次疾病进展评估（CT/MRI）；在2019年8月，方案修订为：对于治疗超过2年的患者，每24周（6个周期）进行一次疾病进展评估。

^b使用分层Cox比例风险模型计算PFS风险比和95%置信区间。所有的分析中，分层因素使用随机分层因素。CT，计算机断层扫描；HRd，同源重组修复缺陷；HRp，同源重组修复正常；MRI，磁共振成像；PFS，无进展生存期。PFS rate，无进展生存率；y，年。

次要临床终点

TFST结果与PFS分析结果一致；治疗组间PFS2无差异。

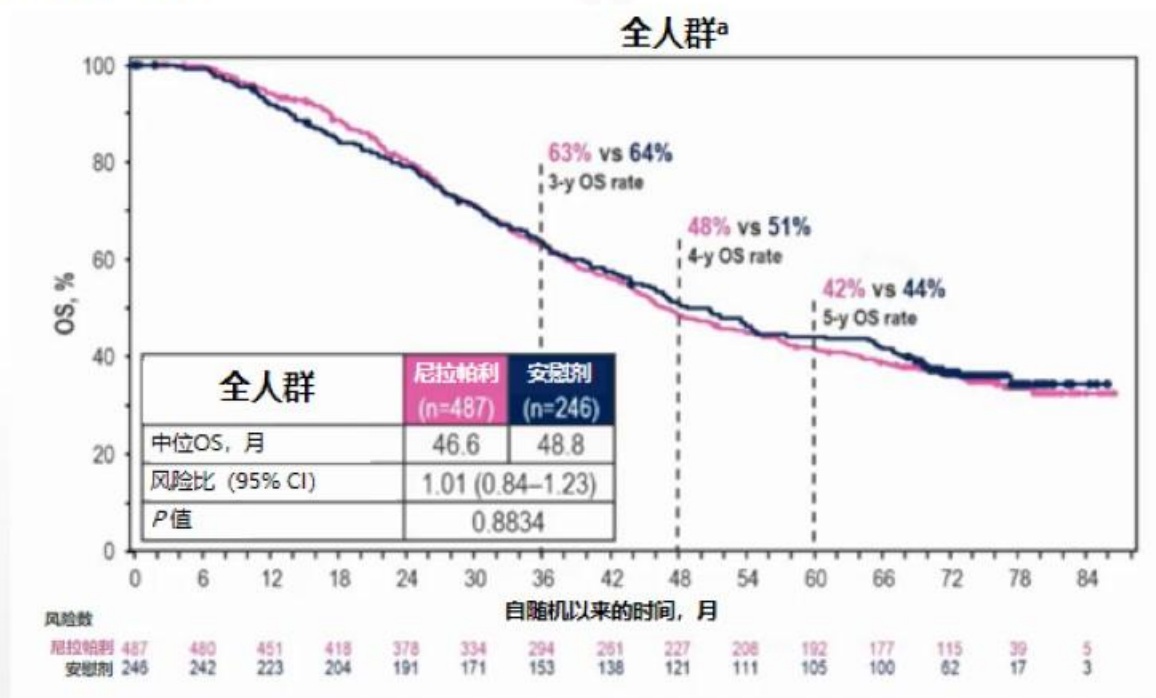


每个点的大小与亚组样本大小成正比。^a患者事件数/人群的患者总数。^b全人群和HRd人群的风险比和95%置信区间使用带有随机分层因素的分层Cox比例风险模型计算；HRp人群的风险比和95%置信区间计算采用非分层Cox比例风险模型。
HRd, 同源重组修复缺陷；HRp, 同源重组修复正常；PFS, 无进展生存期；PFS2, 无进展生存期2；TFST, 至首次后续治疗的时间。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016>
2. Antonio González-Martin, et al. 2024 ESMO LBA29.

最终OS (全人群62.5%成熟度)

尼拉帕利和安慰剂组OS无差异,

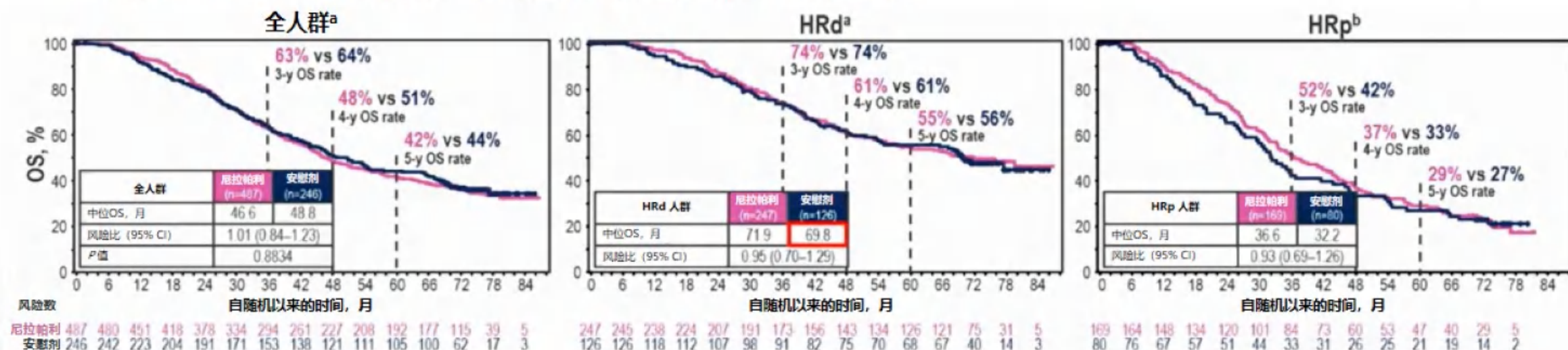


全人群结果计算采用分层log-rank检验。风险比和95%置信区间使用带有随机分层因素的分层Cox比例风险模型计算。OS, 总生存期; OS rate, 总生存率; y, 年。

- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016>
- Antonio González-Martin, et al. 2024 ESMO LBA29.

最终OS (全人群62.5%成熟度)

全人群、HRd和HRp人群中，尼拉帕利和安慰剂组的OS均无差异。



□ 所有预先指定的生物标志物定义的亚组OS结果与全人群一致^c。

□ 高风险晚期卵巢癌的长期疗效评估可能因多因素而复杂化。

- 患者人群
- 延长进展后生存时间
- 后续治疗

^a全人群和HRd人群的风险比和95%置信区间采用带有随机分层因素的分层Cox比例风险模型计算。^b采用非分层Cox比例风险模型计算HRp人群的风险比和95%置信区间。^cHRnd人群 (非分层的) OS结果风险比 (95% CI), 1.39 (0.88-2.19)。HRd, 同源重组修复缺陷; HRnd, 同源重组修复状态未确定; HRp, 同源重组修复正常; OS, 总生存期; OS rate, 总生存率; y, 年。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016>
2. Antonio González-Martin, et al. 2024 ESMO LBA29.

各治疗组后续抗肿瘤治疗

除PAPR抑制剂外，各治疗组后续治疗基本一致。

任意后续抗肿瘤治疗，% ^a	尼拉帕利		安慰剂	
	全人群 (n=487)	HRd (n=247)	全人群 (n=246)	HRd (n=126)
总计	66.7	57.1	73.2	74.6
随访期间后续治疗线数				
1	19.3	17.8	24.4	31.0
2	18.5	15.0	18.7	14.3
3	11.9	9.7	13.8	15.9
≥4	17.0	14.6	15.0	12.7
手术	15.8	16.6	15.0	15.1
放疗	8.4	8.1	7.7	8.7
铂类化疗 ^b	58.5	51.0	62.2	64.3
贝伐珠单抗 ^c	38.8	31.2	35.8	27.8
紫杉醇 ^d	41.7	33.6	34.1	33.3
多柔比星 ^e	45.8	36.8	52.8	47.6
吉西他滨 ^f	35.3	33.2	36.2	31.7
PAPR抑制剂	11.7	15.8	37.8	48.4
尼拉帕利 ^g	3.5	5.3	14.2	15.1
奥拉帕利	7.0	9.7	21.5	30.2
卢卡帕利	1.4	1.2	3.3	4.0
他拉唑帕利	0	0	0.4	0.8

□ 根据每个人群患者总数计算后续治疗的百分比。

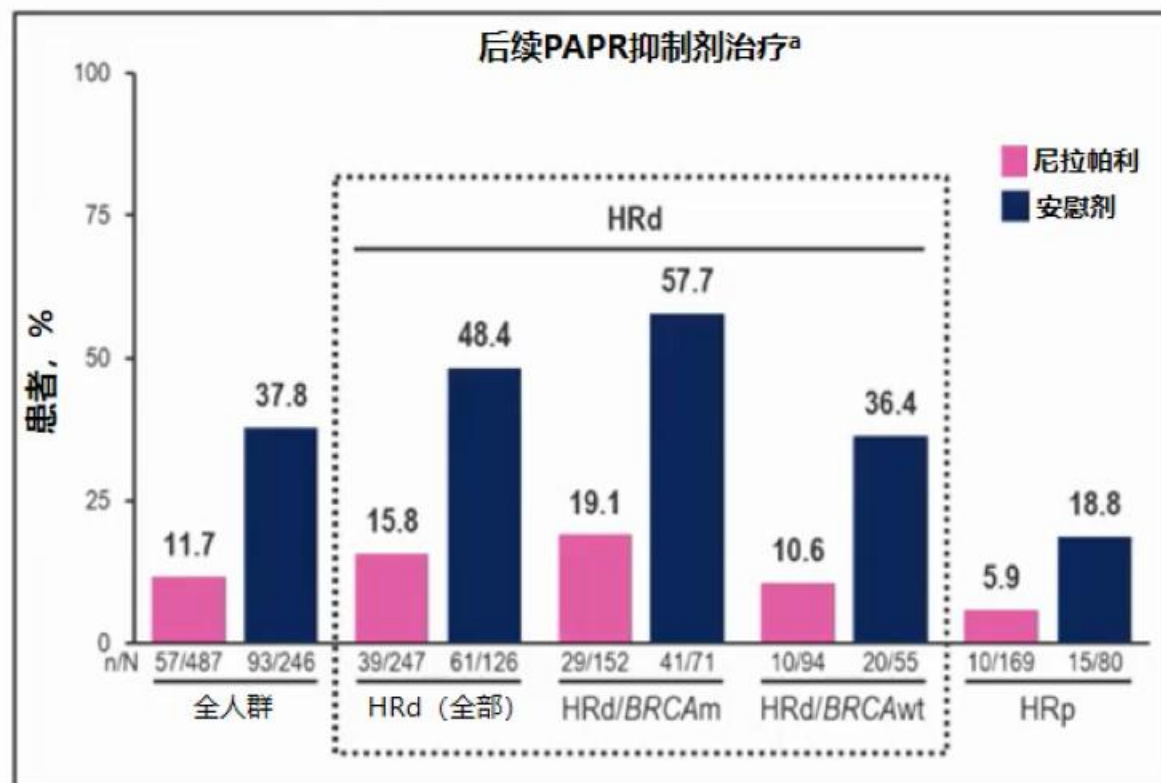
□ 安慰剂组出现疾病进展的患者比例高于尼拉帕利组（PFS影响）。

□ 在经历疾病进展的患者中，PAPR抑制剂导致各治疗组的后续治疗差异最显著。

^a根据每组患者总数计算百分比，而不是疾病进展的患者数。^b包括卡铂、顺铂和奥沙利铂。^c包括贝伐珠单抗和贝伐珠单抗类似物。^d包括多烯紫杉醇和紫杉醇。^e包括多柔比星、盐酸多柔比星、多柔比星脂质体、氢氧化物多柔比星脂质体、聚乙二醇脂质体多柔比星、盐酸聚乙二醇脂质体多柔比星。^f包括吉西他滨和盐酸吉西他滨。^g包括尼拉帕利和甲磺酸尼拉帕利。
HRd，同源重组修复缺陷；PARP，聚（ADP-核糖）聚合酶；PFS，无进展生存期

后续PARP抑制剂治疗

跨人群使用PARP抑制剂，安慰剂组是尼拉帕利组的三倍。



□ 后续PARP抑制剂使用

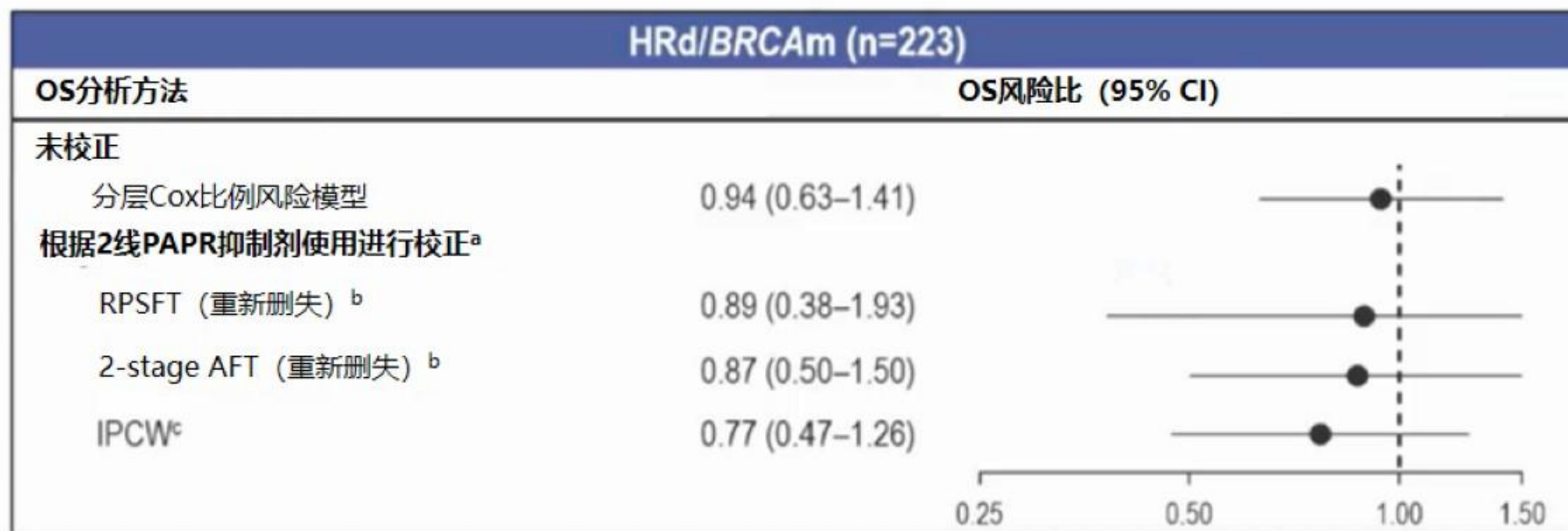
- 大多用于HRd人群，在HRd/*BRCA* 突变人群中使用最多。
- 大部分患者在二线开始使用。

任意后续PARP抑制剂治疗线数, % ^a	全人群		HRd	
	尼拉帕利 (n=487)	安慰剂 (n=246)	尼拉帕利 (n=247)	安慰剂 (n=126)
任意治疗线数	11.7	37.8	15.8	48.4
2线	8.2	30.5	13.0	37.3
3线+	3.5	7.3	2.8	11.1

^a根据每组患者总数计算百分比，而不是疾病进展的患者数量。*BRCAm*, *BRCA*突变; *BRCAwt*, *BRCA*野生型; HRd, 同源重组修复缺陷; HRp, 同源重组修复正常; PARP, 聚 (ADP-核糖) 聚合酶。

HRd/*BRC*Am后续PARP抑制剂使用和OS

OS分析根据2线PARP抑制剂的使用进行校正，表明后续治疗的影响。



□ 校正分析结果应谨慎解读，因为存在以下限制：进展后数据收集的局限性、模型拟合和协变量选择的复杂性，以及每个模型的假设可能并未全部得到验证。

^a校正分析是预先设定的，在接受 ≥ 1 个研究治疗剂量的患者中进行分析。^b校正后的风险比使用带有随机分层因素的Cox比例风险模型评估，95% CI风险比采用有替换的分层自举抽样法计算。^c校正后的风险比使用加权Cox比例风险模型估计，95% CI风险比计算采用稳健方差估计。2-stage AFT，2阶段加速失效时间模型；*BRC*Am，*BRC*A突变；HRd，同源重组修复缺陷；IPCW，逆概率删失加权模型；OS，总生存期；PARP，聚（ADP-核糖）聚合酶；RPSFT，保留失效时间模型。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016>
2. Antonio González-Martin, et al. 2024 ESMO LBA29.

长期安全性更新

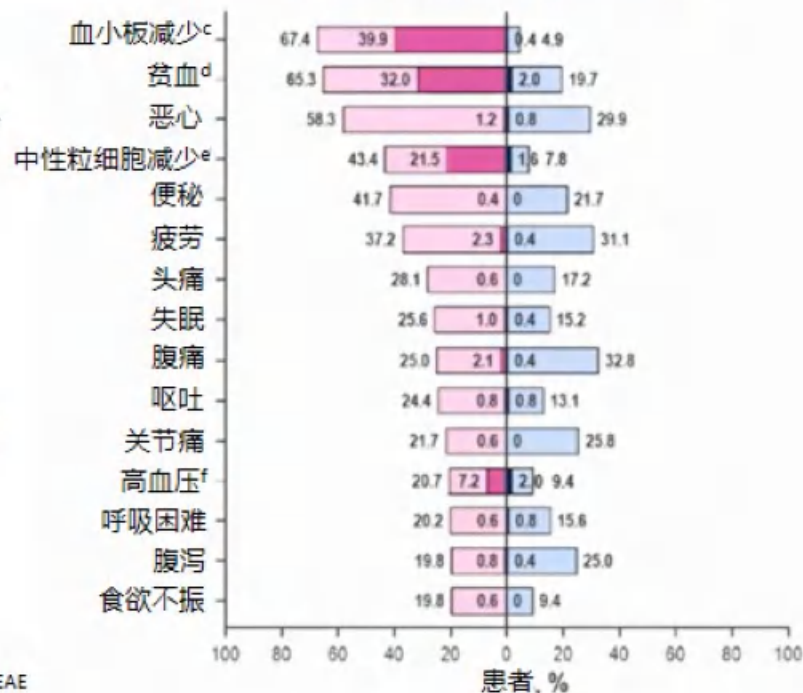
经过7年随访，未观察到新的安全性信号。

- 尼拉帕利组和安慰剂组的中位治疗暴露时间分别为11.3和8.3个月。
- 尼拉帕利组最常见的 ≥ 3 级TEAEs为血小板减少、贫血和中性粒细胞减少。
- 与FSD相比，ISD血液学毒性发生率更低^a。
- MDS/AML率：尼拉帕利，2.3%；安慰剂：1.6%。
- 两组导致死亡的治疗相关不良事件无显著差异，包括跨亚组。

➢ 两组患者的主要死亡原因均为疾病进展。

■ 尼拉帕利组任意等级TEAE
 ■ 尼拉帕利组 ≥ 3 级 TEAE
 ■ 安慰剂组任意等级TEAE
 ■ 安慰剂组 ≥ 3 级 TEAE

$\geq 20\%$ 患者报道的TEAEs^b



^a全球批准的尼拉帕利一线维持治疗起始剂量ISD，剂量根据体重和血小板计数个性化调整。^b在随机接受 ≥ 1 个研究药物剂量的患者中 (N=728)，使用尼拉帕利治疗（所有尼拉帕利，尼拉帕利FSD，尼拉帕利ISD）， $\geq 20\%$ 患者发生的最常见TEAEs。^c包括血小板减少和血小板计数减少。^d包括贫血、血红蛋白降低、红细胞减少、血细胞减少、巨幼细胞贫血。^e包括中性粒细胞减少、中性粒细胞计数减少、轻度中性粒细胞减少和中性粒细胞减少性败血症。^f包括高血压、血压升高和血压波动。AE，不良事件；AML，急性髓系白血病；FSD，固定起始剂量；ISD，个性化起始剂量；MDS，骨髓增生异常综合征；TEAEs，治疗期间出现的不良事件。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02655016>
2. Antonio González-Martin, et al. 2024 ESMO LBA29.

研究结论

中位随访时间6.2年。

- PRIMA研究纳入了高复发风险的晚期高级别浆液性/子宫内膜样卵巢癌患者。
- 在全人群和HRd人群中，随着随访时间延长，观察到尼拉帕利持续的PFS获益。
 - 在HRd人群中存活5年的患者，接受尼拉帕利的患者PFS率约是接受安慰剂患者的2倍（35% vs 16%）。
 - 保持无进展对维持健康相关的生活质量至关重要¹。
- 全人群和HRD状态亚组中，尼拉帕利组和安慰剂组的OS无差异。
 - 在各人群中，安慰剂组的后续PARP抑制剂使用率比尼拉帕利组高3倍（HRd：48.4% vs 15.8%）。
- 长期安全性与尼拉帕利已知的安全性特征一致。
- 长期数据支持尼拉帕利作为一线维持治疗获益，无论HRD状态如何。

HRD，同源重组修复缺陷状态；HRd，同源重组修复缺陷；OS，总生存期；PARP，聚（ADP-核糖）聚合酶；PFS，无进展生存期。

1. Chase DM, et al. Gynecol Oncol. 2022; 166(3): 494-502.

ATHENA-COMBO (GOG-3020/ENGOT-ov45): 一项对比卢卡帕利联合纳武利尤单抗对比卢卡帕利单药用于新诊断卵巢癌维持治疗的III期随机研究

ATHENA-COMBO (GOG-3020/ENGOT-ov45), A Phase 3, randomized trial comparing rucaparib + nivolumab combination therapy vs rucaparib monotherapy as maintenance treatment in patients with newly diagnosed ovarian cancer

通讯作者: Bradley J. Monk

研究机构: University of Arizona College of Medicine

研究背景



- 卢卡帕利和其他PARP抑制剂用于新诊断晚期卵巢癌一线维持治疗可改善PFS¹⁻⁵。
- ATHENA (NCT03522246) 研究是一项国际、随机、安慰剂对照、双盲III期临床研究，包括ATHENA-MONO和ATHENA-COMBO，评估了卢卡帕利联合或不联合纳武利尤单抗用于广泛人群一线维持治疗疗效。
- ATHENA-MONO的初次分析表明，在ITT人群中，卢卡帕利单药对比安慰剂PFS显著获益。
 - 卢卡帕利对比安慰剂，中位PFS分别为20.2个月和9.2个月，HR 0.52 (95% CI, 0.40-0.68)⁵。

CI，置信区间；HR，风险比；ITT，意向治疗；PARP，聚（adp-核糖）聚合酶；PFS，无进展生存期。

1. Moore et al. N Engl J Med. 2018; 379: 2495-505. 2. González-Martin et al. N Engl J Med. 2019; 381: 2391-402. 3. Ray-Coquard et al. N Engl J Med. 2019; 381: 2416-28. 4. Banerjee et al. Lancet Oncol. 2021; 22: 1721-21. 5. Monk et al. J Clin Oncol. 2022; 40: 3952-64.

研究设计



国际、随机、安慰剂对照、双盲III期临床研究

主要入组标准

- 新诊断的III-IV期晚期高级别上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌
 - 完成一线铂类双药化疗和手术，且达到研究者评估的CR或PR；接受细胞减瘤术（初次或间歇性；允许完全切除）
 - ECOG PS 0或1
 - 既往未经过卵巢癌维持治疗
- N≈1000

分层因素

- 肿瘤HRD状态^a
- 化疗后疾病状态
- 手术时机

^a中心评估，由FoundationOne CDx下一代测序检测BRCA突变、BRCA野生型/LOH高 [LOH≥16%]、BRCA野生型/LOH低 [LOH<16%]、BRCA野生型/LOH不确定。

^b治疗24个月或直至影像学进展、不可耐受的毒性或其他导致研究停止的原因。IV安慰剂从第二周期的第一天开始，治疗上限定义为IV安慰剂开始使用后24个月；28天为一个用药周期。

BID，每天两次；CR，完全缓解；ECOG PS，东部肿瘤协作组功能状态评分；HRD，同源重组修复缺陷；ITT，意向治疗；IV，静脉注射；LOH，杂合性缺失；PFS，无进展生存期；PO，口服；PR，部分缓解

随机分组 4:4:1:1

A组：卢卡帕利 (600 mg, BID, PO)
+ 纳武利尤单抗 (480 mg, IV)
N≈400

B组：卢卡帕利 (600 mg, BID, PO)
+ 安慰剂 (IV)
N≈400

C组：安慰剂 (PO)
+ 纳武利尤单抗 (480 mg, IV)
N≈100

D组：安慰剂 (PO)
+ 安慰剂 (IV)
N≈100

提前4周服用卢卡帕利，共治疗24个月^b；研究药物可以单独停用

研究分析

A组：卢卡帕利 (600 mg, BID, PO)
+ 纳武利尤单抗 (480 mg, IV)
N≈400

B组：卢卡帕利 (600 mg, BID, PO)
+ 安慰剂 (IV)
N≈400

C组：安慰剂 (PO)
+ 纳武利尤单抗 (480 mg, IV)
N≈100

D组：安慰剂 (PO)
+ 安慰剂 (IV)
N≈100

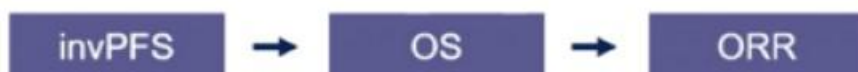
主要终点：研究者评估的ITT人群PFS

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

研究里程碑和统计假设



- ITT人群层次逐步下降分析:



- 主要终点的样本量假设:

HR	中位 PFS (卢卡帕利+纳武利尤单抗 vs 卢卡帕利+安慰剂)
0.725	28个月 vs 20个月

- 统计假设:

$$H_0: HR (\text{卢卡帕利} + \text{纳武利尤单抗} / \text{卢卡帕利} + \text{安慰剂}) \geq 1$$
$$H_a: HR (\text{卢卡帕利} + \text{纳武利尤单抗} / \text{卢卡帕利} + \text{安慰剂}) < 1$$

- 在单侧显著性水平为0.0125时把握度90%

HR, 风险比; inv-PFS, 研究者评估的无进展生存期; ITT, 意向治疗; ORR, 客观缓解率; OS, 总生存期; PFS: 无进展生存期。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

基线特征1



ITT人群基线特征	卢卡帕利+纳武利尤单抗 (N=436)	卢卡帕利+安慰剂 (N=427)
岁, 年, 中位 (范围)	61 (25-83)	61 (30-83)
种族		
白人	325 (74.5)	328 (76.8)
亚洲人	81 (18.6)	80 (18.7)
黑人或非裔美国人	8 (1.8)	5 (1.2)
其他 ^a	22 (5.0)	14 (3.3)
ECOG PS, ^b n (%)		
0	298 (68.3)	295 (69.1)
1	138 (31.7)	131 (30.7)
FIGO分期, n (%)		
III	320 (73.4)	323 (75.6)
IV	116 (26.6)	104 (24.4)
肿瘤类型, n (%)		
上皮性卵巢癌	340 (78.0)	336 (78.7)
输卵管癌	63 (14.4)	50 (11.7)
原发性腹膜癌	33 (7.6)	41 (9.6)
手术时机, n (%)		
初次减瘤术	215 (49.3)	209 (48.9)
间歇性减瘤术	221 (50.7)	218 (51.1)

数据截止日期: 2024年5月17日。
a包括 (尼拉帕利+纳武利尤单抗 vs 卢卡帕利+安慰剂): 美国印第安人或阿拉斯加土著人 (2 [0.5%] vs 1 [0.2%]), 夏威夷原住民或其他太平洋岛民 (1 [0.2%] vs 3 [0.7%]), 多人种 (0 vs 2[0.5%]), 以及未报告 (19 [4.4%] vs 8 [1.9%])。b一例卢卡帕利+安慰剂组患者ECOG PS为2。ECOG PS, 东部肿瘤协作组功能状态评分; FIGO, 国际妇产科联合会; ITT, 意向治疗。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

基线特征2



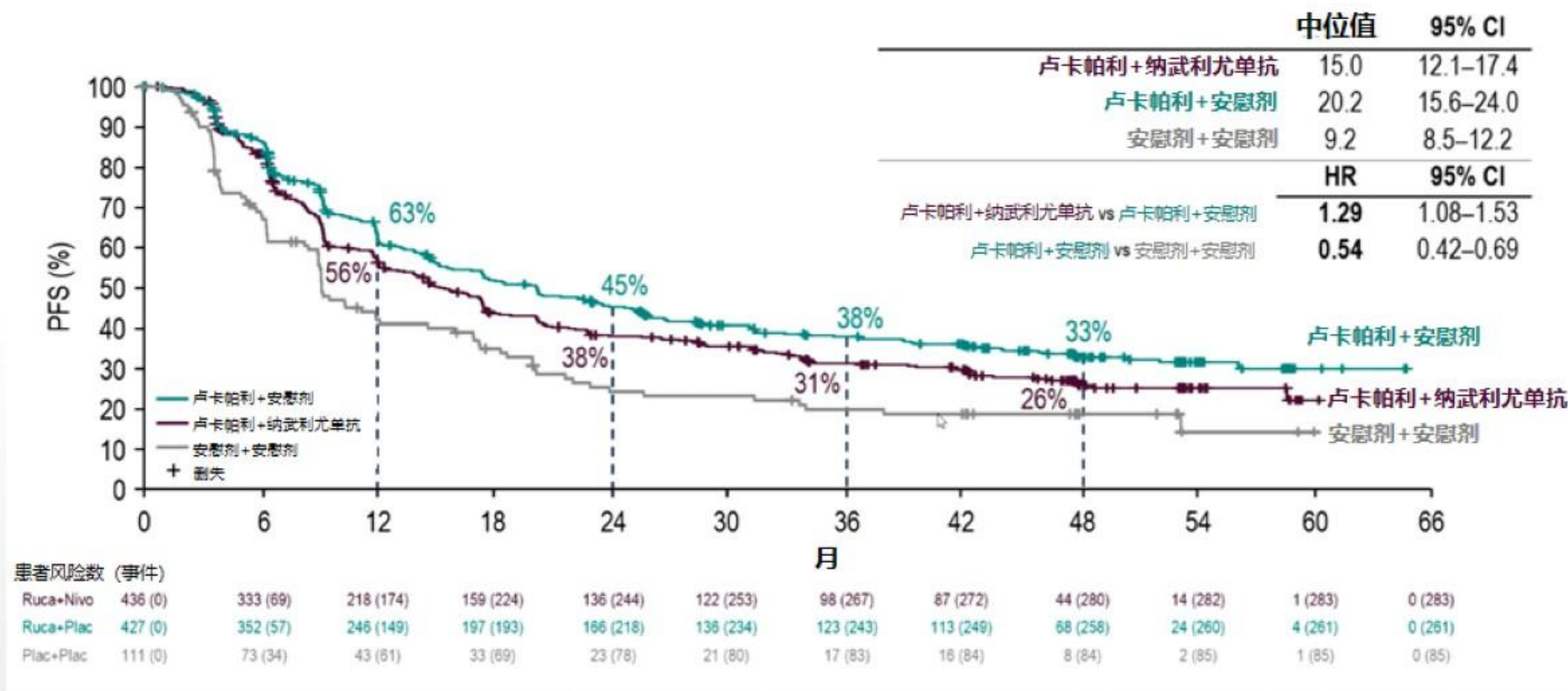
ITT人群基线特征, n (%)	卢卡帕利+纳武利尤单抗 (N=436)	卢卡帕利+安慰剂 (N=427)
化疗后疾病状态		
无残留病灶	327 (75.0)	322 (75.4)
有残留病灶	109 (25.0)	105 (24.6)
放射化疗最佳反应 ^a		
CR	71 (16.3)	73 (17.1)
PR	78 (17.9)	76 (17.8)
手术后无病灶	244 (56.0)	225 (52.7)
HRD状态		
BRCA ^{mut}	94 (21.6)	91 (21.3)
BRCA ^{wt} /LOH ^{high}	99 (22.7)	94 (22.0)
BRCA ^{wt} /LOH ^{low}	188 (43.1)	189 (44.3)
BRCA ^{wt} /LOH ^{indeterminate}	55 (12.6)	53 (12.4)
PD-L1表达水平 ^b		
≥5%	69 (15.8)	72 (16.9)
≥1%	199 (45.6)	197 (46.1)
基线有可测量病灶	39 (8.9)	41 (9.6)

数据截止日期：2024年5月17日。

a其他/无法评估的：卢卡帕利+纳武利尤单抗组，43 (9.9%)；卢卡帕利+安慰剂组，53 (12.4%)。b未报告：卢卡帕利+纳武利尤单抗组，32 (7.3%)；卢卡帕利+安慰剂组，33 (7.7%)。
BRCA, *BRCA1* 或 *BRCA2*；CR, 完全缓解；high, 高；HRD, 同源重组修复缺陷；indeterminate, 不确定；low, 低；ITT, 意向治疗；LOH, 杂合性缺失；mut, 突变；PD-L1, 程序化死亡配体1；PR, 部分缓解；wt, 野生型。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ATHENA-CONBO: 研究者评估PFS (ITT)



数据截止日期: 2024年5月17日。

CI, 置信区间; HR, 风险比; ITT, 意向治疗; Nivo, 纳武利尤单抗; PFS, 无进展生存期; Plac, 安慰剂; Ruca, 卢卡帕利。

- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
- Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ATHENA-COMBO有效人群分布 (ITT)



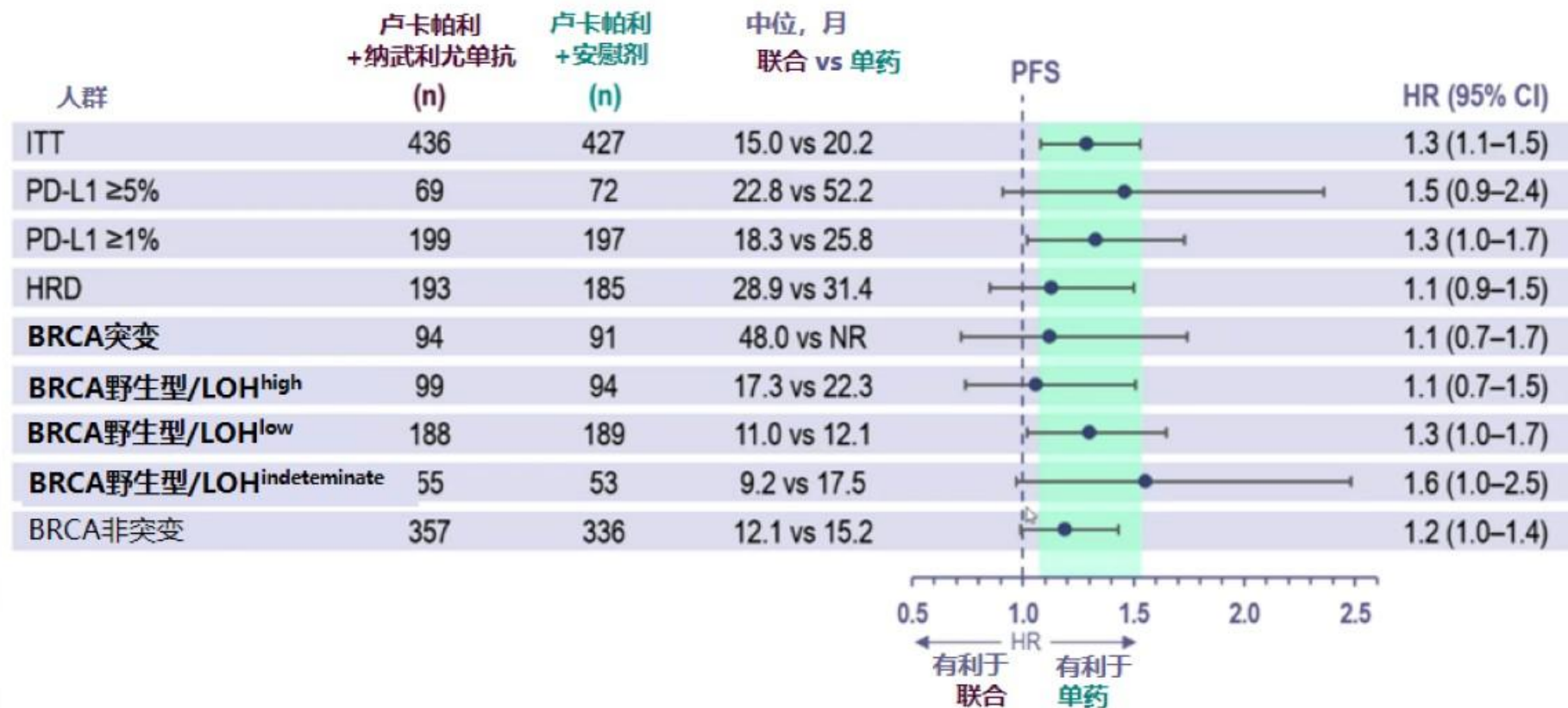
	卢卡帕利+纳武利尤单抗 (N=436)	卢卡帕利+安慰剂 (N=427)
接受治疗, n (%)		
是	410 (94.0)	425 (99.5)
否 ^a	26 (6.0)	2 (0.5)
研究终止的原因, n (%) ^b		
疾病进展	180 (43.9)	182 (42.8)
不良事件	86 (21.0)	54 (12.7)
按方案完成用药	103 (25.1)	147 (34.6)
其他 ^c	41 (10.0)	42 (9.9)

数据截止日期：2024年5月17日。

a在未接受卢卡帕利+纳武利尤单抗联合治疗的患者中，3例患者从未接受过卢卡帕利或纳武利尤单抗，23例在第一周期接受过卢卡帕利，但从未接受过纳武利尤单抗。这23例患者停止服用卢卡帕利和未接受纳武利尤单抗的原因是：疾病进展（3.8%）、不良事件（50%）和其他（34.6%）。b停药原因是基于最后一种药物（卢卡帕利或纳武利尤单抗）的停药原因。在卢卡帕利+纳武利尤单抗组中，研究停药末次用药使用卢卡帕利（91%），纳武利尤单抗（8%），或者两种药物同时停药（2%）；在卢卡帕利+安慰剂组中全部是卢卡帕利（100%）。c原因包括临床进展、医生判定、COVID-19、撤回知情同意和其他指定的原因。ITT，意向治疗。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ATHENA-COMBO探索性亚组研究者评估的PFS



数据截止日期: 2024年5月17日。

粗体标注的人群是分层因素。

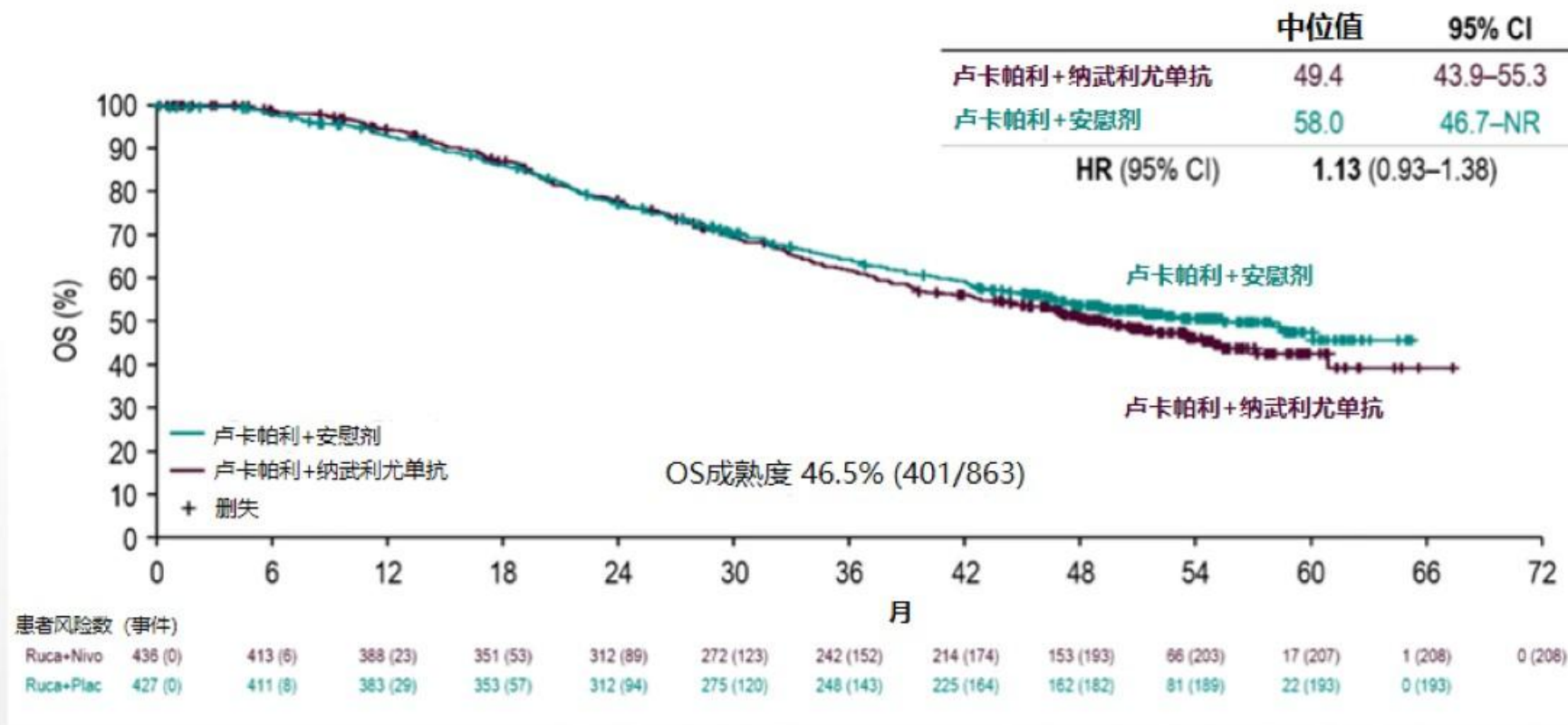
BRCA野生型/LOH high (LOH 阈值, ≥16%), BRCA野生型/LOH low (LOH 阈值, <16%)。

BRCA, *BRCA1* 或 *BRCA2*; CI, 置信区间; high, 高; HR, 风险比; HRD, 同源重组修复缺陷; indeterminate, 不确定; low, 低; ITT, 意向治疗; LOH, 杂合性缺失; HR, 未达到; PD-L1, 程序化死亡配体1; PFS, 无进展生存期。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>

2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ATHENA-COMBO: 中期OS (ITT)

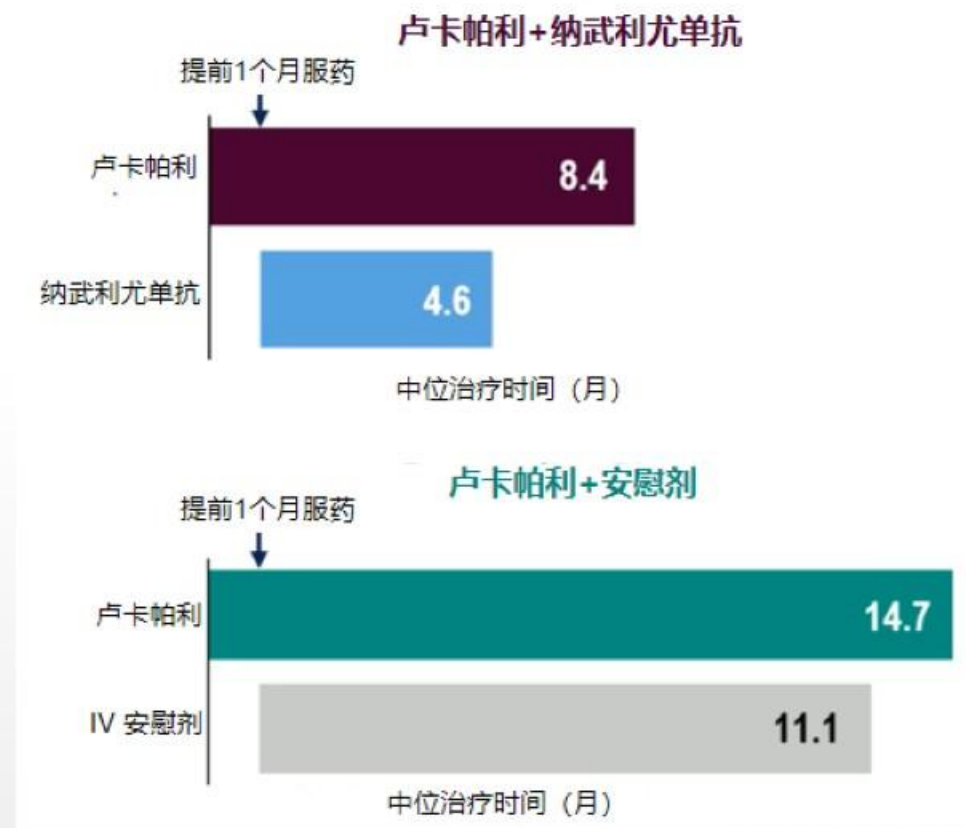


数据截止日期: 2024年5月17日。

CI, 置信区间; HR, 风险比; ITT, 意向治疗; Nivo, 纳武利尤单抗; NR, 未达到; OS, 总生存期; Plac, 安慰剂; Ruca, 卢卡帕利。

- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
- Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ATHENA-COMBO: 有效人群治疗暴露 (ITT)



ITT, 意向治疗; IV, 静脉注射。

□ 卢卡帕利+安慰剂组的患者比卢卡帕利+纳武利尤单抗组患者暴露于卢卡帕利的时间长75%。

□ 卢卡帕利的中位相对剂量强度:

➢ 卢卡帕利+纳武利尤单抗=0.84

➢ 卢卡帕利+安慰剂=0.89

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ATHENA-COMBO: 安全性小结 (安全性分析人群)



不良事件, n (%)	卢卡帕利+纳武利尤单抗 (N=410)	卢卡帕利+安慰剂 (N=448)
任意等级 TEAE	407 (99.3)	435 (97.1)
≥3级 TEAE	306 (74.6)	286 (63.8)
因TEAE导致的口服药物治疗中断和/或剂量减少	321 (78.3)	283 (63.2)
因TEAE导致口服的研究药物停药	104 (25.4)	66 (14.7)
因TEAE导致静脉注射的研究药物停药	145 (35.4)	43 (9.6)
因TEAE导致口服和静脉注射的研究药物停药	63 (15.4)	19 (4.2)
因TEAE导致死亡 ^a (不包括疾病进展)	9 (2.2)	4 (0.9)
MDS/AML	4 (0.98)	4 (0.89)

□ 导致口服和/或静脉注射研究药物中断的最常见的TEAEs (≥2%) 包括: ALT/AST升高^b、贫血^b、虚弱^b、中性粒细胞减少^b、血小板减少^b、发热性中性粒细胞减少、皮疹和恶心。

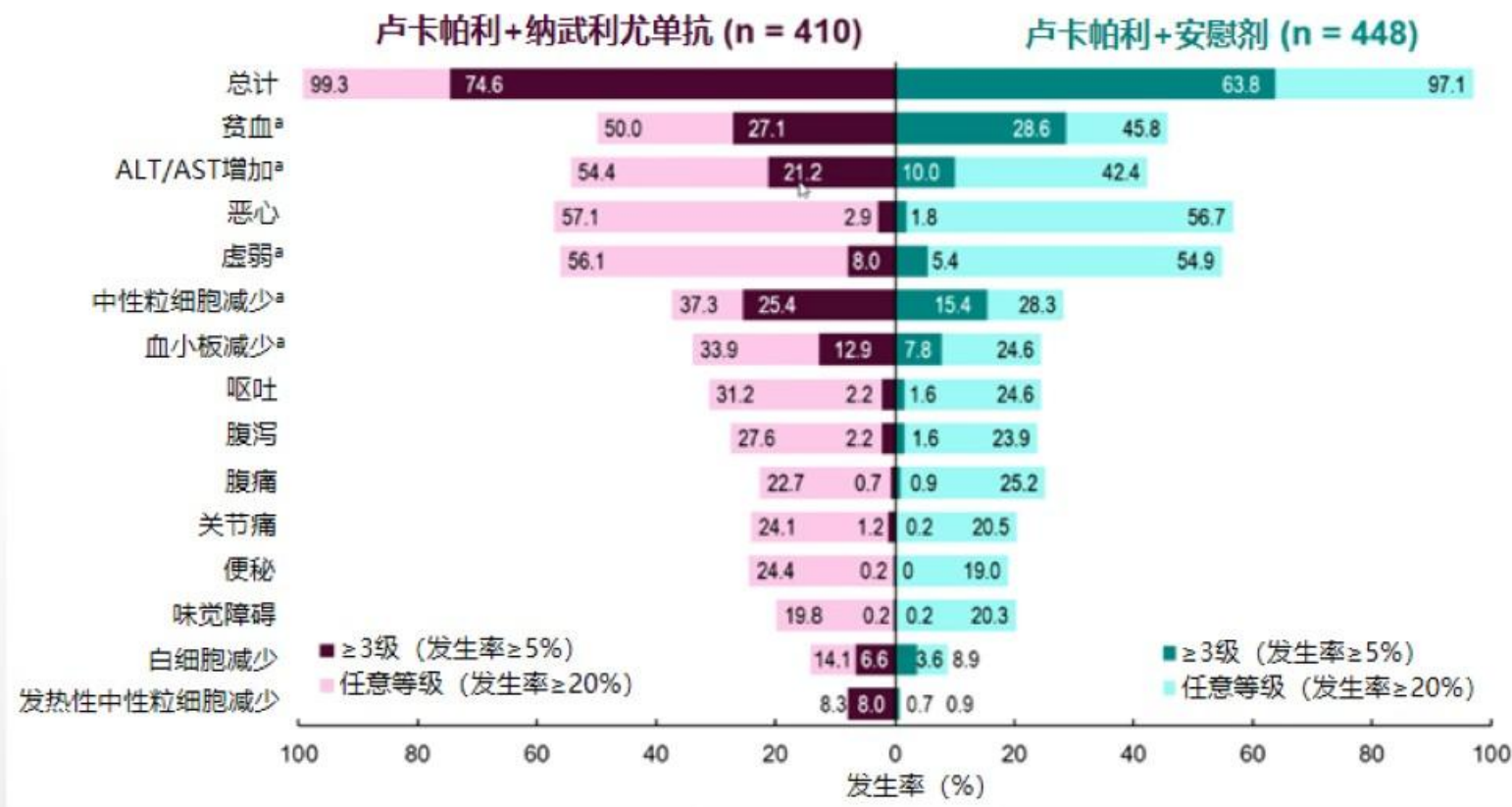
□ MDS/AML在两组发生率<1%; 除了1例卢卡帕利+安慰剂组发生的MDS事件, 所有事件都在长期随访中发生。

数据截止日期: 2024年5月17日。

a只有3例死亡事件被认为与治疗相关, 2例发生在卢卡帕利+纳武利尤单抗组 (发热性中性粒细胞减少和巨结肠), 1例发生在卢卡帕利+安慰剂组 (AML); b分组术语: 贫血或血红蛋白降低; ALT或AST升高, 虚弱或疲劳, 中性粒细胞减少或中性粒细胞计数降低; 血小板减少或血小板计数降低。ALT, 谷丙转氨酶; AML, 急性髓系白血病; AST, 谷草转氨酶; IV, 静脉注射; MDS, 骨髓增生异常综合征; TEAE, 治疗期间出现的不良事件 (在首次给予研究药物或之后直至最后一次口服+28天或最后一次静脉注射+5个月发生的任何不良事件,)。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ATHENA-COMBO: 最常见的TEAES



^a分组术语: 贫血或血红蛋白降低; ALT或AST升高, 虚弱或疲劳, 中性粒细胞减少或中性粒细胞计数降低; 血小板减少或血小板计数降低。
ALT, 谷丙转氨酶; AST, 谷草转氨酶; TEAES, 治疗期间出现的不良事件; WBC, 白细胞

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

研究结论



- 纳武利尤单抗联合卢卡帕利与毒性增加相关，联合方案并未将卢卡帕利单药用于一线维持治疗的PFS获益延长。
- 卢卡帕利单药的疗效与ATHENA-MONO研究额外随访2年观察到的结果一致。

PFS, 无进展生存期

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03522246>
2. Bradley J. Monk, et al. 2024 ESMO LBA30.

ICON9研究：评估奥拉帕利联合西地尼布对比奥拉帕利单药 用于铂类化疗缓解的铂敏感复发性卵巢癌维持治疗疗效的国际 III期随机对照研究

ICON9: International phase III randomised trial evaluating efficacy of maintenance olaparib + cediranib vs olaparib alone in relapsed platinum-sensitive ovarian cancer following a response to platinum-based chemotherapy

通讯作者：Shibani Nicum

研究机构：Oxford University Hospitals NHS Trust

1. <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/EudraCT:2017-000161-75>.
2. Shibani Nicum, et al. 2024 ESMO LBA33.

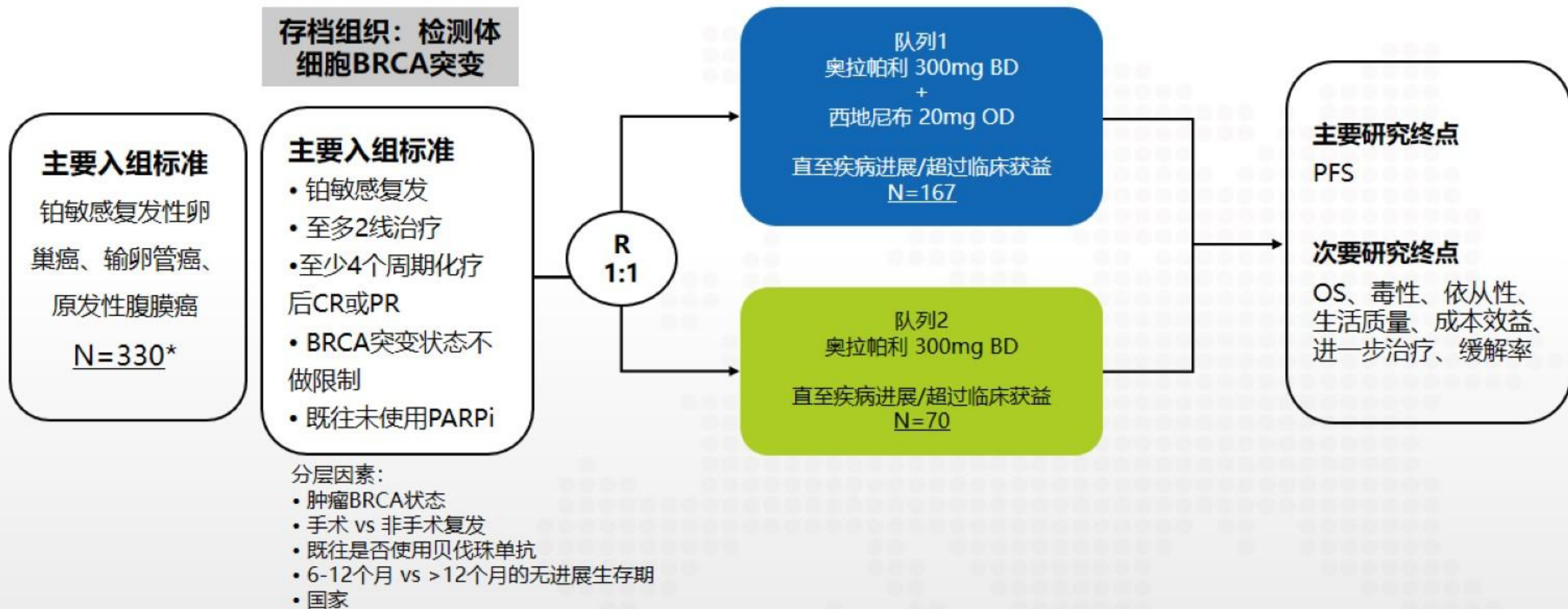
研究背景



- 大多数晚期卵巢癌患者在18至24个月内复发。
- 在铂敏感复发（PSR）卵巢癌中，PARP抑制剂奥拉帕利和血管内皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂西地尼布均已显示出疗效获益^{1,2}。
- ICON9是一项国际随机对照III期试验，旨在评估在对铂类化疗敏感的首次铂敏感复发卵巢癌中，奥拉帕利和西地尼布维持治疗对比奥拉帕利单药治疗的维持疗效。
- 主要终点是无进展生存期（PFS），目标风险比(HR)为0.70，奥拉帕利对照组的预计中位PFS为8.4个月，把握度80%。

1. Ledermann et al. N Engl J Med 2012; 2. Ledermann et al. Lancet 2016

研究设计



*2021年12月20日试验修订

1. <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/EudraCT:2017-000161-75>.
2. Shibani Nicum, et al. 2024 ESMO LBA33.

基线特征



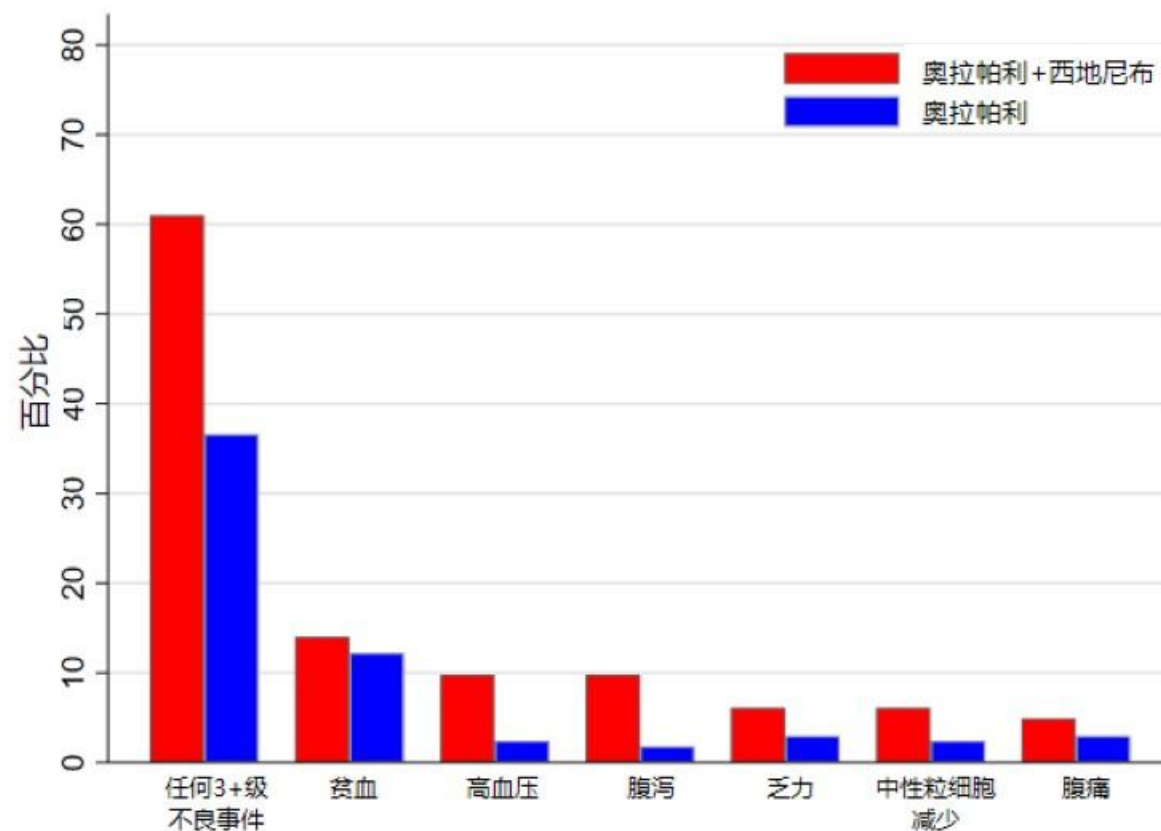
	奥拉帕利 (N=170)	奥拉帕利+西地尼布 (N=167)
年龄, 中位值 (范围), 年	64 (34-81)	62 (34-85)
ECOG PS, n (%)		
0	96 (56.5%)	102 (61.1%)
1	74 (43.5%)	65 (38.9%)
组织学类型, n (%)		
浆液性癌	164 (97.0%)	163 (97.6%)
子宫内膜样癌	5 (3.0%)	4 (2.4%)
缺失	1	0
二线化疗, n (%)		
6个周期	144 (84.7%)	152 (91.0%)
4-5个周期	26 (15.3%)	15 (9.0%)

	奥拉帕利 (N=170)	奥拉帕利+西地尼布 (N=167)
无铂间期, n (%)		
6-12个月	47 (27.6%)	44 (26.3%)
>12个月	123 (72.4%)	123 (73.7%)
复发手术, n (%)		
手术	25 (14.7%)	19 (11.4%)
无手术	145 (85.3%)	148 (88.6%)
既往贝伐珠单抗治疗, n (%)		
是	60 (35.3%)	60 (35.9%)
否	110 (64.7%)	107 (64.1%)
tBRCA状态, n (%)		
BRCA突变型	39 (22.9%)	38 (22.8%)
BRCA野生型	131 (77.1%)	129 (77.2%)
国家, n (%)		
英国	100 (58.8%)	102 (61.1%)
澳大利亚/新西兰	60 (35.3%)	57 (34.1%)
加拿大	10 (5.9%)	8 (4.8%)

1. <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/EudraCT: 2017-000161-75>.

2. Shibani Nicum, et al. 2024 ESMO LBA33.

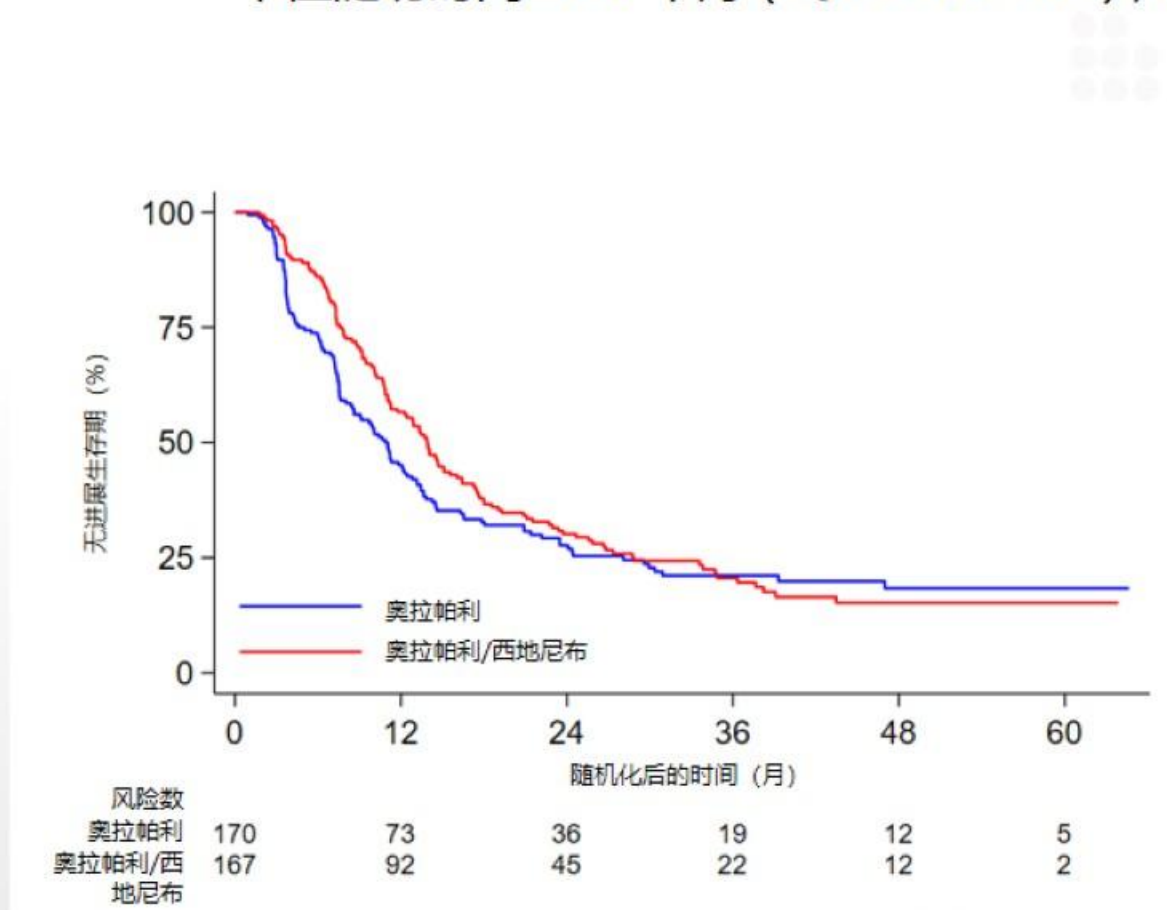
3+级不良事件和依从性



	奥拉帕利 (N=170)	奥拉帕利+西地尼布 (N=167)
治疗中, n (%)	30 (17.6%)	33 (19.8%)
停止治疗, n (%)	140 (82.4%)	134 (80.2%)
停止原因, n (%)		
疾病进展	115 (82.1%)	103 (76.9%)
安全性	15 (10.7%)	18 (13.4%)
其他	10 (7.1%)	13 (9.7%)
中位周期数 (范围; IQR)	8 (0-51; 4-14)	11 (0-55; 6-18)

主要研究终点: PFS

- 中位随访时间 37.0 个月 (IQR: 24.8–50.9) ; PFS 事件数: 255



	奥拉帕利 (N=170)	奥拉帕利+西地尼布 (N=167)
中位 PFS (95% CI)	11.0 个月 (8.4–12.8)	13.9 个月 (11.3–16.1)
HR (95% CI)	0.84 (0.65-1.07), p=0.24	

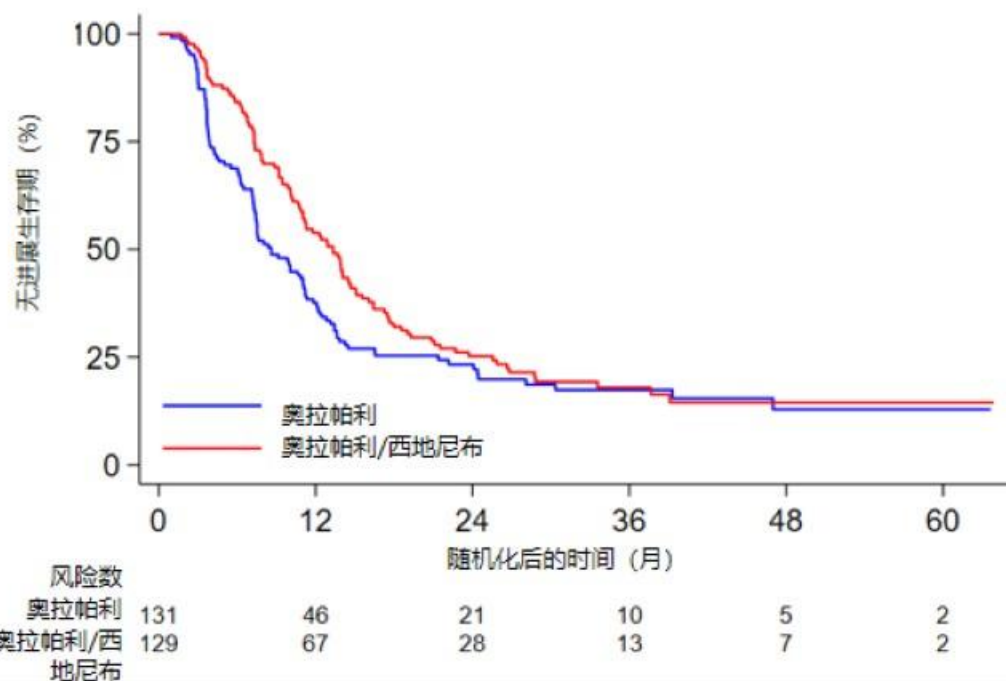
非比例性风险 (p=0.001)。
限制性平均生存时间: 前24个月, O+C组比O组无进展生存时间平均多1.9个月 (14.7个月 vs 12.8个月) (95%CI: 0.2–3.6)。

肿瘤BRCA状态的PFS

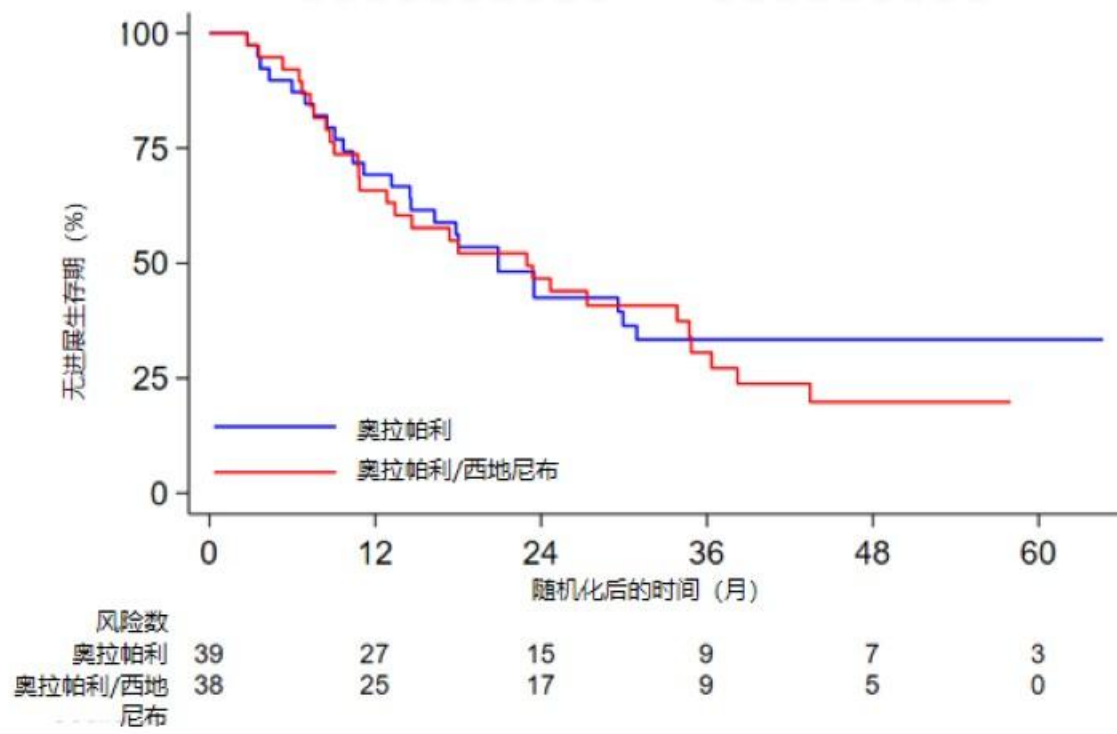


无论BRCA状态如何，PFS无显著差异

BRCA野生型 p=0.06

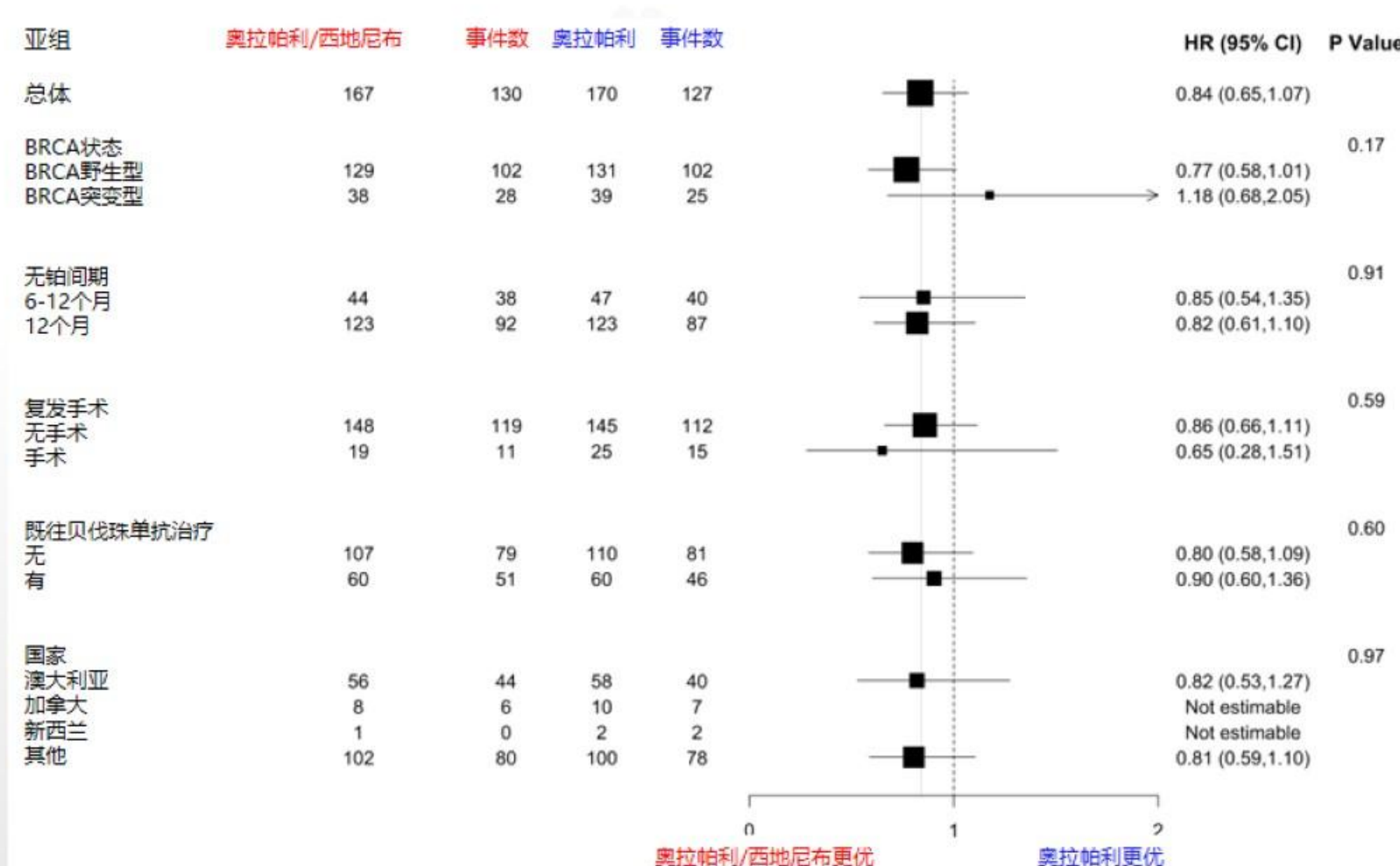


BRCA突变型 p=0.61



1. <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/EudraCT:2017-000161-75>.
2. Shibani Nicum, et al. 2024 ESMO LBA33.

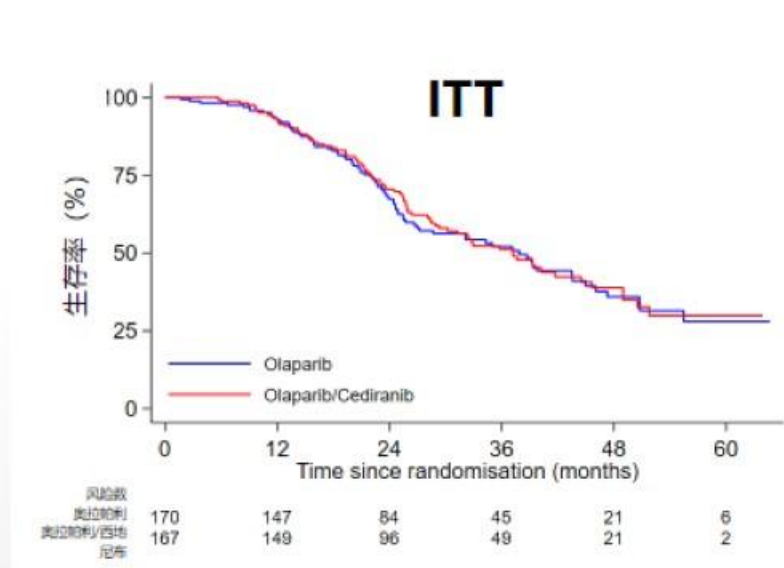
PFS亚组分析



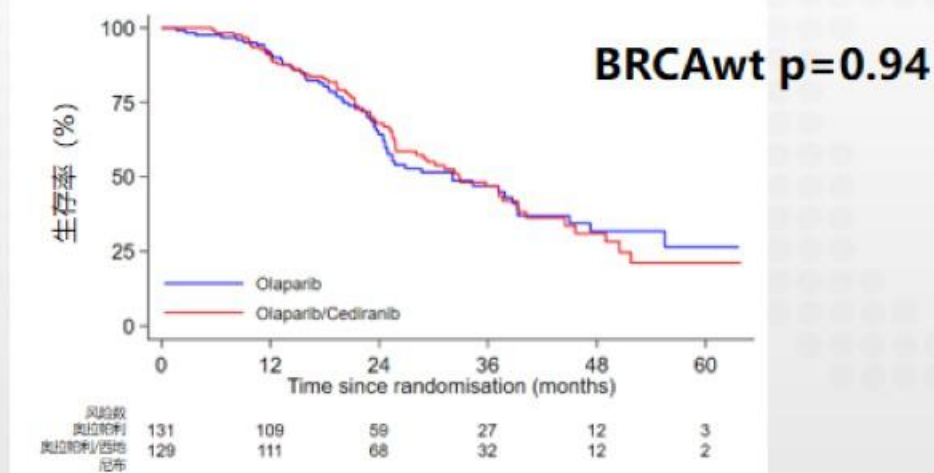
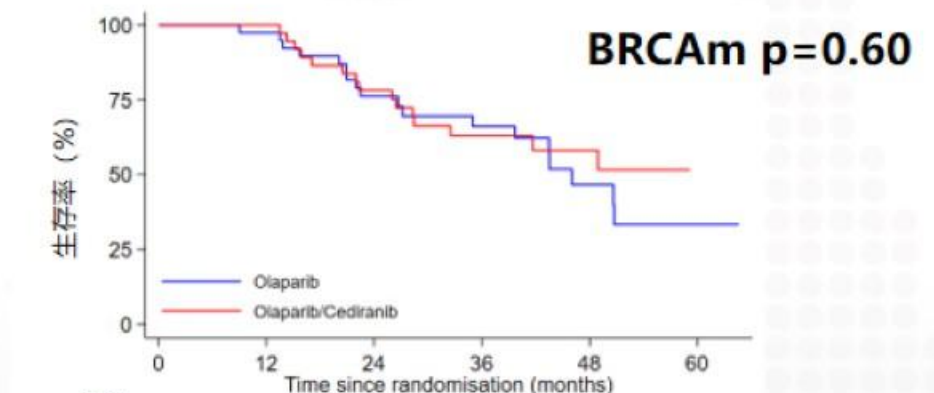
- <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/EudraCT:2017-000161-75>.
- Shibani Nicum, et al. 2024 ESMO LBA33.

ITT人群及BRCA状态的OS

- 中位随访时间 37.0 个月 (IQR: 24.8–50.9) ; OS 事件数: 160;
- OS: 在任何分层因素下包括BRCA状态, OS均无显著差异。



ITT	奥拉帕利 (N=170)	奥拉帕利+西地尼布 (N=167)
中位 OS (95% CI)	37.8 个月 (26.9–45.0)	37.2 个月 (29.3–44.5)
HR (95% CI)	0.92 (95% CI: 0.67–1.26), p=0.81	
没有非比例性风险的证据 (p=0.62)		



1. <https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/EudraCT: 2017-000161-75>.
 2. Shibani Nicum, et al. 2024 ESMO LBA33.

研究结论

- 与奥拉帕利相比，奥拉帕利/西地尼布维持治疗对PFS或OS的改善无统计学意义（HR分别为0.84和0.92）。
 - 奥拉帕利的中位无进展生存期（mPFS）为11.0个月 - 优于预期（8.4个月）。
 - 奥拉帕利的中位总生存期（mOS）为37.8个月 - 优于预期（29.8个月）。
 - BRCA野生型和突变型患者之间没有差异。
- 药物的安全性与预期的毒性一致。
 - 专家关注的不良事件：骨髓增生异常综合征（MDS）：2例奥拉帕利单药组；急性髓系白血病（AML）：1例奥拉帕利/西地尼布联合治疗组。
- 正在进行的分析：
 - 生活质量评分（QLQ-C30, QLU-C10D, QLQ-OV28），全球健康状况评分（EQ-5D-5L）。
- 转化研究：
 - 同源重组修复缺陷（HRD）状态/TIE2水平，以识别可能获益于联合西地尼布治疗的患者。

索米妥昔单抗 (MIRV) 用于治疗铂敏感复发性卵巢癌且叶酸受体 α (FR α)高表达的患者: II期PICCOLO研究结果

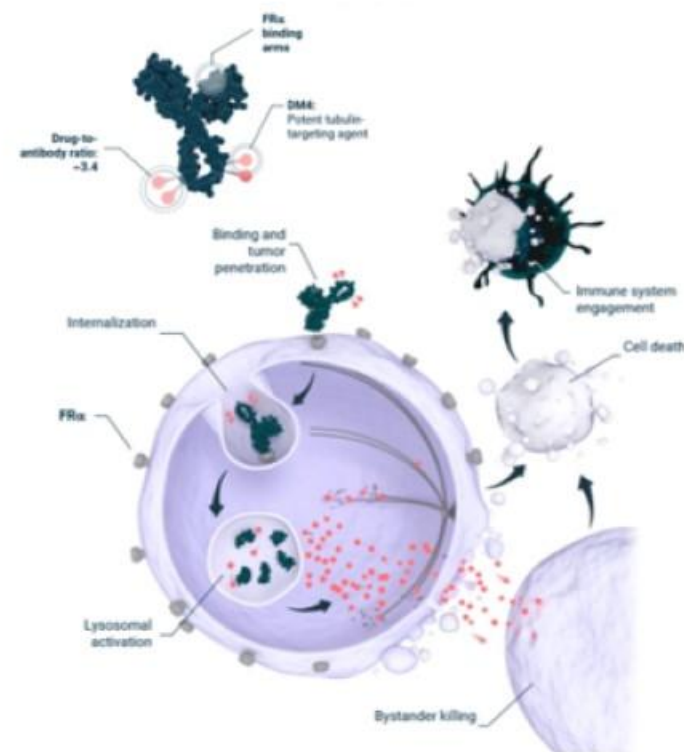
Mirvetuximab Soravtansine (MIRV) in Recurrent Platinum-Sensitive Ovarian Cancer (PSOC) with High Folate Receptor-Alpha (FR α) Expression: Results From the Phase II PICCOLO Trial

第一作者: Angeles Alvarez Secord
研究机构: Duke Cancer Institute

研究背景



- ❑ MIRV是首个经FDA批准用于卵巢癌的ADC药物，也是自2014年以来唯一——一个批准用于铂耐药复发（PROC）治疗的药物。
 - MIRV正在欧洲进行上市许可申请评估
- ❑ MIRV由FR α 结合抗体、可切割连接子以及有效的靶向微管蛋白的美登素DM4载荷组成。^{1,2}
- ❑ 在卵巢癌中，基于铂的化疗的疗效随着每次复发而减弱，患者耐受铂类相关毒性累积的能力也随之减弱。³
- ❑ 接受过PARPi治疗的患者对后续治疗的响应减弱，尤其是铂类药物。⁴



1. Ab O, et al. Mol Cancer Ther. 2015; 14(7): 1605-1613.

2. Moore KN, et al. Cancer.2017; 123(16): 3088-3087.

3. Kessous R, et al. Int J Cancer.2021;148:2304-2312.

4. O' Malley et al. Target Oncol.2023;18:471-503.

研究设计: PICCOLO(NCT05041257)

单臂, 开放标签II期研究

PICCOLO受试者总数 (N=79)

主要入组标准

- 铂敏感 (定义为从最后一剂含铂治疗至影像学进展时间 > 6个月)
- 可在大于75%的存活肿瘤细胞中经免疫组化检测到PS2+强度的FR α^a
- 至少经过2种前线含铂化疗^b
- 若BRCA+, 则需要经过PARPi治疗
- 既往是否贝伐珠单抗经治无要求
- 适合单药治疗

治疗方案

索米妥昔单抗
(6 mg/kg AIBW Q3W)

主要研究终点

ORR (研究者评估)

关键次要研究终点

DoR (研究者评估)

其它次要研究终点

安全性与毒性
CA-125响应 (GCIG标准)
PFS
OS
敏感性分析^c

a: FR α 表达测量由VENTANA FOLR1[FOLR1-2.1] RxDx检测

b: 有记录的铂过敏为前1线治疗

c: 由BICR评估的ORR/DoR和PFS将收集用于敏感性分析

AIBW:调整后的理想体重 GCIG: 妇科肿瘤协作组 PS2+: 阳性染色强度 ≥ 2

BRCA: 乳腺癌易感基因

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>

2. Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

基线人口统计学和特征

特征	N=79
中位年龄, 岁(范围)	66 (41-84)
人种, n(%)	
白人	65 (82.3)
黑人或非裔美国人	4 (5.1)
亚洲人	1 (1.3)
未报道	8 (10.1)
其它	1 (1.3)
前线系统治疗次数, n (%)	
1-2 ^a	49(62.0)
≥3	30 (37.9)
前线紫杉醇暴露, n (%)	
是	77 (97.5)
多线暴露	20 (25.3)
否	2 (2.5)

特征	N=79
既往接受PARPi ^b , n (%)	
是	64 (81.0)
进展 ^c	59 (74.7)
未进展	5 (6.3)
否	12 (15.2)
既往贝伐珠单抗暴露, n (%)	
是	51 (64.6)
否	28 (35.4)
最新无铂间期 (月) ^d , n(%)	
≤12	43 (54.4)
> 12	34 (43.0)

筛选302例患者, 124 (44%) 具有≥75% ≥2+ FRα肿瘤表达

数据截止时间: 2024年1月17日

a: 仅一例患者接受一次前线系统治疗

b: 3名参与者(3.8%)参与了评估PARPi对比安慰剂的双盲试验(实际治疗未知), 因而对先前PARPi的暴露情况不确定

c: 如果受试者在最后一次服用PARPi后的30天内疾病进展或疾病进展原因被归为停止服用PARPi, 则该受试者被定义为在既往使用PARPi时疾病进展, 并被归入此类别。

d: 无铂间期受试者缺失2人 (2.5%)

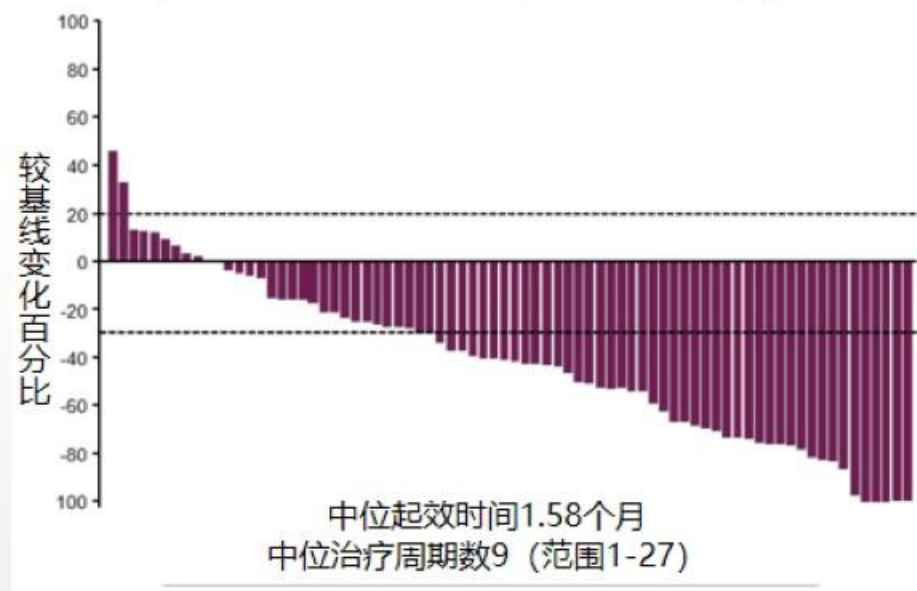
1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>

2. Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

研究者评估的疗效



使用索米妥昔单抗患者基线起最大肿瘤百分比变化



数据截止时间：2024年1月17日

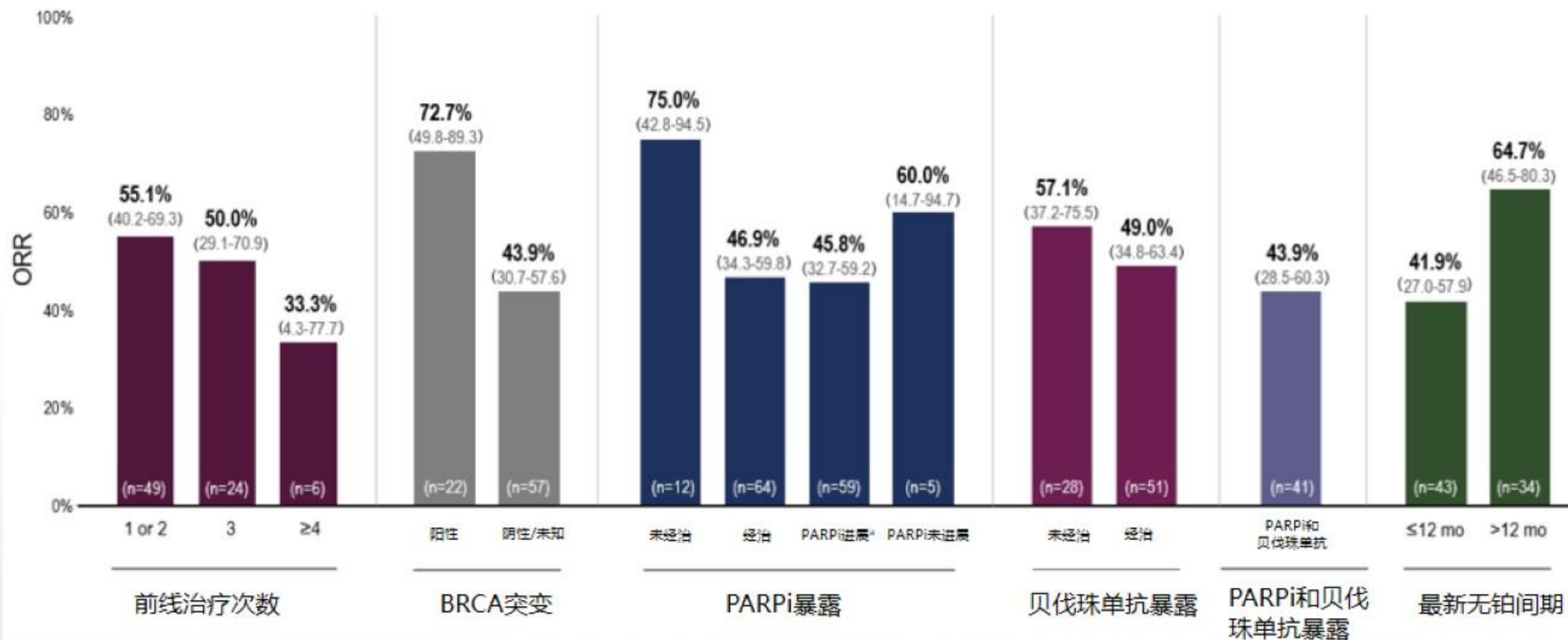
- a: 在CR和PR的患者中计算
- b: 对CA -125可评估人群进行分析

主要终点	N=79
ORR, n (%)	41 (51.9)
95% CI	40.4-63.3
最佳整体响应, n (%)	
CR	6 (7.6)
PR	35 (44.3)
SD	29 (36.7)
PD	7 (8.9)
未评估, n (%)	2 (2.5)

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>
2. Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

亚组ORR

全人群ORR: 51.9% (95% CI, 40.4-63.3)



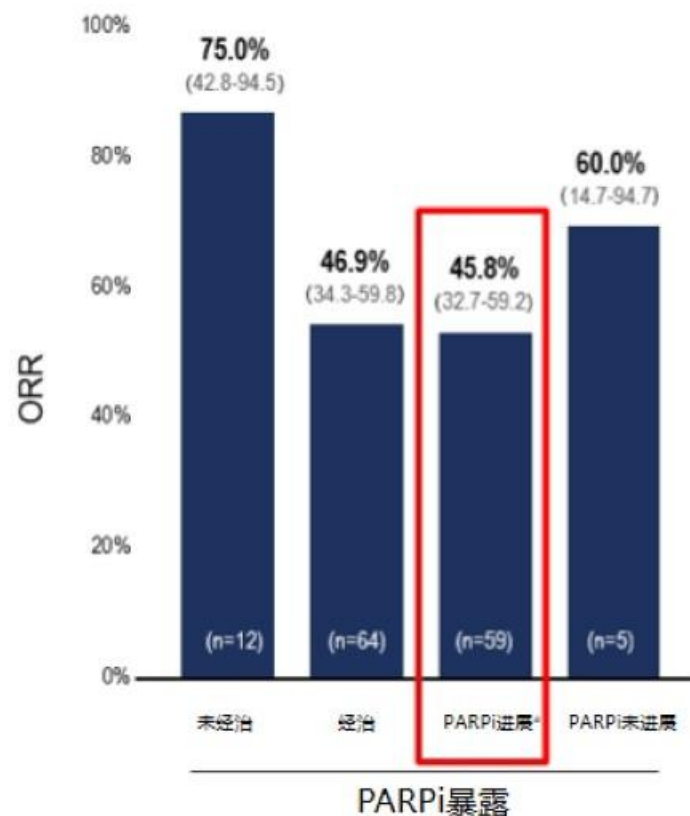
数据截止时间: 2024年1月17日

a: 如果受试者在最后一次服用PARPi后的30天内疾病进展或停止服用PARPi的原因被归为疾病进展, 则该受试者被定义为在既往使用PARPi时疾病进展, 并被归入此类别

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>
2. Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

PARPi暴露亚组ORR

全人群ORR: 51.9% (95% CI, 40.4-63.3)



PARPi暴露	中位DoR月 (95%CI)
未经治	8.8 (3.5-NR)
经治	8.3 (5.5-10.8)
使用PARPi进展	7.3 (5.0-10.8)
使用PARPi未进展	8.4 (7.0-NR)

数据截止时间: 2024年1月17日

a: 如果受试者在最后一次服用PARPi后的30天内疾病进展或停止服用PARPi的原因被归为疾病进展, 则该受试者被定义为在既往使用PARPi时疾病进展, 并被归入此类别。b: 无铂间期定义为最近一次含铂治疗到该线疾病进展或复发的时间。

- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>
- Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

安全性小结



TEAEs小结	N=79
任何TEAEs, n(%)	78 (99)
3级以上TEAEs, n(%)	40 (51)
SAEs, n(%)	15 (19)
治疗相关SAEs, n(%)	7 (9)
研究中导致剂量调整的TEAE, n(%)	52 (66)
导致剂量降低的TEAE, n(%)	33 (42)
导致剂量延迟/不变的TEAE, n(%)	48 (61)
导致研究中止的TEAE, n(%)	13 (16)
导致死亡的TEAE ^a , n(%)	2 (3)
治疗相关的AE导致死亡, n(%)	1 (1)

a: TEAE导致2名受试者死亡。其中一个认为与MIRV(肺炎)有关，另一个认为不相关(感染性休克)。

TEAE: 治疗期出现的不良事件

SAE: 严重不良事件

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>
2. Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

受试者中发生≥10%的TEAEs（任何等级，≥3级；N=79）



TEAE, n (%)	All grades	Grade ≥3 ^a
视力模糊	50 (63)	8 (10)
干眼症	29 (37)	2 (3)
恶心	29 (37)	1 (1)
角膜病	26 (33)	3 (4)
腹泻	24 (30)	2 (3)
虚弱	23 (29)	2 (3)
周围神经病变	22 (28)	3 (4)
白内障	19 (24)	6 (8)
关节痛	16 (20)	1 (1)
天冬氨酸转移酶升高	16 (20)	0
呕吐	15 (19)	1 (1)

TEAE, ^{a,b} n (%)	All grades	Grade ≥3 ^a
丙氨酸氨基转移酶升高	14 (18)	0
疲劳	14 (18)	0
便秘	13 (16)	0
头痛	13 (16)	0
COVID-19	12 (15)	0
畏光	12 (15)	0
腹痛	11 (14)	0
中性粒细胞减少	11 (14)	2 (2)
神经毒性	10 (13)	2 (3)
味觉障碍	9 (11)	0
肺炎	8 (10)	3 (4)

a: 除一例受试者出现4级中性粒细胞减少和1例出现5级肺炎外，此表的其他事件均为≤3级。b: 1例受试者缺失等级

TEAE: 治疗期出现的不良事件

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>
2. Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

研究结论



- PICCOLO研究在接受过多重方案治疗的铂敏感复发卵巢癌（PSOC）人群中显示出显著的疗效，包括那些可能有PARPi耐药的人群(75%的受试者)。
 - ◆ 研究者评估的ORR:51.9%(95% CI, 40.4-63.3), 包括6个CR
 - ◆ mDOR:8.25个月(95% CI, 5.55-10.78)
 - ◆ 在PARPi进展的患者中, ORR为45.8%(95%CI, 32.7-59.2), mDOR为7.33个月(95%CI, 5.03-10.78)。
 - ◆ 中位起效时间: 1.58个月
- 索米妥昔单抗继续显示出具有差异化的安全特性, 其AE主要由低等级感觉神经的、胃肠道的和可解决的眼部的不良反应组成
- 这些数据使索米妥昔单抗成为 $\geq 3L$ PSOC且FR α 阳性表达患者的新治疗选择
- 索米妥昔单抗继续在较前线治疗中联合贝伐珠单抗和卡铂进行探索

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05041257>
2. Angeles Alvarez Secord, et al. 2024 ESMO 718MO.

III期MIRASOL研究：索米妥昔单抗 (MIRV) vs. 研究者选择的化疗用于铂耐药卵巢癌伴叶酸受体 α (FR α)高表达患者的生存结果更新

Phase III MIRASOL trial: Updated overall survival results of mirvetuximab soravtansine (MIRV) vs. investigator's choice chemotherapy (ICC) in patients (pts) with platinum-resistant ovarian cancer (PROC) and high folate receptor-alpha (FR α) expression

作者：Lan Gardner Coffman

研究机构：University of Pittsburgh

研究背景



- 索米妥昔单抗 (MIRV) 是一种首创的ADC药物, 由FR α 结合抗体、可裂解的连接子和美登木素生物碱DM4 (一种强效的微管蛋白靶向剂) 组成^{1, 2}。
- FR α 在高达97%的卵巢癌中表达, 其中39%的卵巢癌表现出FR α 高表达³⁻⁷。
- 基于MIRASOL III期试验 (NCT04209855) 的结果, MIRV于2024年3月被美国FDA批准用于治疗既往接受过1-3次系统治疗、FR α 阳性、铂耐药卵巢癌 (PROC) 成人患者^{7, 8}。
 - MIRV目前正在欧洲进行上市许可申请的评估⁹。
- 在MIRV对比研究者选择的化疗用于高级别浆液性PROC的MIRASOL研究初步分析中, 中位随访时间13.1m, MIRV显示出优于研究者选择化疗的PFS (中位, 5.62 m vs. 3.98 m; HR, 0.65; 95% CI, 0.52-0.81; P<0.0001)、ORR (42.3% vs. 15.9%; OR, 3.81; 95% CI, 2.44-5.94; P<0.0001), 和OS (中位, 16.46 m vs. 12.75 m; HR, 0.67; 95% CI, 0.50-0.89; P=0.0046)^{7, 10}。
- 基于此, 我们报道了延长随访日期的更新非分析性结果 (到MIRASOL的第120天), 中位随访20.3m (范围, 19.3-21.4)。

1. Moore KN, et al. Cancer. 2017;123(16):3080-7. 2. Ab O, et al. Mol Concer Ther. 2015;14(7):1605-13. 3. Markert S, et al. Anticancer Res. 2008;28(6A):3567-72. 4. Kalli KR, et al. Gynecol Oncol. 2008;108(3):619-26. 5. Martin LP, et al. Gynecol Oncol. 2017;147(2):402-7. 6. Matulonis UA, et al. J Clin Oncol. 2023;41(13):2436-45. 7. Moore KN, et al. N Engl J Med. 2023;389(23):2162-74. 8. ELAHERE. Prescribing information. ImmunoGen, Inc.; 2024. 9. News release. AbbVie Inc; October 27, 2023. Accessed September 5, 2024. 10. Moore KN, et al. 2023 ASCO. LBA5507.

研究设计



全球、确证性、随机、开放标签III期临床研究 (NCT04209855)

主要入组标准

- 铂耐药 (PFI ≤ 6个月);
- IHC检测FRα, ≥ 75%肿瘤细胞强度PS2+;
- 组织学为高级别浆液性;
- 排除铂难治 (初始PFI < 3个月);
- 既往经过1-3线治疗;
- 允许既往接受过贝伐珠单抗和PARPi;
- 允许有BRCA突变的患者

N=453

分层因素

- 研究者选择的化疗: 紫杉醇、PLD或拓扑替康
- 既往治疗线数: 1线 vs. 2线 vs. 3线

初步分析数据截止日期: 2023年3月6日。延长随访数据截止日期: 2023年10月27日。

AIBW, 调整的理想体重; BICR: 盲法独立中心评价; BRCA, 乳腺癌基因; CA-125, 肿瘤抗原125; FRα, 叶酸受体α; IC, 研究者的选择; IHC, 免疫组织化学; INV, 研究者; PARPi, 聚(ADP核糖)聚合酶抑制剂; PLD, 聚乙二醇脂质体多柔比星; PFI, 无铂间期; PROs, 患者报告结局; PS2+, 阳性染色强度 ≥ 2;

a 关键次要终点PRO评估使用OV28腹部/胃肠道症状亚量表来确定在第8/9周改善 ≥ 15% (或相当于15分) 的人数。b 国际妇癌组织 (GCIg) 标准。

c 包括来自OV28 (附加子量表)、EORTC QLQ-C30 (C30), EQ-5D-5L和PGI-S。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04209855>

2. Lan Gardner Coffman, et al. ESMO 2024. e-poster 746.

试验组治疗方案:

MIRV
(6 mg/kg AIBW Q3W)
N=227

对照组治疗方案:

研究者选择的化疗
(紫杉醇、PLD或拓扑替康)
N=226

- ITT人群: 所有接受随机分组的患者, 无论分配到哪个治疗组。
- 安全性分析人群: 所有接受随机分组, 并且接受了至少1次治疗的患者。

主要终点:

- INV评估的PFS
(BICR 敏感性分析)

关键次要终点:

- INV评估的ORR
(BICR 敏感性分析)
- OS
- OV28腹部/胃肠亚量表^a

次要终点:

- 安全性和耐受性
- DOR
- CA-125 反应^b
- PFS2

探索性终点:

- 额外的PRO评估^c

事后分析

- 报告了延长截止日期的数据和 *p* 值
- 分层分析报告了HR和优势比

基线特征



表1 MIRASOL研究基线统计及分层因素(n=453)^a

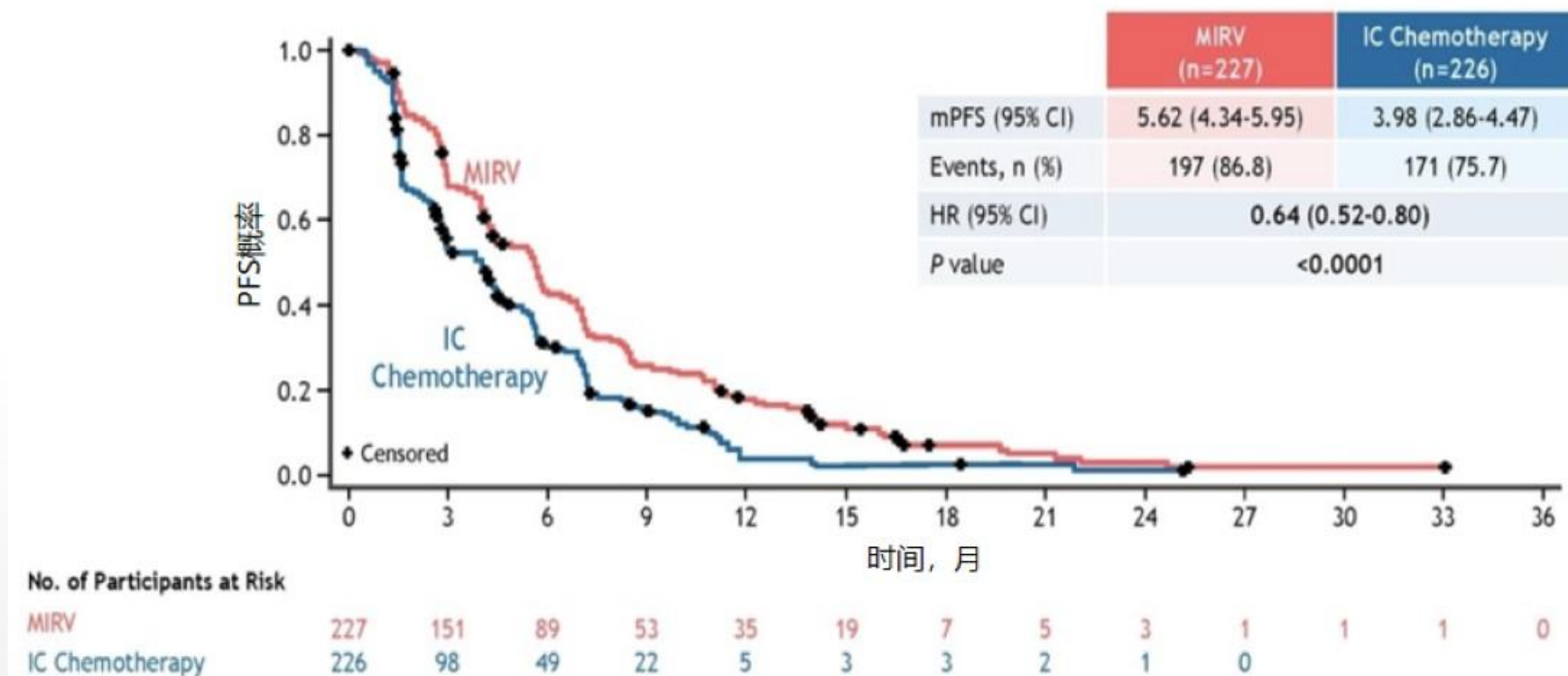
特征		MIRV (n=227)	研究者选择的化疗 (n=226)
年龄, 中位 (范围), 岁	年龄	64 (32-88)	62 (29-87)
	I-II	9 (4)	9 (4)
初始诊断分期, n (%) ^b	III	137 (60)	147 (65)
	IV	76 (33)	65 (29)
	是	29 (13)	36 (16)
BRCA突变, n (%)	否/未知	198 (87)	190 (84)
	贝伐珠单抗	138 (61)	143 (63)
既往暴露, n (%)	PARPi	124 (55)	127 (56)
	紫杉类	227 (100)	224 (99)

特征		MIRV (n=227)	研究者选择的化疗 (n=226)
初始无铂间期, n (%) ^c	≤ 12m	146 (64)	142 (63)
	>12m	80 (35)	84 (37)
无铂间期, n (%) ^d	≤ 3m	88 (39)	99 (44)
	>3m-≤6m	138 (61)	124 (55)
分层因素: 既往全身治疗 线数, n (%)	1	31 (14)	32 (14)
	2	91 (40)	91 (40)
	3	105 (46)	103 (46)
分层因素: 研究者选择的 化疗, n (%)	紫杉醇	93 (41)	92 (41)
	PLD	82 (36)	81 (36)
	拓扑替康	52 (23)	53 (23)

初步分析数据截止日期:2023年3月6日。
a 意向治疗人群。
b MIRV组5例(2%)受试者、研究者选择的化疗组5例(2%)受试者缺少初始诊断时的分期信息。
c MIRV组1例(<1%)受试者缺少初始无铂间期信息。
d MIRV组有1例(<1%)受试者, 研究者选择的化疗组有3例(1%)受试者, 无铂间期 > 6个月。
Lan Gardner Coffman, et al. ESMO 2024. e-poster 746.

□ 至延长随访数据截止日期 (2023年10月27日), 5% (n=10)的受试者依然在接受MIRV治疗, <1% (n=1)的受试者依然在接受研究者选择的化疗治疗。

事后分析研究者评估的PFS



延长随访数据截止日期:2023年10月27日。

- 到延长随访的数据截止日期，更新的PFS HR为0.64 (95% CI, 0.52-0.80, 名义 $p < 0.0001$)，MIRV相比于研究者选择的化疗更有利。

更新的ORR



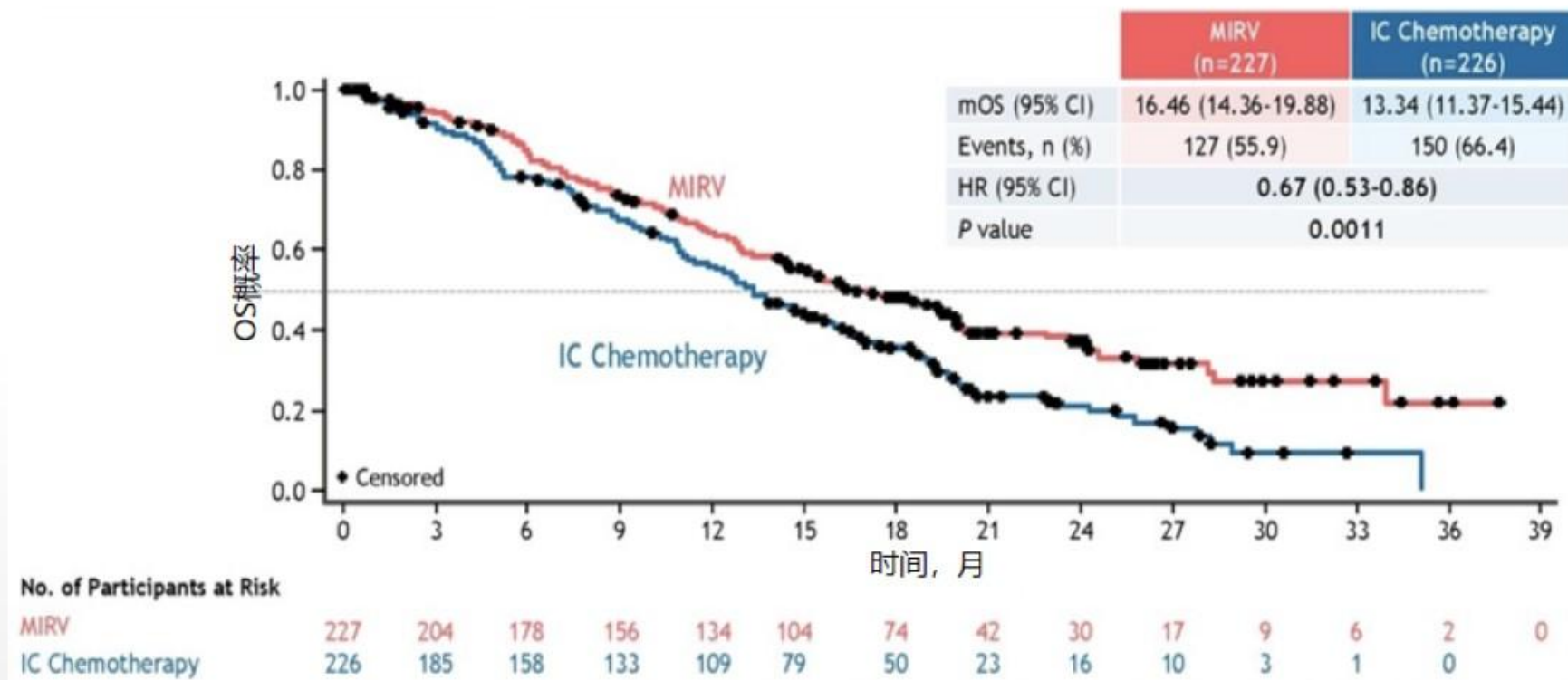
	MIRV (n=227)	研究者选择的化疗 (n=226)
研究者评估的ORR n (95% CI)	42.7% 97 (36.2-49.4)	15.9% 36 (11.4-21.4)
CR, n (%)	13 (5.7)	0
PR, n (%)	84 (37.0)	36 (15.9)
SD, n (%)	85 (37.4)	91 (40.3)
PD, n (%)	31 (13.7)	63 (27.9)
NE, n (%)	14 (6.2)	36 (15.9)
研究者评估的ORR差异 (95% CI), 26.8% (18.8-34.8)		
OR (95% CI), 3.89 (2.49-6.08)		
$p < 0.0001$		

延长随访数据截止日期:2023年10月27日。

- 到延长随访的数据截止日期，更新的研究者评估的ORR在MIRV组为42.7% (95% CI, 36.2-49.4)，研究者选择的化疗组为15.9% (95%CI, 11.4-21.4)。
- MIRV和研究者选择的化疗组ORR更新的治疗差异为26.8% (95% CI 18.8-34.8)，OR为3.89 (95% CI, 2.49-6.08)，名义 $p < 0.0001$ ，与研究者选择的化疗相比更有利于MIRV。

Lan Gardner Coffman, et al. ESMO 2024. e-poster 746.

事后分析的OS



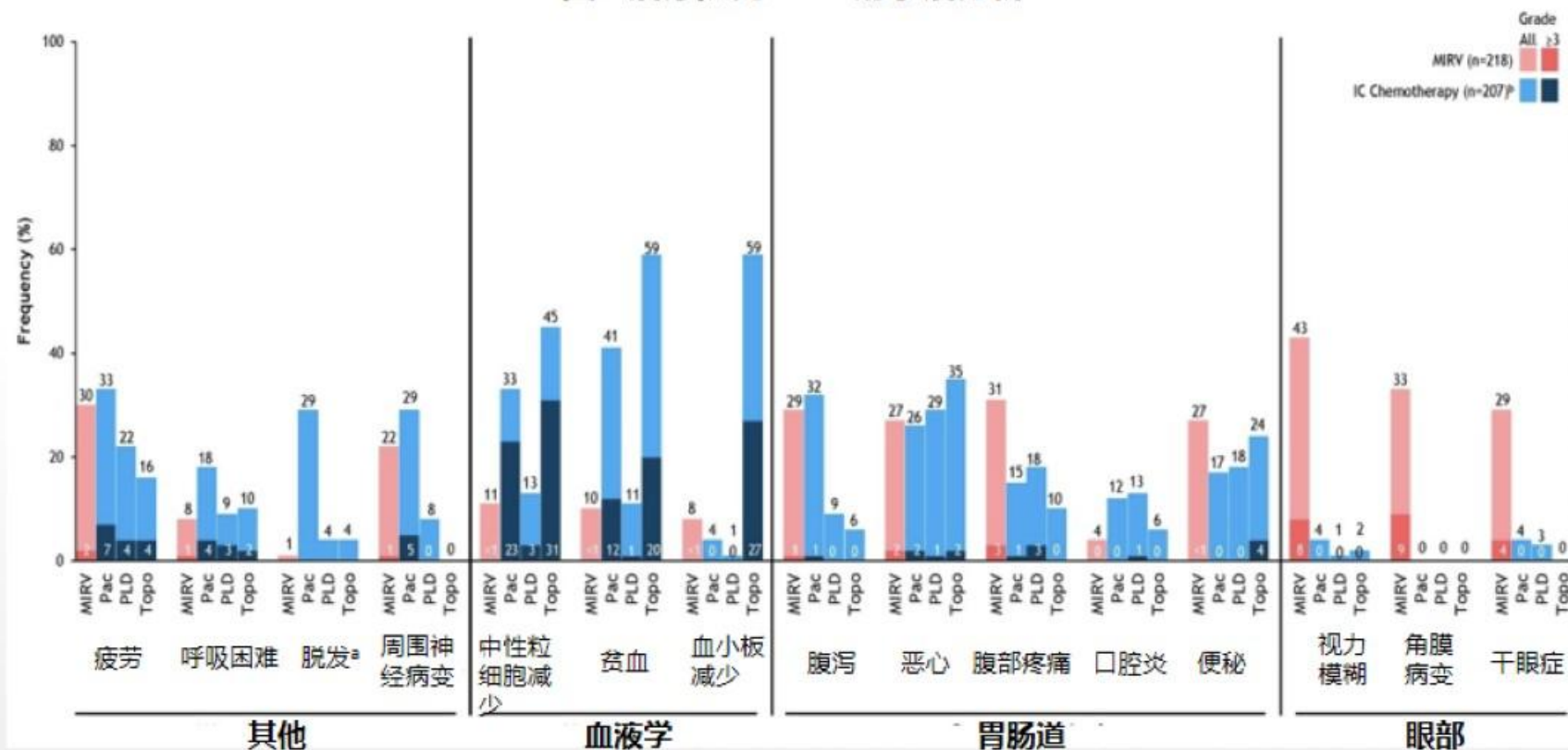
延长随访数据截止日期:2023年10月27日。

- 中位随访20.3m (范围, 19.3-21.4)。
- 到延长随访的数据截止日期, 更新的OS HR为0.67 (95% CI, 0.53-0.86, 名义 $p=0.0011$), MIRV相比于研究者选择的化疗更有利。

MIRASOL治疗队列更新的安全性



图3 治疗队列TEAE的事后分析



a 3级不适用于脱发; b Pac, n=82; PLD, n=76; Topo, n=49

□ 血液学、感觉神经、胃肠道及眼部TEAE的发生率在延长随访的数据截止日期和MIRASOL分析时一致。

MIRASOL更新的安全性总结

事件, n (%)	MIRV (n=218)	研究者选择的化疗 (n=207)
任何TEAE	210 (96)	194 (94)
≥3级TEAE	93 (43)	112 (54)
SAEs	55 (25)	68 (33)
治疗相关SAEs	21 (10)	16 (8)
因TEAEs导致剂量降低	75 (34)	50 (24)
因TEAEs导致给药延迟或暂停	121 (56)	111 (54)
因TEAE导致停药	22 (10)	33 (16)
给药期间或最后一次给药30天内死亡	9 (4)	11 (5)
TEAEs导致的死亡	4 (2)	5 (2)
TRAEs导致的死亡	0 ^a	1 (<1) ^b

数据截止日期2023年10月27日

a 在初次分析中报告了1例患者退出治疗后死亡，该表格未反映该事件。

b 在研究者选择的化疗组，1例接受拓扑替康治疗的患者因治疗相关的感染性休克死亡。

- 在延长随访的数据截止日期，没有发现新的安全性信号。
- 与接受研究者选择的化疗患者相比，接受MIRV的患者≥3级TEAEs (43% vs. 54%) 和SAEs (25% vs. 33%)的发生率更低。
- 与研究者选择的化疗相比，MIRV组患者剂量降低比例更高(34% vs. 24%)，但停药率更低(10% vs. 16%)。

研究结论



- 在铂耐药的卵巢癌（PROC）III期研究（MIRASOL研究；中位随访期13.1个月），MIRV是首个被证明OS获益优于化疗的新疗法。
- 中位随访20.3个月，MIRASOL试验延长数据截止日期的分析显示，在PROC中，MIRV与研究者选择的化疗相比，PFS、ORR和OS均有显著临床意义的改善。
 - 这些延长随访数据截止时的结果映射了初步分析中使用MIRV观察到的疗效获益。
- OS的HR在初次分析（HR, 0.67；中位随访，13.1个月）和延长数据截止时保持不变（HR, 0.67；中位随访，20.3个月）。
- MIRV观察到的疗效及其良好的安全性，支持MIRV作为FR α -阳性PROC患者的标准治疗。

氟唑帕利联合阿帕替尼对比氟唑帕利单药治疗复发性卵巢癌 (OC) 的II期研究

A phase 2 trial of fuzuloparib in combination with apatinib vs.
fuzuloparib alone for recurrent ovarian cancer (OC)

通讯作者：朱笕青

研究机构：浙江省肿瘤医院

研究背景



- 多项研究表明，聚二磷酸腺苷(ADP) 核糖聚合酶 (PARP) 抑制剂与抗血管生成药物联合治疗铂敏感和铂耐药复发性卵巢癌均有效¹⁻⁵。
- 氟唑帕利是一种口服的PARP抑制剂⁶。
- 阿帕替尼是一种口服高效酪氨酸激酶抑制剂，靶向血管内皮生长因子受体2 (VEGFR-2)⁷。
- 进行一项随机、对照、开放标签、多中心、II期试验，以进一步探讨氟唑帕利联合阿帕替尼与氟唑帕利单药治疗复发性OC患者的疗效和安全性。

1.Mirza MR,et al.Lancet Oncol 2019;20(10):1409-19 ; 2.Liu JF,et al.Lancet Oncol 2014;15(11):1207-14 ;3.Colombo N,et al.Gynecol Oncol 2022;164(3):505-13 ; 4.Nicum S,et al.Br J Cancer 2024;130(6):941-50; 5. Lee JM,et al.Clin Cancer Res 2022;28(19):4186-93; 6.Li H,et al.Chin J Cancer Res 2020;32(3):370-82; 7.Ding J,et al Drug Metab Dispos 2013;41(6):1195-210

研究设计



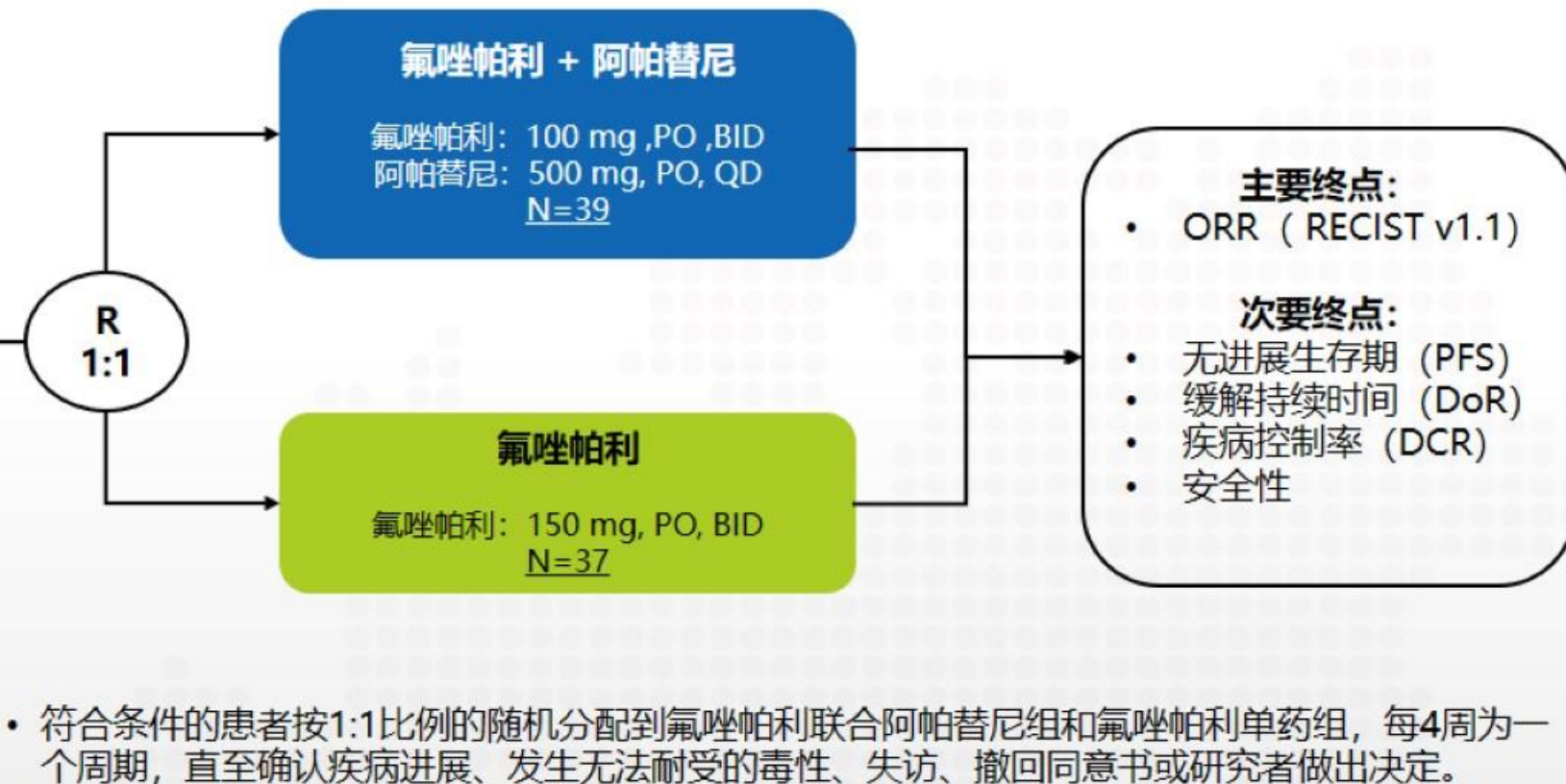
主要入组标准

- 病理学确认的高级别浆液性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌；
- 既往经过 ≥ 2 次含铂方案治疗；
- 原发性铂耐药（一线铂类化疗后 >1 至 <6 个月内进展/复发）也符合条件；
- 至少有一个可测量病灶；
- ECOG PS 0-1；
- 既往未使用过PARP抑制剂或阿帕替尼。

N=76

分层因素

- *gBRCA1/2* 突变（是与否）
- 最后一次铂类化疗到进展/复发的时间（ >1 至 <6 个月[铂耐药型] vs. 6至 <12 个月[铂敏感型]）。



1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04517357>
2. Jianqing Zhu, et al. 2024 ESMO 766P.

患者基线



➢ 2021年1月1日至2021年12月21日期间，共有76例患者入组（39例使用氟唑帕利联合阿帕替尼，37例使用氟唑帕利单药）。

➢ 截至2024年1月11日，没有患者仍在接受治疗。中位随访时间为22.1个月（13.8-29.6）。

	氟唑帕利+阿帕替尼 N=39	氟唑帕利 N=37
年龄，岁	55.0 (37-79)	54.0 (43-72)
ECOG 评分为 1	18 (46.2%)	19 (51.4%)
肿瘤类型		
卵巢癌	35 (89.7%)	34 (91.9%)
输卵管癌	4 (10.3%)	2 (5.4%)
原发性腹膜癌	0	0
其他	0	1 (2.7%)
组织学类型		
浆液性	39 (100.0%)	36 (97.3%)
子宫内膜样	0	1 (2.7%)
<i>gBRCA1/2</i> 突变		
是	11 (28.2%)	10 (27.0%)
否	28 (71.8%)	27 (73.0%)

	氟唑帕利+阿帕替尼 N=39	氟唑帕利 N=37
末次铂类化疗到进展/复发的时间		
6≤x<12个月（铂敏感）	12 (30.8%)	12 (32.4%)
1<x<6个月（铂耐药）	27 (69.2%)	25 (67.6%)
既往铂类化疗线数		
1	9 (23.1%)	10 (27.0%)
2	19 (48.7%)	9 (24.3%)
3	9 (23.1%)	12 (32.4%)
≥4	2 (5.1%)	6 (16.2%)
既往VEGFR抑制剂使用史		
是	13 (33.3%)	7 (18.9%)
否	26 (66.7%)	30 (81.1%)

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04517357>

2. Jiangqin Zhu, et al. 2024 ESMO 766P.

研究结果

根据RECIST v1.1评估的所有患者的肿瘤缓解

	氟唑帕利+阿帕替尼 N=39	氟唑帕利 N=37
BOR		
CR	1 (2.6%)	1 (2.7%)
PR	14 (35.9%)	12 (32.4%)
SD	19 (48.7%)	14 (37.8%)
PD	5 (12.8%)	10 (27.0%)
ORR	15 (38.5%, 23.36-55.38)	13 (35.1%, 20.21-52.54)
DCR	34 (87.2%, 72.57-95.70)	27 (73.0%, 55.88-86.21)

氟唑帕利联合阿帕替尼的ORR为38.5%，而氟唑帕利为35.1%（差异=3.3%；95%CI，-18.35至25.00；单侧p=0.7322），DCR分别为87.2%和73.0%。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04517357>
2. Jianqing Zhu, et al. 2024 ESMO 766P.



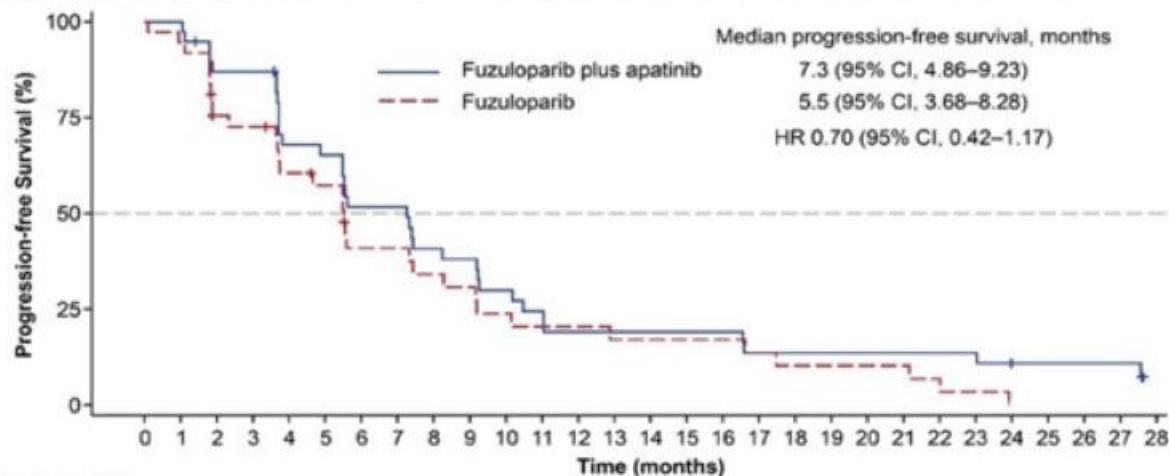
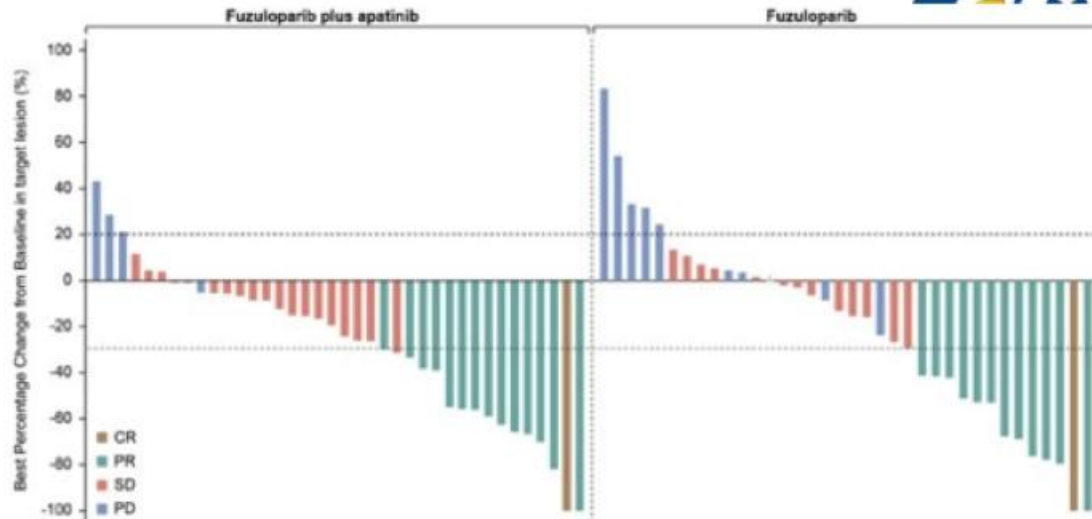
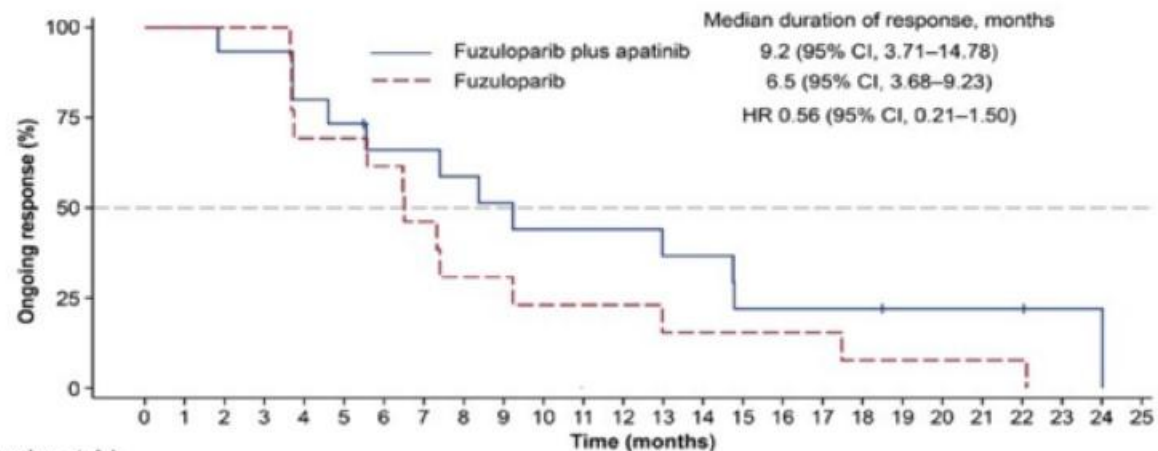
ORR亚组分析

	氟唑帕利+阿帕替尼	氟唑帕利	差值, % (95% CI)
<i>gBRCA 1/2</i> 突变			
是	63.6% (7/11;30.79-89.07)	60.0% (6/10;26.24-87.84)	3.6% (-37.96-45.23)
否	28.6% (8/28;13.22-48.67)	25.9% (7/27;11.11-46.28)	2.6% (-20.88-26.17)
末次铂类化疗到进展/复发的时间			
6≤x<12个月 (铂敏感)	58.3% (7/12;27.67-84.83)	66.7% (8/12;34.89-90.08)	-8.3% (-46.93-30.26)
1<x<6个月 (铂耐药)	29.6% (8/27;13.75-50.18)	20.0% (5/25;6.83-40.70)	9.6% (-13.66-32.92)
既往VEGFR抑制剂使用史			
是	15.4% (2/13;1.92-45.45)	28.6% (2/7;3.67-70.96)	-13.2% (-51.98-25.60)
否	50.0% (13/26;29.93-70.07)	36.7% (11/30;19.93-56.14)	13.3% (-12.49-39.15)

在铂类耐药OC患者中，氟唑帕利联合阿帕替尼组的ORR为29.6%，氟唑帕利组为20.0%，在既往未使用VEGFR抑制剂的患者中，ORR分别为50.0%和36.7%。

研究结果

两组靶病灶与基线相比的最佳变化



- 氟唑帕利联合阿帕替尼的中位DoR为9.2个月，而氟唑帕利为6.5个月 (HR=0.56; 95%CI, 0.21-1.50;) ;
- 34例 (87.2%) 使用氟唑帕利联合阿帕替尼的患者和32例 (86.5%) 使用氟唑帕利单药的患者病情进展或死亡。氟唑帕利联合阿帕替尼组的中位无进展生存期为7.3个月，而氟唑帕利组为5.5个月 (HR=0.70; 95%CI, 0.42-1.17; 单侧p=0.1743) 。

安全性



	氟唑帕利+阿帕替尼 N=39		氟唑帕利 N=37	
	任意级别	3-5级	任意级别	3-5级
任意	39 (100.0%)	24 (61.5%)	37 (100.0%)	15 (40.5%)
高血压	18 (46.2%)	5 (12.8%)	0	0
贫血	17 (43.6%)	6 (15.4%)	20 (54.1%)	12 (32.4%)
呕吐	17 (43.6%)	0	9 (24.3%)	0
血小板计数下降	16 (41.0%)	4 (10.3%)	16 (43.2%)	8 (21.6%)
白细胞计数下降	16 (41.0%)	2 (5.1%)	19 (51.4%)	1 (2.7%)
恶心	15 (38.5%)	0	17 (45.9%)	0
乏力	13 (33.3%)	1 (2.6%)	7 (18.9%)	1 (2.7%)
AST升高	12 (30.8%)	0	5 (13.5%)	0
头疼	12 (30.8%)	0	3 (8.1%)	1 (2.7%)
中性粒细胞计数下降	11 (28.2%)	3 (7.7%)	13 (35.1%)	1 (2.7%)
食欲下降	10 (25.6%)	2 (5.1%)	13 (35.1%)	0
血肌酐升高	6 (15.4%)	0	12 (32.4%)	0

两组100%的患者都发生了治疗相关不良事件 (TRAE)。在氟唑帕利联合阿帕替尼组和氟唑帕利单药组中，61.5%和40.5%的患者发生了3级或更高级别的TRAE，最常见的TRAE分别是贫血（15.4%，32.4%）、高血压（12.8%，0）和血小板计数减少（10.3%，21.6%）。

研究总结



- 对于复发性卵巢癌患者，氟唑帕利联合阿帕替尼联合治疗以及单独使用氟唑帕利都是有效且可行的。氟唑帕利联合阿帕替尼与氟唑帕利单药相比，在铂耐药性或既往无VEGFR抑制剂治疗的卵巢癌患者中，ORR有改善的趋势。



SHR-A1921治疗铂耐药卵巢癌（PROC）的首次人体（FIH）I期研究数据

SHR-A1921 in platinum-resistant ovarian cancer(PROC):data from a first-in-human phase 1 study

通讯作者：唐迪红

研究机构：湖南省肿瘤医院

研究背景



□ 铂耐药卵巢癌 (PROC) :

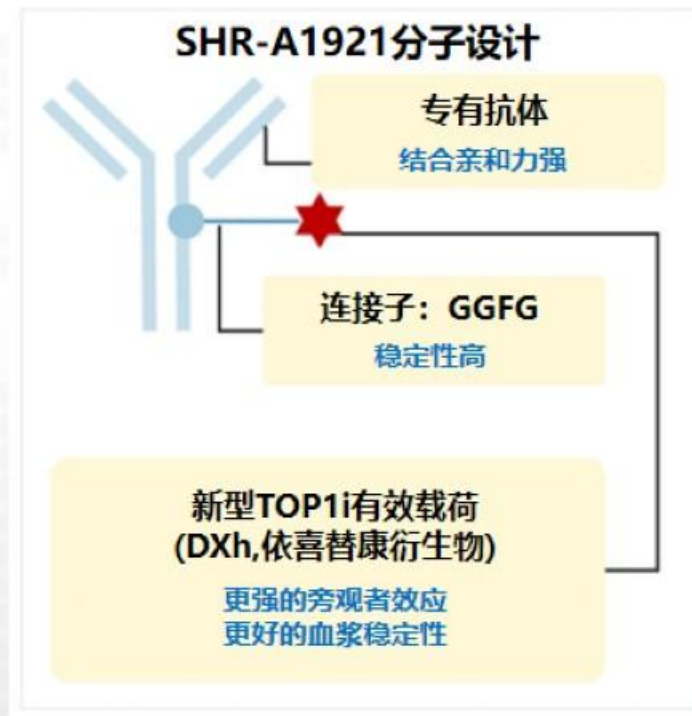
- 初诊并接受含铂化疗的上皮卵巢癌患者，近85%会出现耐药。¹
- PROC预后较差，既往接受过全身治疗的患者有效治疗选择有限

□ SHR-A1921是一种新型抗体药物偶联物:

- 由人源化抗Trop-2 IgG1单克隆抗体与DNA拓扑异构酶I抑制剂(payload, DXh)通过四肽可切割连接子(GGFG)连接组成。

□ SHR-A1921用于经治晚期癌症:

- 这是一项剂量递增、剂量扩展和疗效扩展的I期研究(NCT05154604)。
- 确定最大耐受剂量为4.0 mg/kg Q3W.²
- 针对PROC，采用3.0 mg/kg Q3W和2.0 + 2.0mg/kg Q3W进行剂量优化。



1. J Clin Oncol.2024 Jan 10; 42(2):127-133.

2.AACR 2023, Presentation Number:CT181

PROC队列设计



主要入组标准

- 1.组织学证实的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌、原发性腹膜癌；
- 2.在铂类药物治疗期间或完成后6个月内出现疾病进展；
- 3.能够提供肿瘤组织进行TROP-2表达水平检测；
- 4.有可测量病灶（RECIST v1.1）；
- 5.ECOG PS 0-1；
- 6.预期生存12周及以上；
- 7.器官功能充足。

SHR-A1921 3.0mg/kg iv
第1天, 21天一个周期 (3.0mg/kg)

SHR-A1921 2.0mg/kg iv
第1天和第8天, 21天一个周期((2.0+2.0 mg/kg)

治疗持续到疾病进展、不可接受的毒性、受试者退出或研究者决定为止。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>
2. Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

受试者分布



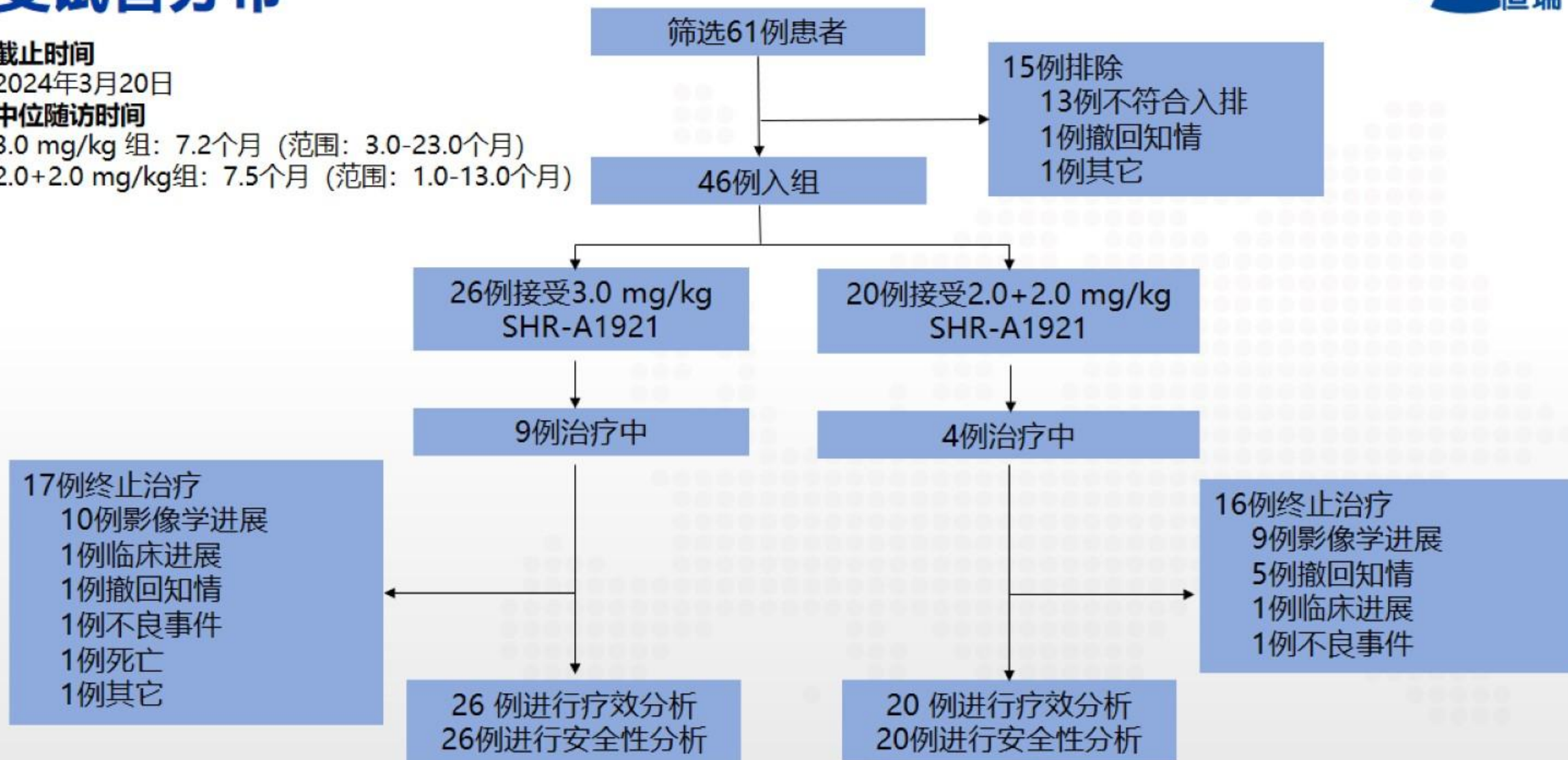
截止时间

2024年3月20日

中位随访时间

3.0 mg/kg 组: 7.2个月 (范围: 3.0-23.0个月)

2.0+2.0 mg/kg组: 7.5个月 (范围: 1.0-13.0个月)



1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>

2. Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

基线特征



	3.0 mg/kg (n=26)	2.0+2.0 mg/kg (n=20)
中位年龄, 岁(范围)	55.0(40-71)	54.0(38-61)
ECOG评分, n(%)		
0	1 (3.8)	1 (3.8)
1	25(96.2)	19(95.0)
原发肿瘤诊断, n(%)		
卵巢癌	25(96.2)	20(100.0)
输卵管癌	1 (3.8)	0
组织学类型, n(%)		
浆液性癌	19(73.1)	16(80.0)
透明细胞癌	4 (15.4)	1 (5.0)
粘液性癌	2 (7.7)	1 (5.0)
其它	1 (3.8)	2 (10.0)
既往进行肿瘤手术, n(%)		
是	24 (92.3)	20(100.0)
否	2 (7.7)	0
铂耐药类型*, n(%)		
原发性铂耐药	11(42.3)	7(35.0)
继发性铂耐药	15(57.7)	13(65.0)

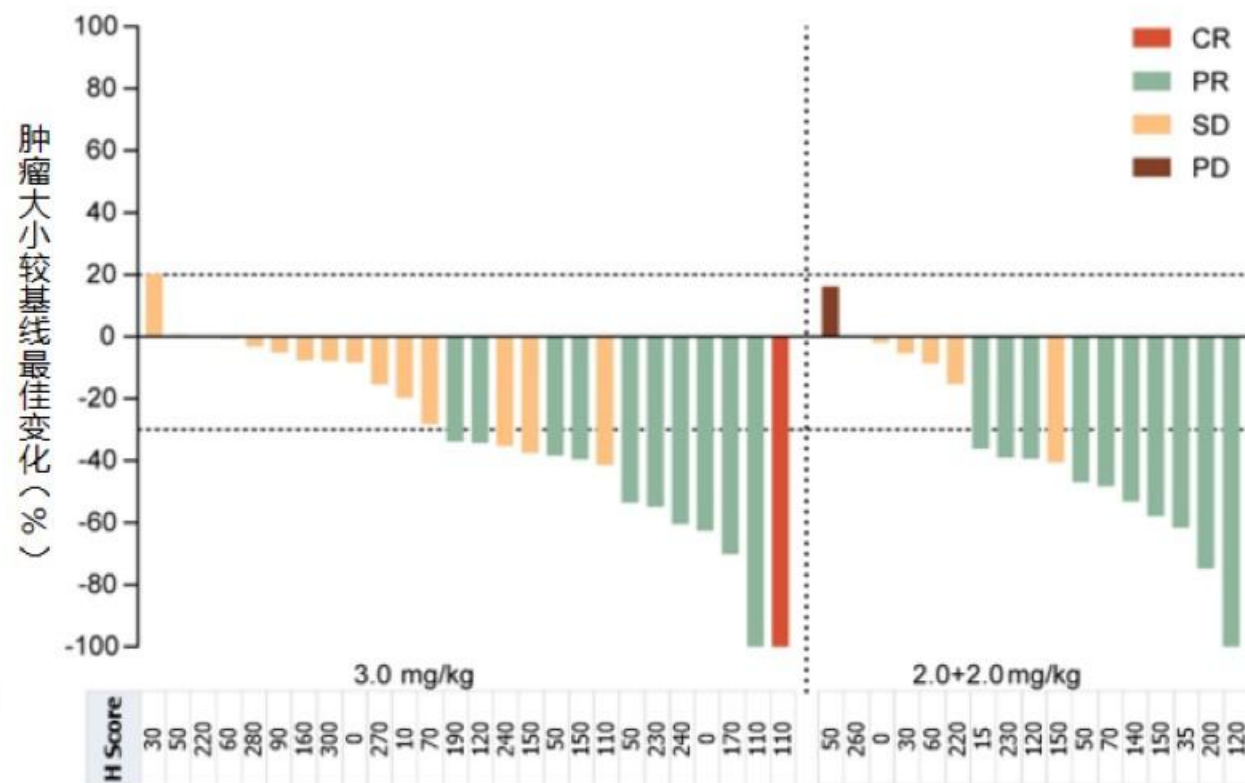
	3.0 mg/kg (n=26)	2.0+2.0 mg/kg (n=20)
末次含铂化疗的无铂间期, n (%)		
≤4周	7 (26.9)	9 (45.0)
≥4周到 < 6个月	19 (73.1)	11 (55.0)
前线治疗线数, n (%)		
1	2 (7.7)	3 (15.0)
2	5(19.2)	7(35.0)
3	9(34.6)	3 (15.0)
≥4	10(38.5)	7(35.0)
既往系统治疗, n (%)		
含铂化疗	26(100.0)	20(100.0)
贝伐珠单抗	20(76.9)	12 (60.0)
PARP抑制剂	17 (65.4)	10 (50.0)
TROP-2表达#, n (%)		
高: 200< H-score ≤300	7 (26.9)	4(20.0)
中: 100≤ H-score <200	9(34.6)	6(30.0)
低: 0≤ H-score <100	10(38.5)	10(50.0)

*: 原发性铂耐药定义为一线铂类化疗期间或化疗结束后6个月内复发。继发性铂耐药定义为二线或后线铂基化疗期间或化疗结束后6个月内复发。

#: H-score=(3 x%告强度染色细胞)+(2x%中等强度染色)+(1x%轻度染色细胞)

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>
2. Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

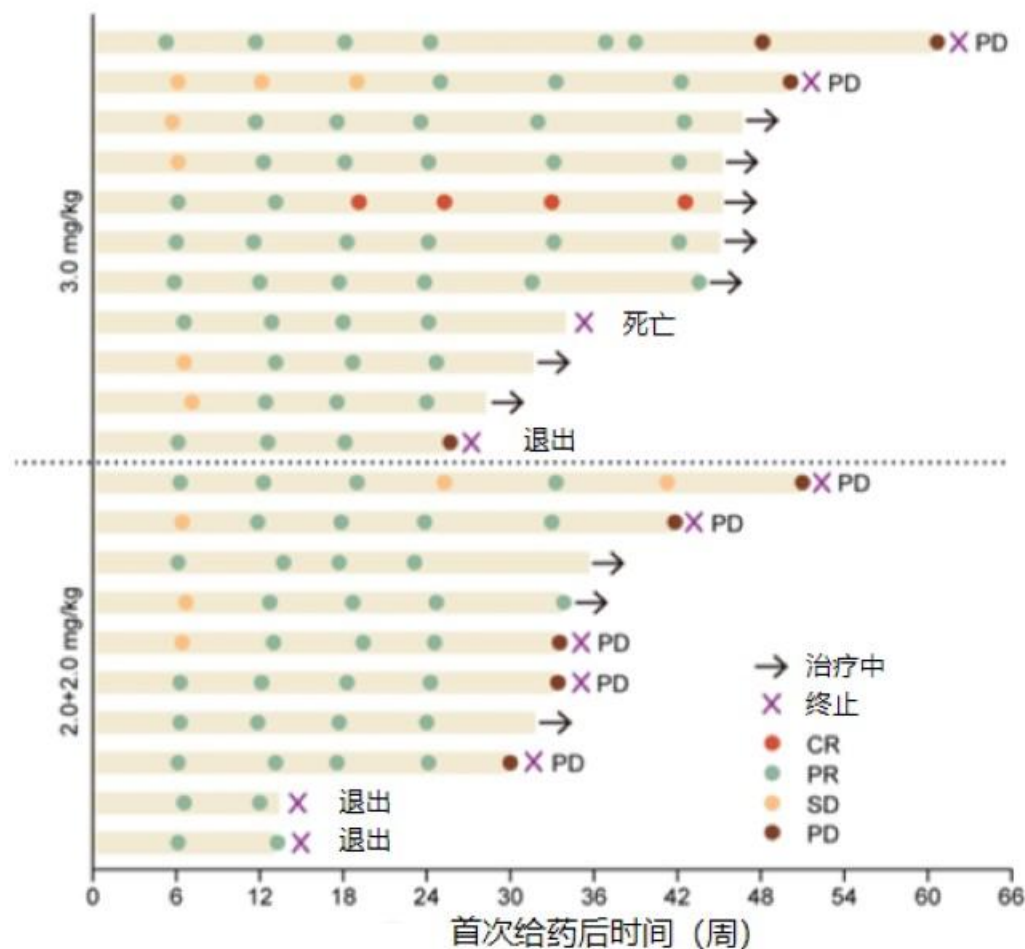
肿瘤响应



	3.0 mg/kg (n=26)	2.0+2.0 mg/kg (n=20)
可评估, N	26	17
最佳整体疗效评估, n (%)		
CR	1 (3.8)	0
PR	10 (38.5)	10 (58.8)
SD	15 (57.7)	6 (35.3)
PD	0	1 (5.9)
ORR, % (95% CI)	42.3 (23.4-63.1)	58.8 (32.9-81.6)
DCR, % (95% CI)	100.0 (86.8-100.0)	94.1 (71.3-99.9)

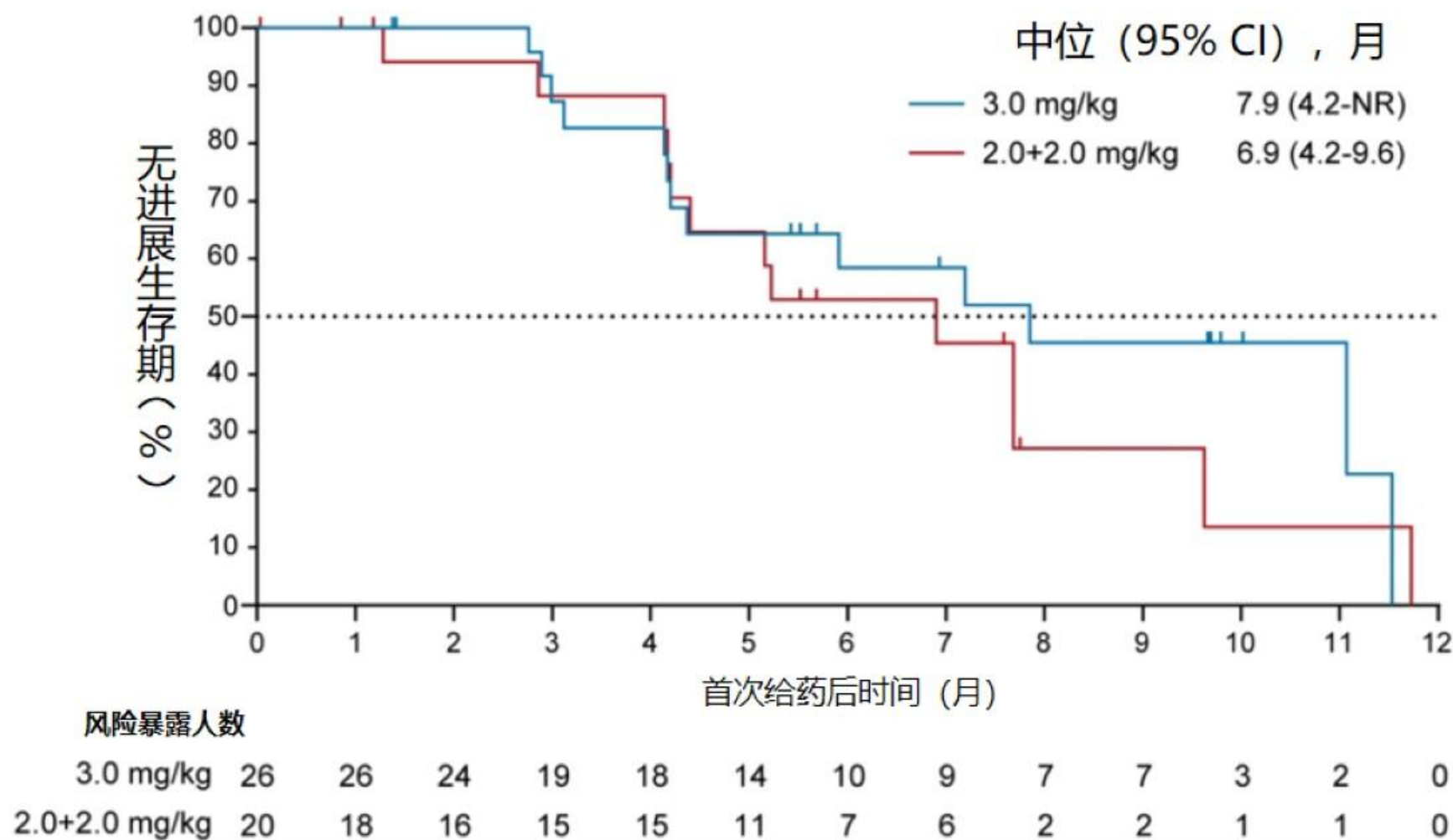
- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>
- Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

肿瘤响应



	3.0 mg/kg (n=26)	2.0+2.0 mg/kg (n=20)
DoR (月), 中位 (95% CI)	9.9 (4.5-NR)	6.3 (3.0-NR)

- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>
- Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

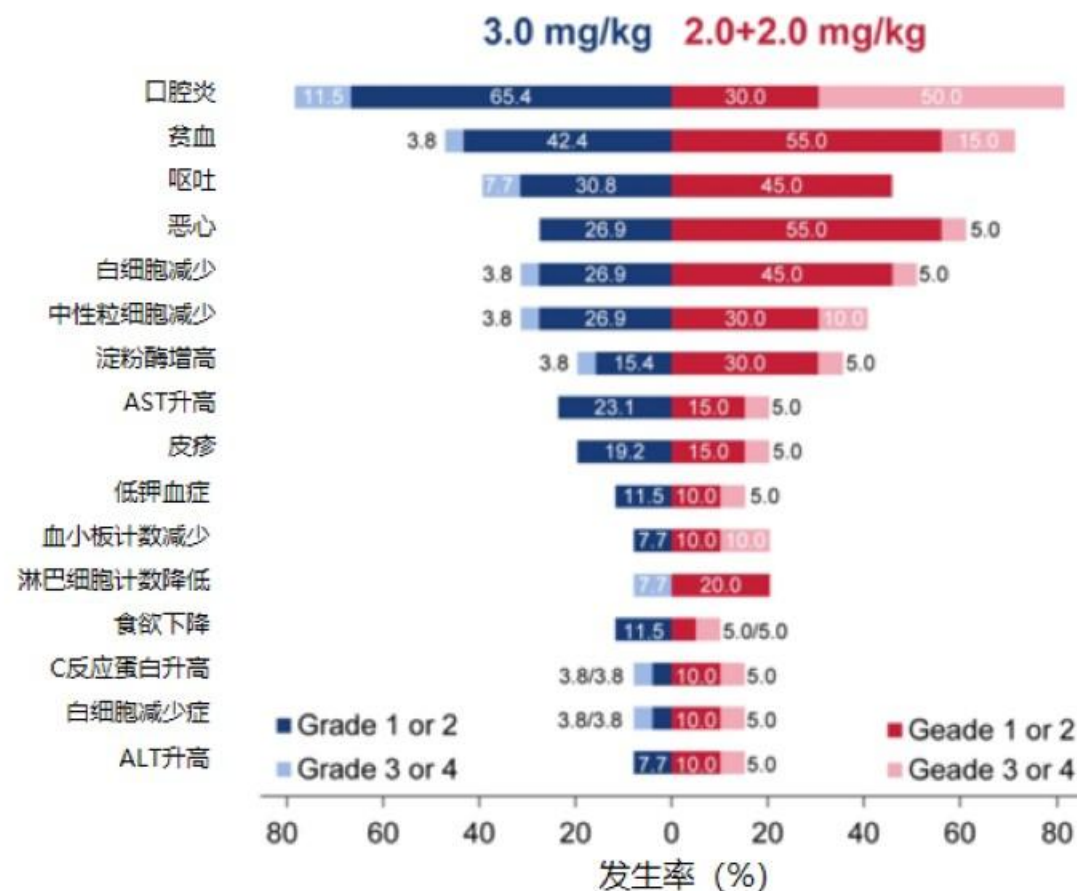


1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>
2. Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

安全性



	3.0 mg/kg (n=26)	2.0+2.0 mg/kg (n=20)
TRAEs, n (%)		
任意级别	26(100.0)	20(100.0)
3-4级	11 (42.3)	12 (60.0)
导致治疗中断	10(38.5)	13 (65.0)
导致剂量降低	6 (23.1)	6(30.0)
导致治疗终止	0	1 (5.0)
严重	4(15.4)	7 (35.0)
导致死亡	0	0



在接受至少1次SHR-A1921治疗的患者中发生的3或4级TRAEs如图所示

TRAE: 治疗相关不良反应 AST: 天门冬氨酸氨基转移酶 ALT: 丙氨酸氨基转移酶

- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>
- Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

研究结论



□ SHR-A1921在经多线治疗的PROC患者中显示出良好的疗效

-ORR: 3.0 mg/kg组为42.3%, 2.0+2.0 mg/kg组为58.8%

-中位DoR: 3.0 mg/kg组为9.9个月, 2.0+2.0 mg/kg组为6.3个月

-中位PFS: 3.0 mg/kg组为7.9个月, 2.0+2.0 mg/kg组为6.9个月

□ SHR-A1921 在PROC患者队列的安全性是可控的

□ 一项关键的3期研究正在进行中(NCT06394492)

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05154604>
2. Dihong Tang, et al. 2024 ESMO 717MO.

Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) 在子宫内膜癌 (EC) 或卵巢癌 (OC) 患者中的应用: II期TROPION-PanTumor03 研究结果

Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) in patients with Ovarian or
Endometrial Cancer: Results from the Phase2 TROPION-PanTumor03 Study

通讯作者: Ana Oaknin

研究机构: Vall d' Hebron Barcelona Hospital Campus, Barcelona, Spain

研究背景



□ TROP2是一种跨膜蛋白，在大多数卵巢癌和子宫内膜癌中高度表达¹。

□ Dato-DXd是一种靶向TROP2的抗体偶联药物 (ADC)，它能够将一种有效的拓扑异构酶I抑制剂有效载荷输送到肿瘤细胞中²，并且具有几个独特的特性：*

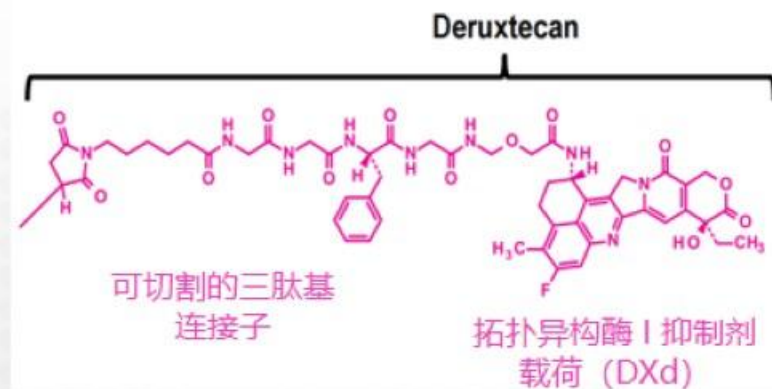
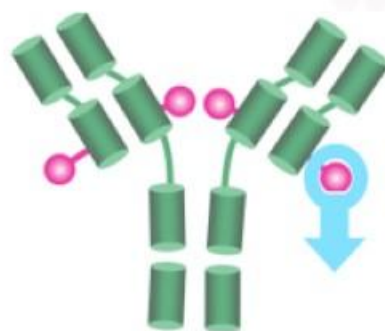
- 优化的药物与抗体比率约为4[†]
- 血浆稳定，肿瘤选择性可切割的连接子-有效载荷
- 有效载荷具有高效性和短的系统半衰期[†]
- 有旁观者抗肿瘤效应

□ 在III期临床试验中，Dato-DXd已经显示出对于经预治疗的非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者和HR+/HER2-乳腺癌患者的临床相关的疗效和可管理的安全性^{3,4}。

*这些特性的临床相关性正在研究中。[†]基于动物数据。

ADC, 抗体偶联药物; Dato-DXd, datopotamab deraxtecan; HR+, 激素受体阳性; HER2-, 人表皮生长因子受体2阴性; IgG, 免疫球蛋白G; NSCLC, 非小细胞肺癌; TROP2, 滋养层细胞表面抗原2; Topo-I, 拓扑异构酶I。

Dato-DXd: 人源抗TROP2 IgG1单克隆抗体⁵



图像仅供示意参考，实际药物位置可能会有所不同

1. Shvartsure A, et al. Genes Cancer 2015;6:84-105; 2. Okaima D, et al. Mol Cancer Ther 2021;20:2329-40; 3. Ahn M-J, et al. Ann Oncol 2023; 34:s1665-66; 4. Bardia A. et al. Ann Oncol 2023;34(suppl 2):81264-5; 5. Dent R, et al. Future Oncol 2024;19:2349-59.

TROPION-PanTumor03: 研究设计

□ 一项II期、开放标签、全球性研究 (NCT05489211)，评估Dato-DXd单药治疗以及与多种抗癌药物联合治疗多种肿瘤中的疗效。

□ 本次报告展示了Dato-DXd单药治疗在卵巢癌和子宫内膜癌队列中的研究结果。

卵巢癌 (未限制TROP2表达)

- 高级别浆液性或内膜样卵巢、输卵管或原发性腹膜癌
- ECOG PS 0或1
- 在经过至少1线含铂化疗但不超过2线针对晚期或转移性癌症的治疗后进展；铂敏感和铂耐药都可以。

子宫内膜癌 (未限制TROP2表达)

- 晚期/转移性子官内膜癌
- 所有组织学类型 (肉瘤除外)
- ECOG PS 0或1
- 在经过至少1线含铂化疗但不超过2线针对晚期或转移性癌症的治疗后进展。

N=35

Dato-DXd[†]
6 mg/kg IV Q3W

N=40

主要研究终点

- 研究者基于RECIST v1.1评估的ORR
- 安全性&耐受性

次要研究终点

- 研究者评估的PFS, DoR, DCR
- PK和免疫原性

探索性终点

- OS
- 生物标志物分析

*铂敏感定义为在完成铂类药物化疗后≥6个月出现复发/进展；铂耐药定义为在铂类药物化疗后<6个月出现进展，包括在铂类药物化疗期间或3个月内进展的原发耐药患者（IMG采用修改后的定义）。

[†]患者继续接受治疗，直到他们满足以下任一停药标准：疾病进展、不可接受的毒性、撤回同意或研究终止。

根据方案，为所有患者在开始使用Dato-DXd之前都提供了每日口腔护理方案以预防口腔炎；强烈推荐含有类固醇的漱口水。

DCR, 疾病控制率；DoR, 缓解持续时间；ECOG PS, 东部肿瘤协作组体能状态评分；IMG, 国际医学毕业生；IV, 静脉注射；ORR, 客观缓解率；OS, 总生存期；PFS, 无进展生存期；PK, 药代动力学；Q3W, 每3周；RECIST v1.1, 实体瘤的疗效评价标准版本1.1。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05489211>

2. Ana Oaknin, et al. 2024 ESMO 714 MO.

基础特征和人口统计



特征		卵巢癌(N=35)	子宫内膜癌(N=40)
年龄	中位值 (范围),年	61.0(35-80)	66.5(48-78)
种族, n (%)	亚洲	8(22.9)	16(40.0)
	白种人	23(65.7)	18(45.0)
	其他或未报道	4(11.4)*	6(15.0)*
ECOG PS, n (%)	0	21(60.0)	25(62.5)
	1	14(40.0)	15(37.5)
主要病理学类型, n (%)	高级别子宫内膜样	0(0.0)	11(27.5)
	高级别浆液性	27(77.1)	10(25.0)
	低级别子宫内膜样	0(0.0)	7(17.5)
	透明细胞癌	6(17.1)	3(7.5)
	其他†	2(5.7)	9(22.5)
既往治疗线数, n (%) §	1	11(31.4)	29(72.5)
	≥2	24(68.6)	11(27.5)
既往治疗, n (%) †	铂类治疗	35(100)	40(100)
	贝伐珠单抗/仑伐替尼	25(71.4)	8(20.0)
	PARP抑制剂	18(51.4)	1(2.5)
	免疫治疗	2(5.7)	9(22.5)
	激素疗法	0 (0.0)	5(12.5)
铂敏感性	铂耐药‡	26(74.3)	—
	铂敏感	9(25.7)	—

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05489211>
2. Ana Oaknin, et al. 2024 ESMO 714 MO.

*包括其他 (n=1), 缺失 (n=1) 和未报告 (n=2); †包括美国印第安人或阿拉斯加原住民 (n=1), 黑人或非裔美国人 (n=1), 未报告 (n=3) 和缺失 (n=1); ‡包括肉瘤癌; §接受过多线治疗的患者仅在更高线治疗方案下统计。在晚期或转移性疾病中, 允许不超过2线之前的系统治疗, 新辅助/辅助在卵巢队列中视为同一线治疗; ‖患者可以在多行中统计, 因为可以采取多种治疗。在每一行中, 患者只统计一次; †包括患有铂耐药的患者, 定义为铂类药物治疗后3个月内病情进展。PARP, 多聚ADP核糖聚合酶。

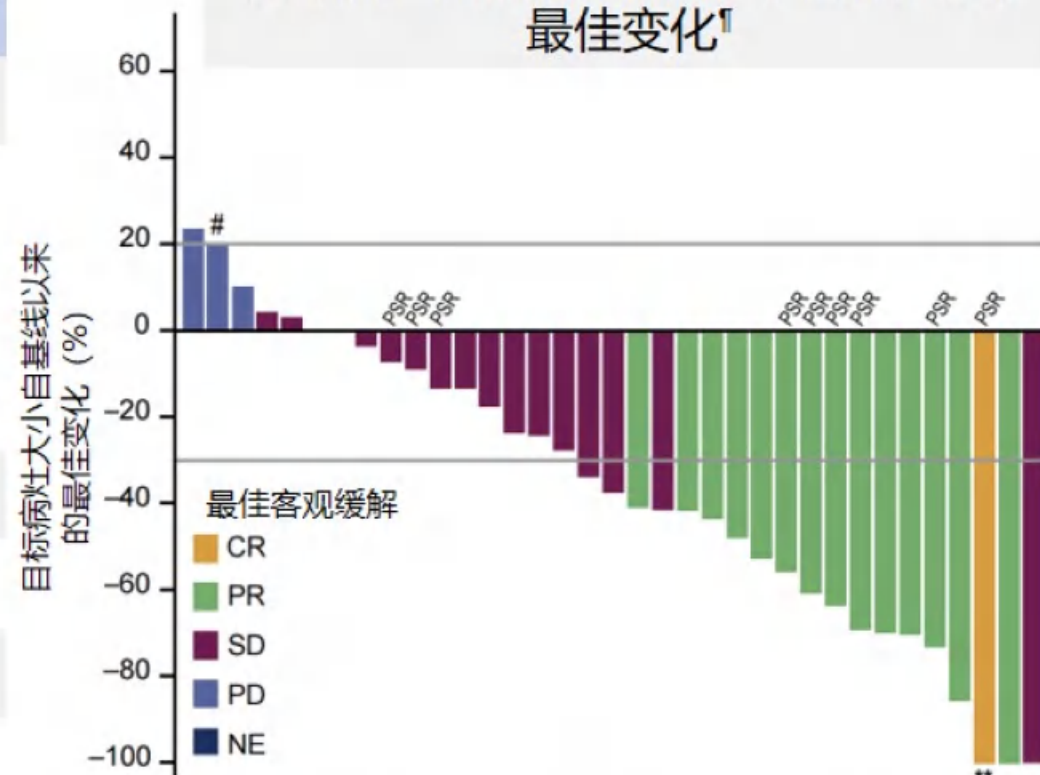
卵巢癌队列有效性



- 截至2024年6月14日，卵巢癌队列的中位随访时间*为14.5个月(范围10.4-15.4)

	卵巢癌		
	总体(N=35)	铂敏感(n=9)	铂耐药(n=26)
确认的ORR,%(95%CI)	42.9 (26.3-60.6)	66.7 (29.9-92.5)	34.6 (17.2-55.7)
最佳肿瘤缓解, n(%)			
CR	1(2.9)	1(11.1)	0(0.0)
PR	14(40.0)	5(55.6)	9 (34.6)
SD [†]	17(48.6)	3(33.3)	14(53.8)
PD [‡]	3(8.6)	0(0.0)	3(11.5)
NE [§]	0 (0.0)	0(0.0)	0(0.0)
至缓解的中位时间, 月 (范围)	1.4 (1.2-8.2)	-	-
中位DoR, 月 (95%CI)	5.7 (2.9-NC)	8.5 (2.7-NC)	5.6 (2.9-NC)
12周DCR率, % (80%CI)	85.7 (75.1-92.9)	100 (77.4-100.0)	80.8 (67.2-90.3)
中位PFS, 月 (95%CI)	5.6 (4.1-7.0)	-	-

瀑布图：目标病灶大小自基线以来的最佳变化[¶]



- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05489211>
- Ana Oaknin, et al. 2024 ESMO 714 MO.

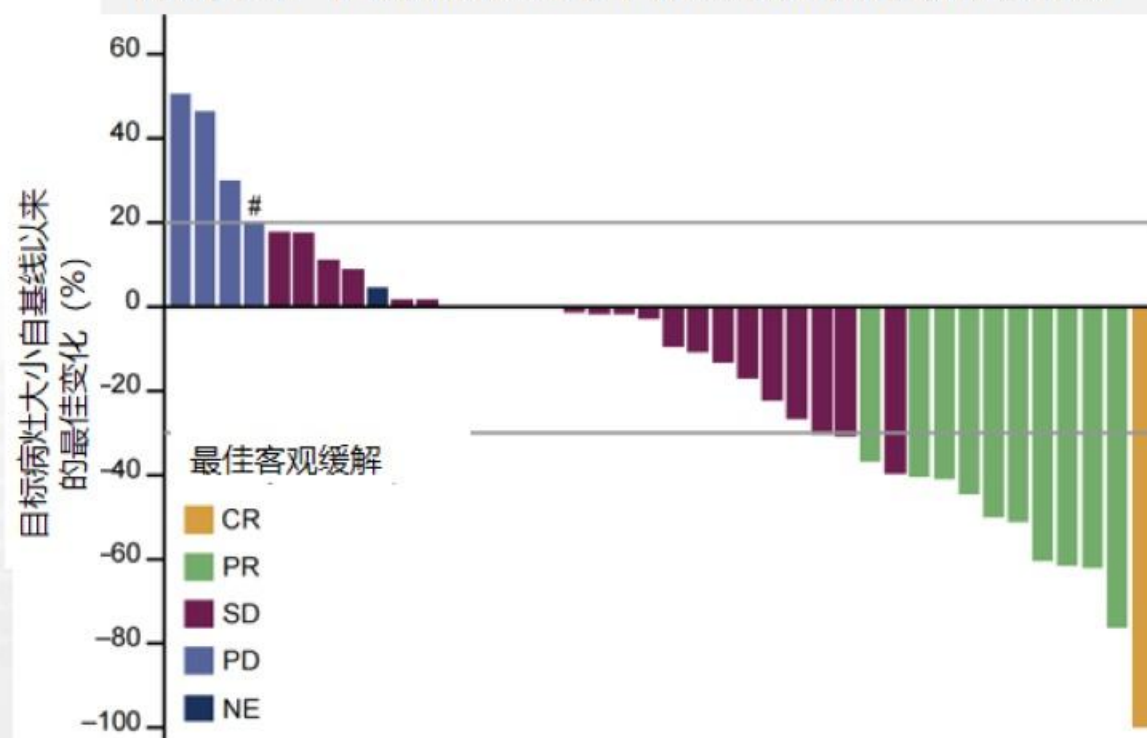
*随访时间计算为从随机化到截止日期的中位时间，在仅截止的患者中计算；[†]未确认的CR/PR，或SD ≥35天；[‡]根据RECIST标准评估的进展或死亡 ≤13周；[§]SD <35天，没有有效的基线评估或可评估的随访评估；[¶]定义为达到CR、PR或SD的患者百分比；[‡]目标病灶大小的最佳变化是从基线的最大减少或在没有减少的情况下的最小增加。-30%和20%的线条分别表示PR和PD的阈值。如果由于缺少数据无法计算最佳百分比变化，在以下情况中将+20%作为最佳百分比变化（否则保留为缺失）：患者没有基线后评估，已经死亡，有新病灶或病灶进展，或因PD退出且没有可评估的目标病灶数据。带有估算值的患者用#标记；**患者在第一次访视时达到随访PR（目标病灶从基线变化100%），在随后的两次就诊时为PD，因此是未确认的PR并被归类为SD。CI，置信区间；CR，完全缓解；NC，无法计算；NE，无法评估；PD，疾病进展；PR，部分缓解；PSR，铂敏感复发；SD，疾病稳定。

子宫内膜癌队列有效性

- 截至2024年6月14日，子宫内膜癌队列的中位随访时间*为13.6个月(范围2.1-19.6)

	子宫内膜癌(N=40)
确认的ORR,%(95%CI)	27.5(14.6-43.9)
最佳肿瘤缓解, n(%)	
CR	1(2.5)
PR	10(25.0)
SD [†]	23(57.5)
PD [‡]	5(12.5)
NE [§]	1 (2.5)
至缓解的中位时间, 月 (范围)	2.8(1.4-4.2)
中位DoR, 月(95%CI)	16.4 (7.1-NC)
12周DCR率, %(80%CI)	57.5 (46.1-68.3)
中位PFS, 月(95%CI)	6.3 (2.8-NC)

瀑布图：目标病灶大小自基线以来的最佳变化[¶]



*随访持续时间计算为从随机化到截止日期的中位时间，仅针对被截止的患者；[†]未确认的完全缓解 (CR) /部分缓解 (PR)，或疾病稳定 (SD) ≥ 35 天；[‡]根据RECIST标准，疾病进展或死亡 ≤ 13 周；[§]疾病稳定 (SD) < 35 天，没有有效的基线评估或可评估的随访评估；[¶]定义为达到CR、PR或SD的患者百分比；[¶]目标病灶大小的最佳变化是从基线的最大减少，或在未减少的情况下的最小增加。-30%和20%的线条分别表示PR和疾病进展 (PD) 的阈值。如果由于缺少数据无法计算最佳百分比变化，在以下情况下将+20%作为最佳百分比变化（否则保留为缺失）：患者没有基线后的评估，已经死亡，有新病灶或病灶进展，或因PD退出且没有可评估的目标病灶数据。带有估算值的患者用#标记。

- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05489211>
- Ana Oaknin, et al. 2024 ESMO 714 MO.

安全性总结



- Dato-DXd在卵巢组的中位治疗持续时间*为5.6个月(1.4-14.8)，在子宫内膜组的中位治疗持续时间为5.2个月(0.7-19.3)

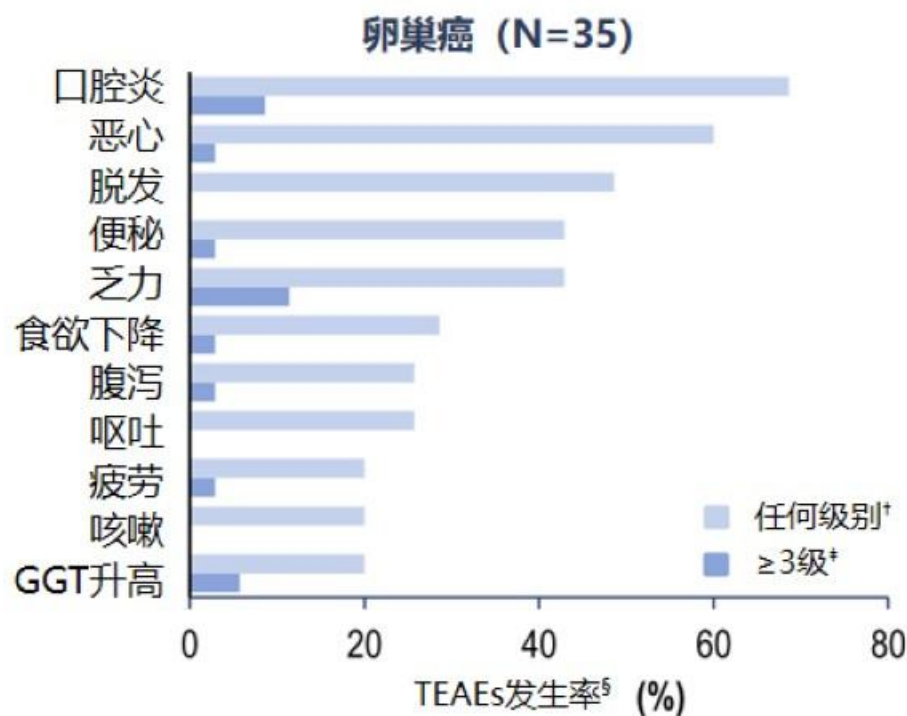
TEAEs, n(%) [†]	卵巢癌(N=35)	子宫内膜癌(N=40)
所有级别	35(100.0)	39(97.5)
≥3级 [‡]	19(54.3)	23(57.5)
严重	10 (28.6)	11(27.5)
导致		
剂量减少 [§]	13 (37.1)	10(25.0)
剂量中断	16 (45.7)	14(35.0)
停药 [¶]	2 (5.7)	3(7.5)
死亡	0 (0)	0 (0)

*实际治疗持续时间，定义为总治疗持续时间（从研究药物首次给药记录到研究停药日期、死亡日期、数据截止日期中最早的一个）减去中断的总持续时间；[†]在同一类别中有多个事件的患者，在该类别中仅计算一次。在多个类别中有事件的患者，在每个相关类别中各计算一次；[‡]根据常见不良事件术语标准（CTCAE）v5.0；[§]两个队列中剂量减少的最常见原因是口腔炎（卵巢队列：n=4；子宫内膜队列：n=7）；^{||}卵巢队列中剂量中断的最常见原因为点状角膜炎（n=2）、视力模糊（n=2）和口腔炎（n=2）；子宫内膜队列中为COVID-19（n=2）、角膜炎（n=3）和淀粉酶增加（n=2）；[¶]停药原因为卵巢队列中的肺炎（n=2）和子宫内膜队列中的晕厥（n=1）、干眼症和溃疡性角膜炎（n=1）以及间质性肺病（n=1）。ILD，间质性肺病；TEAEs，治疗中出现的不良事件。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05489211>
2. Ana Oaknin, et al. 2024 ESMO 714 MO.

最常见的TEAEs

- 两个队列中最常见的TEAEs是口腔炎*和恶心，其中大多数为1-2级。
- 在每个队列中各有1例患者出现被判定与药物相关的ILD*，两例均为3级。
- 卵巢和子宫内膜队列中，眼表事件*的报告率分别为40.0%（3级：0%）和27.5%（3级：5%），无4级或5级不良事件。



*特殊关注的不良事件。眼表事件和间质性肺病（ILD）按组别术语报告；*在≥20%的患者中出现的任何级别的治疗中出现的不良事件（TEAEs）；*根据CTCAE v5.0；包括在≥5名患者中出现的≥3级不良事件；§在同一类别中有多个事件的患者，在该类别中仅计算一次。在多个类别中有事件的患者，在每个相关类别中各计算一次。GGT，γ-谷氨酰转氨酶。

❑ Dato-DXd单药治疗在既往接受过铂类药物化疗且病情进展的晚期/转移性卵巢癌和子宫内膜癌患者中显示出令人鼓舞的疗效。

- 在卵巢癌队列中，客观缓解率（ORR）为42.9%，中位持续缓解时间（DoR）为5.7个月（95%CI: 2.9-NC）。
 - ✓ 在对铂类药物敏感的患者中，ORR为66.7%，DoR为8.5个月（95%CI: 2.7-NC）。
 - ✓ 在对铂类药物耐药的患者中，ORR为34.6%，DoR为5.6个月（95%CI: 2.9-NC）。
- 在子宫内膜癌队列中，ORR为27.5%，DoR为16.4个月（95%CI: 7.1-NC）。

❑ Dato-DXd单药治疗的安全性可控，与先前研究的结果一致。

- 少数TEAEs导致停药，没有导致死亡的TEAEs。
- 最常见的TEAEs为口腔炎和恶心，大多数为1/2级。
- 判定与药物相关的ILD发生率低。

芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)在经治进展期子宫内膜癌(EC)和卵巢癌(OC)患者中的安全性和有效性：一项II期研究

Safety and Efficacy of Sacituzumab Tirumotecan (sac-TMT) in Patients (pts) with Previously Treated Advanced Endometrial Carcinoma (EC) and Ovarian Cancer (OC) from a Phase 2 Study

通讯作者：王丹波

研究机构：辽宁省肿瘤医院

研究背景



- Sac-TMT (也称为SKB264/MK-2870) 是一种TROP2 ADC, 由独特的Kthiol (嘧啶硫醇) 连接子与一种新型拓扑异构酶I抑制剂 (KL610023) 偶联, DAR为7.4。
- 本次报告正在进行的KL264-I-01研究 (NCT04152499) 中的II期试验部分, 子宫内膜癌和卵巢癌队列的初步疗效和安全性结果。

ADC, 抗体偶联药物。

研究设计



队列8：晚期EC (N=44)

关键入组标准

- 接受过 ≥ 1 线基于铂类的治疗
- MSI-H/dMMR患者既往需接受过抗PD-1/L1治疗
- ECOG PS为0或1

队列2：晚期OC (N=40)

关键入组标准

- 接受过 ≥ 1 线基于铂类的治疗
- 铂敏感复发患者需接受过 ≥ 2 线基于铂类的治疗
- ECOG PS为0或1

sac-TMT (SKB264/MK-2870)
5 mg/kg, Q2W

直至疾病进展, 出现不可
耐受毒性或撤回知情

肿瘤评估:

- 前12个月每8周一次, 此后每12周一次。

主要研究终点

- 研究者根据RECIST v1.1 评估的ORR

次要研究终点

- PFS, DoR, OS
- 安全性

dMMR, 错配修复缺陷; DoR, 缓解持续时间; EC, 子宫内膜癌; ECOG PS, 美国东部肿瘤协作组体能状态; MSI-H, 微卫星不稳定性; OC, 卵巢癌; ORR, 客观缓解率; OS, 总生存期; PD-1, 程序性细胞死亡蛋白1; PD-L1, 程序性细胞死亡蛋白配体1; PFS, 无进展生存期; pts, 患者; Q2W, 每两周; RECIST, 实体瘤反应评价标准。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04152499>.
2. D. Wang, et al. 2024 ESMO 715MO.

基线特征

EC队列：44例患者入组并随访≥17周。22例（50.0%）患者在数据截止日期仍在服用sac-TMT。中位随访时间为7.2个月

基线数据	EC (N = 44)
中位年龄（范围），岁	58 (40, 73)
ECOG PS, % (n)	
0	31.8 (14)
1	68.2 (30)
组织学类型, % (n)	
子宫内膜样	54.5 (24)
非子宫内膜样	31.8 (14)
癌肉瘤	6.8 (3)
未知/未检测	6.8 (3)
MMR/MSI状态, % (n)	
dMMR/MSI-H	2.3 (1)
pMMR/MSS or MSI-L	70.5 (31)
未知/未检测	27.3 (12)
TROP2 IHC H-score, ^a % (n)	
>200	27.3 (12)
≤200	63.6 (28)
既往接受的系统性治疗线数, % (n)	
1	47.7 (21)
≥2	52.3 (23)
既往接受过免疫治疗, % (n)	
是	36.4 (16)
否	63.6 (28)

OC队列：40例患者入组并随访≥17周。4例（10.0%）患者在数据截止日期仍在服用sac-TMT。中位随访时间为28.2个月

基线数据	OC (N = 40)
中位年龄（范围），岁	57.5 (29, 74)
ECOG PS, % (n)	
0	25.0 (10)
1	75.0 (30)
组织学类型, % (n)	
高级别浆液性	62.5 (25)
非高级别浆液性	20.0 (8)
其他 ^b	17.5 (7)
入组时的对铂类药物的敏感性, % (n)	
铂敏感	12.5 (5)
铂耐药	87.5 (35)
TROP2 IHC H-score, ^a % (n)	
>200	32.5 (13)
≤200	55.0 (22)
既往接受的系统性治疗线数, % (n)	
2	20.0 (8)
>2	80.0 (32)

a. 使用MEDx免疫组化试验评估TROP2的表达情况。EC队列中4名患者和OC队列中5名患者的TROP2表达情况缺失。

b. 子宫内膜样腺癌 (n=2), 粘液腺癌 (n=2), 交界性粘液性囊腺癌 (n=1), 透明细胞癌 (n=2), 子宫内膜样中分化腺癌 (n=1), EC, 子宫内膜癌; ECOG PS, 美国东部肿瘤协作组体能状态; MMR, 错配修复; MSI, 微卫星不稳定性; OC, 卵巢癌; TROP2, 滋养层细胞表面抗原2。

数据截止日期：2024年3月5日。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04152499>.
2. D. Wang, et al. 2024 ESMO 715MO.

初步结果:在EC队列中的有效性

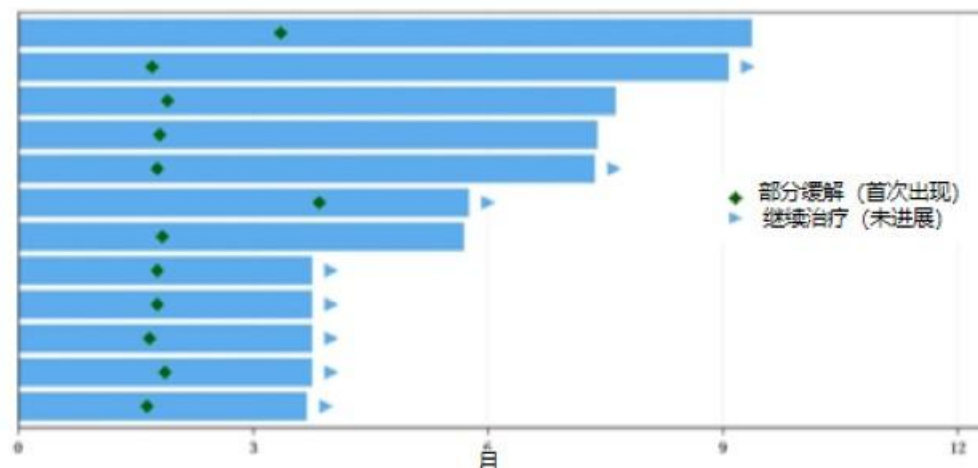


	EC (N = 44) ^a
ORR, % (n/N)	34.1 (15/44) ^b
经过确认的ORR	27.3 (12/44)
亚组	
TROP2 H-score >200	41.7 (5/12)
既往接受过免疫治疗	37.5 (6/16)
DCR, % (n/N)	75.0 (33/44)
PR	34.1 (15/44)
SD	40.9 (18/44)
DoR	
中位数 (范围), 月	5.7 (3.8, 7.4+)
PFS	
中位数 (95% CI), 月	5.7 (3.7, 9.4)

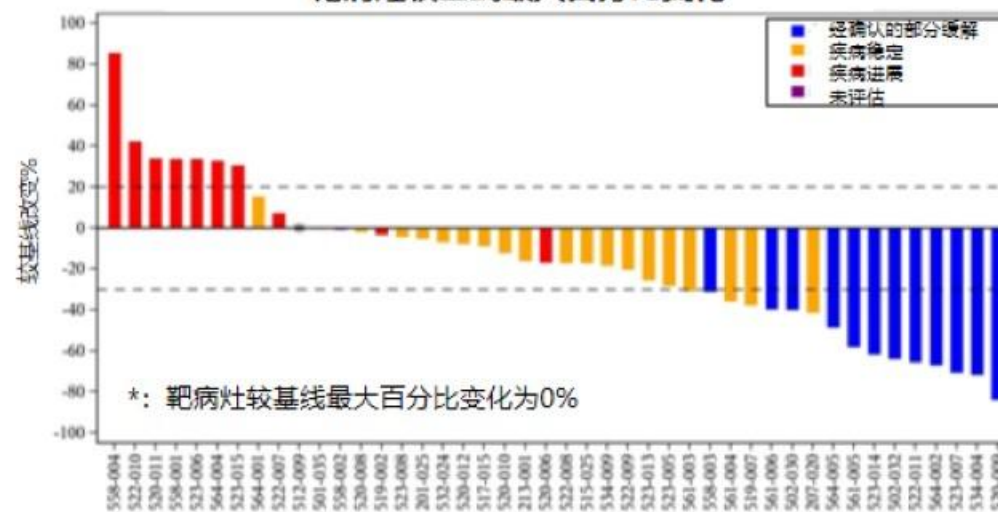
a.研究者根据RECIST v1.1评估的缓解程度。

b.两名缓解程度未确认的患者在数据截止日期仍在接受治疗。

经确认的对治疗响应的患者从随机到缓解的时间以及治疗持续的时间



靶病灶较基线最大百分比变化



- <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04152499>.
- D. Wang, et al. 2024 ESMO 715MO.

CI, 置信区间; DCR, 疾病控制率; DoR, 缓解持续时间; EC, 子宫内膜癌; ORR, 客观缓解率; PFS, 无进展生存期; PR, 部分缓解; RECIST, 实体瘤反应评价标准; SD, 疾病稳定; TROP2, 滋养层细胞表面抗原2。

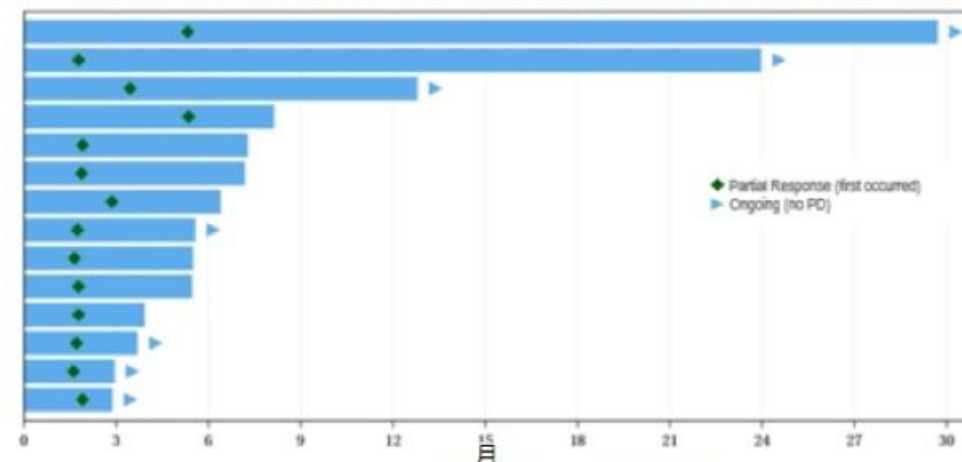
数据截止日期: 2024年3月5日。

初步结果:在OC队列中的有效性

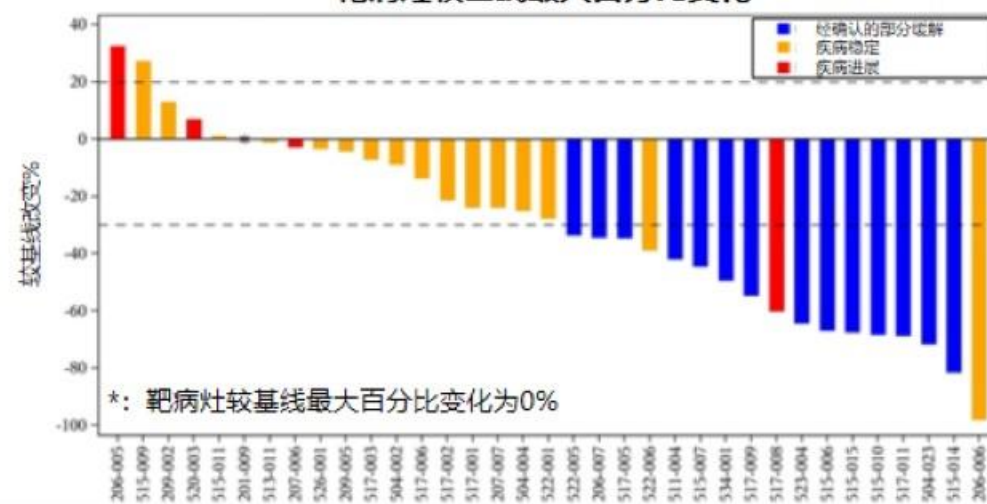
	OC (N = 40) ^a
ORR, % (n/N)	40.0 (16/40)
经过确认的ORR	35.0 (14/40)
亚组	
TROP2 H-score > 200	61.5 (8/13)
铂耐药	37.1 (13/35)
DCR, % (n/N)	75.0 (30/40)
PR	40.0 (16/40)
SD	35.0 (14/40)
DoR	
中位数 (范围), 月	5.3 (2.1, 24.4+)
PFS	
中位数 (95% CI), 月	6.0 (3.9, 7.3)

a.研究者根据RECIST v11评估的缓解程度。

经确认的对治疗响应的患者从随机到缓解的时间以及治疗持续的时间



靶病灶较基线最大百分比变化



*: 靶病灶较基线最大百分比变化为0%

初步结果：安全性（在所有级别AEs中大于等于30%）



% (n)	EC (N = 44) ^a		OC (N = 40) ^a	
TRAEs	100% (44)		100% (40)	
≥ 3级的TRAEs	72.7% (32)		67.5% (27)	
严重的TRAEs	20.5% (9)		37.5% (15)	
导致治疗终止的TRAEs ^b	2.3% (1)		12.5% (5)	
TRAE首选术语	所有等级	≥ 3级 ^c	所有等级	≥ 3级 ^c
贫血	88.6% (39)	29.5% (13)	85.0% (34)	35.0% (14)
白细胞减少	81.8% (36)	40.9% (18)	60.0% (24)	22.5% (9)
中性粒细胞计数减少	65.9% (29)	43.2% (19)	57.5% (23)	30.0% (12)
口腔炎	38.6% (17)	13.6% (6)	57.5% (23)	15.0% (6)
呕吐	36.4% (16)	0	40.0% (16)	0
脱发	34.1% (15)	0	45.0% (18)	0
恶心	27.3% (12)	0	42.5% (17)	2.5% (1)
血小板计数减少	25.0% (11)	6.8% (3)	42.5% (17)	7.5% (3)
皮疹	15.9% (7)	2.3% (1)	32.5% (13)	2.5% (1)

- 最常见的血液学毒性是贫血、白细胞减少和中性粒细胞计数减少。
- 最常见的胃肠道毒性是口腔炎，呕吐和恶心。腹泻在EC和OC队列中的发生率分别为2.3%和10.0%。
- 没有因TRAEs导致的死亡。
- 无药物相关性ILD/肺炎

a. 两个队列均接受了5mg/kg剂量的sac-TMT治疗（Q2W）。
b. 导致治疗终止的TRAEs：EC队列-中性粒细胞计数下降。OC队列（每种AE n=1）：心肌梗死，粘膜炎症，低钾血症，超敏反应和血液学毒性。
c. 其他的发生率≥5%的≥3级的TRAEs：EC队列-无。OC队列-中性粒细胞减少症（10.0%）、不适（5.0%）、粘膜炎症（5.0%）、淀粉酶升高（5.0%）。淋巴细胞计数下降（5.0%）和低钾血症（5.0%）。
EC，子宫内膜癌；ILD，间质性肺炎；OC，卵巢癌；TRAE，治疗相关不良事件；WBC，白细胞。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04152499>.
2. D. Wang, et al. 2024 ESMO 715MO.

研究结论



□ Sac-TMT单药治疗在经治人群中显示出具有潜力的抗肿瘤活性。

-在EC队列中，ORR为34.1%，中位PFS和中位DoR均为5.7个月。

-在OC队列中，ORR为40.0%，中位PFS为6.0个月，中位DoR为5.3个月。

□ 最常见的TRAEs是血液学毒性。Sac-TMT单药治疗显示出可控的安全性。

□ 一项对比Sac-TMT和医生选择的化疗方案治疗EC患者（接受过基于铂类的化疗和免疫治疗）的III期全球研究正在进行中（TroFuse-005, NCT06132958）。

DoR, 缓解持续时间; EC, 子宫内膜癌; OC, 卵巢癌; ORR, 客观缓解率; PFS, 无进展生存期; pts, 患者; TRAE, 治疗相关不良事件。

1. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04152499>.
2. D. Wang, et al. 2024 ESMO 715MO.



2024 BARCELONA

ESMO

谢谢观看
THANK YOU

